

1. Une femme de 28 ans, nullipare, au 15^e jour du cycle menstruel, vous consulte pour des douleurs aiguës de la fosse iliaque droite apparues depuis 48 heures. C'est une constipée chronique mais qui présente depuis 3 jours des diarrhées. La palpation et la détente abdominales sont douloureuses. Elle est subfébrile à 37.5 °C. Un test de grossesse est négatif. La leucocytose est à 11 G/l (norme: 4.5-11). Elle vous consulte car son état clinique s'est aggravé au cours des 6 dernières heures.
Pour envisager une appendicectomie d'urgence on devrait se baser sur
 - a la péjoration clinique actuelle
 - b la leucocytose
 - c une échographie
 - d un CT-scan
 - e une culture des selles
2. Un garçon de 13 ans obèse souffre de douleurs à la hanche depuis 2 mois. A l'examen, on met en évidence une diminution de la rotation interne de la hanche gauche.
Quelle est la cause la plus vraisemblable?
 - a une épiphysiolyse de la tête fémorale
 - b la coxarthrose
 - c une tumeur à cellules géantes
 - d une arthrite tuberculeuse
3. Un garçon de 16 ans, en bonne santé habituelle, présente des douleurs périombilicales intermittentes, tendant à se localiser dans la fosse iliaque droite après quelques heures. La température est à 37.8 °C. La palpation abdominal montre des douleurs de pression et un signe de rebond dans la partie inférieure de l'abdomen.
Quel est le diagnostic de présomption?
 - a une appendicite aiguë
 - b l'ascaridiose
 - c une lithiase urétérale droite
 - d une infection urinaire sur incontinence vésico-urétérale
 - e une gastro-entérite aiguë
4. Chez un patient de 40 ans, l'hémoglobine a chuté de 14 à 10 g/dl (norme: 13.5-17.5) en 4 jours. Vous supposez une hémolyse intravasculaire.
Pour confirmer le diagnostic de suspicion, quel résultat de laboratoire est le plus appropriée?
 - a un fer sérique à 38 µmol/l (norme 9-30 µmol/l)
 - b une lactate déshydrogénase à 480 UI/l (norme 100-190 U/l)
 - c une augmentation de l'urobilinogène urinaire
 - d une hémoglobinurie
 - e un test de Coombs positif
5. Un homme de 72 ans se plaint d'une douleur intense lors de la déglutition qui dure depuis 3 jours. Il n'a ni fièvre ni leucocytose. A l'examen ORL, il présente des lésions sur l'hémi-palais (voir figure).
Quel est le diagnostic le plus vraisemblable?
 - a une angine
 - b un abcès pharyngé
 - c une diphtérie
 - d le zona (Herpes Zoster)
 - e une mycose
6. Lors d'un examen d'entourage d'une famille, effectué à la suite de la découverte d'un cas de tuberculose, un enfant âgé de 7 ans a une réaction à la tuberculine positive, alors qu'il n'a pas reçu le BCG. Sa radiographie thoracique est normale.
Quelle est la mesure la plus appropriée?
 - a entreprendre un traitement à base d'INH (l'isoniazide)
 - b donner une triple association antituberculeuse (INH, éthambutol, rifampicine)
 - c vacciner au BCG (bacille Calmette-Guérin)
 - d faire une radiographie de contrôle dans 6 semaines
 - e ne rien faire
7. Une fille de 10 ans avec un syndrome de Marfan se plaint subitement de douleur lancinante à l'épaule et de difficultés à respirer. Elle est afebrile. A l'auscultation cardiaque, vous remarquez un clic mésosystolique et un souffle téléstolique. La tension artérielle et le pouls sont normaux. A l'auscultation pulmonaire, vous entendez sur l'hémithorax gauche un murmure vésiculaire normal mais nettement diminué. La fréquence respiratoire au repos est à 24/min. La saturation en oxygène par pulsoxymétrie est à 93 %.
Quel est le diagnostic de présomption?
 - a la rupture d'un anévrisme aortique
 - b une pneumonie et une pleurésie gauche
 - c un pneumothorax gauche
 - d une embolie pulmonaire
 - e une atélectasie du poumon gauche
8. Chez un homme de 70 ans, avec une hypertension artérielle asymptomatique de 170/100 mmHg, le médecin traitant palpe une masse abdominale pulsatile. L'examen aux ultrasons met en évidence un anévrisme abdominal aortique en dessous des artères

rénales et mesurant 8 cm de diamètre.

Quelle démarche est la plus adéquate dans cette situation?

- a transfert aux chirurgiens vasculaires
- b le traitement de l'hypertension et un contrôle par ultrasons tous les 3 à 6 mois
- c l'hospitalisation pour régler la tension artérielle
- d un régime pauvre en sel, acide acétylsalicylique per os
- e l'instruction du malade de se présenter d'urgence en cas de douleur abdominale

9. Une toxicomane de 18 ans (héroïne intraveineuse) vous consulte en raison d'une fièvre à 39 °C et d'un abcès à l'avant-bras gauche. A l'exception de l'abcès et de ganglions lymphatiques axillaires agrandis, bien mobilisables, le status ne révèle rien de particulier. Cœur et poumons sont normaux, de même que la radiographie du thorax. L'abcès est incisé. Le pus contient de nombreux coques gram-positifs en grappe et un traitement antibiotique est instauré.

Dans cette situation, quel est le médicament le plus indiqué?

- a la flucloxacilline
- b l'amoxicilline
- c le cotrimoxazole
- d la pénicilline G
- e l'amphotéricine B

10. Une femme âgée de 50 ans vous consulte et montre une lésion réticulaire, blanche et adhérente de la muqueuse buccale.

Quel est le diagnostic le plus probable?

- a une stomatite à Candida
- b un pemphigus vulgaire
- c une leucoplasie nicotinique
- d le lichen plan
- e une dyskératose folliculaire de Darier

11. Un homme de 30 ans est traité depuis 9 mois pour une dépression. L'amélioration de son état vous incite à interrompre le traitement de paroxétine. 3 jours après l'arrêt du traitement, le patient se plaint de sensations vertigineuses, d'anxiété et d'insomnie. Il est agité et fébrile (37.5 °C).

A ce stade, quelle procédure est la plus appropriée?

- a hospitaliser le patient pour investigation
- b reprendre le traitement de paroxétine
- c commencer un traitement avec un autre antidépresseur
- d prescrire une benzodiazépine à longue durée d'action
- e le refroidissement externe et administrer le dantrolène

12. Un homme de 45 ans est traité depuis des années pour une polyarthrite chronique. Il est admis en urgence en raison de douleurs épigastriques et périombilicales d'apparition soudaine. A l'examen d'entrée, l'abdomen est tendu et très douloureux à la pression, bruits intestinaux sont absents. Sa peau est humide et froide. Il a une tension artérielle à 100/60 mmHg, un pouls à 120/min et une température à 37.8 °C.

Quelle est la mesure la plus indiquée?

- a administrer des analgésiques et faire jeûner, réévaluer 6 heures plus tard
- b une angiographie et une fibrinolyse
- c une laparotomie
- d une panendoscopie
- e un transit baryté

13. Un cycliste de 35 ans est mordu à l'avant-bras droit par un renard en zone d'endémie de la rage. Il a reçu un rappel Di-Te 2 ans auparavant et ne se souvient d'aucune autre vaccination. Aux urgences, on constate une plaie par morsure de 3 cm au dos de l'avant-bras. Le pouls, la sensibilité et la motricité sont sans particularité en périphérie.

Quel est le traitement le plus approprié?

- a un débridement et suture de la plaie
- b un débridement de la plaie, laissée ouverte; un rappel anti-tétanique
- c un débridement de la plaie, laissée ouverte; une immunisation anti-rabique active
- d un débridement de la plaie, laissée ouverte; une immunisation anti-rabique active et passive
- e une autre forme de traitement

14. Une veuve de 67 ans est hospitalisée pour investigations d'une baisse de l'état général. Le recueil de l'anamnèse est difficile parce que la patiente déclare ne plus vouloir vivre. Depuis 5 ans, elle est traitée par des patches de nitrés pour une maladie coronarienne et par de l'amiodarone en raison d'une fibrillation auriculaire rapide. Vous vous trouvez en présence d'une patiente cachectique avec un IMC à 17.3 kg/m², un pouls irrégulier à 123/min et une tension artérielle à 118/73 mmHg. L'auscultation cardiaque révèle un B3 et un souffle systolique 2/6 irradiant dans l'aisselle. Vous auscultez des râles de stase aux deux bases pulmonaires. Le reste de l'examen clinique est sans particularités.

Dans l'investigation de cette patiente, la prochaine étape est

- a une évaluation psychiatrique
- b un profil glycémique
- c un dosage de la TSH
- d une échocardiographie
- e une échographie abdominale à la recherche d'une tumeur

15. Depuis 6 mois, une adolescente de 18 ans présente des papules ortiées sur le tégument. Elles ne durent que peu de temps et réapparaissent à d'autres endroits. Les muqueuses sont indemnes.
Quelle est la partie la plus importante de l'investigation?
- a l'anamnèse
 - b le dosage de IgE (dans le sérum)
 - c la formule sanguine
 - d la biopsie cutanée
 - e les tests cutanés
16. Un garçon de 3 ans est emmené chez le pédiatre car il est fébrile à 39 °C depuis 3 jours et présente une raideur du dos. Les constatations marquantes de l'examen clinique sont les suivantes: un pharynx érythémateux, des adénopathies cervicales indolores ainsi qu'une légère raideur de nuque.
Quelle est la prochaine démarche la plus judicieuse?
- a une recherche d'anticorps hétérophiles
 - b une hémoculture
 - c une ponction lombaire
 - d un frottis de gorge et un traitement de pénicilline per os pendant 10 jours
 - e un frottis de gorge, un comptage leucocytaire et un contrôle clinique 24 heures plus tard
17. Un patient de 19 ans se plaint d'une toux non productive depuis deux jours. Chaque accès de toux s'accompagne de violentes douleurs rétrosternales. Le médecin traitant suppose une trachéo-bronchite.
De quel médicament le patient bénéficiera-t-il le plus?
- a de la codéine
 - b de l'amoxicilline
 - c de la guaifénésine
 - d de la N-acétylcystéine
 - e de la clarithromycine
18. Un homme de 76 ans est conduit en ambulance aux urgences en raison de vertiges ne lui permettant plus de se lever. Il a chuté plusieurs fois à domicile durant les 2 derniers jours. L'anamnèse personnelle révèle une hypertension artérielle mal équilibrée, motivant l'adjonction d'un diurétique (le torasémide 10 mg/j) au traitement de base d'antagoniste du calcium (l'amlodipine 10 mg/j) et d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion (le ramipril 10 mg/j). L'examen des nerfs crâniens est normal, il n'y a pas de nystagmus et le réflexe cutané plantaire est en flexion. Le bilan biologique se présente comme suit:
la créatinine 135 µmol/l (norme: <115)
l'urée 23.2 mmol/l (norme: 3.6-7.1)
la créatine kinase 535 U/l (norme: 60-170)
la troponine T <0.01 mg/l (norme: <0.01)
Quel examen complémentaire conduit le plus vraisemblablement au diagnostic?
- a une électroystagmographie
 - b une épreuve calorique vestibulaire
 - c un test table basculante (tilt-table)
 - d une IRM cérébrale
 - e un test de Schellong
19. 6 mois après avoir été opérée d'une prothèse de la hanche droite, alors que tout allait bien, une femme de 72 ans se plaint d'une douleur de cette hanche, apparue il y a 2 semaines sans traumatisme. Vous constatez une température à 37.9 °C, une hanche douloureuse à la mobilisation. La CRP est à 20 mg/l (norme: <<10), la vitesse de sédimentation à 35 mm/h (norme: <<25). Le compte leucocytaire est dans la norme.
Quel est le procédé le plus adéquat?
- a une antibiothérapie et le contact avec l'orthopédiste traitant
 - b un bilan radiologique, des AINS puis un contrôle clinique dans une semaine
 - c une scintigraphie osseuse
 - d une ponction de hanche et une bactériologie
 - e une IRM
20. Un adolescent de 18 ans souffre depuis 4 ans de douleurs dorsales intermittentes. A l'examen, on met en évidence une cyphose du rachis dorsal.
Quel diagnostic est le plus probable?
- a une spondylose déformante
 - b une spondylite tuberculeuse
 - c la maladie de Scheuermann
 - d un hémangiome vertébral
 - e une cyphoscoliose idiopathique
21. Une femme de 29 ans ressentait pendant 3 jours des picotements et de légères douleurs dans son membre supérieur droit. Elle voyait apparaître le long de ce même membre des altérations cutanées circonscrites avec des vésicules sur fond rouge. L'anamnèse ne révèle ni indice en faveur d'une atonie ni prise de médicament.
Laquelle des dermatoses est la plus probable?
- a une dermatite herpétiforme de Duhring
 - b un eczéma herpétique (Kaposi-Juliusberg)
 - c un érythème polymorphe

- d un herpès simplex
- e le zona (Herpes zoster)

22. Une fille de 12 ans développe un état fébrile et un exanthème maculeux partiellement hémorragique. Par la suite apparaissent une macrohématurie, un méléna et des douleurs articulaires intenses.

Quel est le diagnostic le plus probable?

- a une périartérite noueuse
- b un lupus érythémateux
- c un purpura thrombopénique idiopathique
- d un purpura de Schönlein-Henoch
- e une glomérulonéphrite

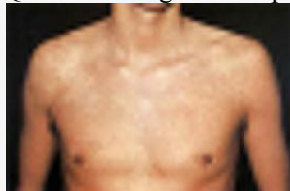
23. Un homme de 46 ans, opéré d'une appendicite aiguë, présente au 6e jour post-opératoire un état fébrile alors que sa plaie opératoire est sans signe inflammatoire.

Quel examen faut-il faire en premier lieu?

- a une radiographie de l'abdomen à vide
- b une culture des selles
- c une culture des urines
- d un toucher rectal
- e une radiographie du thorax

24. Un homme de 20 ans remarque, après une exposition solaire en été, des macules blanc-brunâtre sur la partie supérieure du thorax (voir figure). Ces taches claires montrent une fine desquamation après grattage avec une spatule.

Quel est le diagnostic le plus probable?



- a un érythrasma
- b un pityriasis alba simplex
- c un pityriasis versicolor
- d un leucoderme psoriasique
- e un vitiligo

25. Une femme de 57 ans, présentant une surcharge pondérale et souffrant depuis des années d'un diabète de type 2, est amenée comateuse à l'hôpital. Anamnestiquement, on apprend que le jour précédent elle s'est plainte de vertiges rotationnels sévères, quelques heures plus tard d'insécurité à la marche et pendant la nuit de céphalées allant en augmentant. Elle a vomi à plusieurs reprises et est devenue somnolente 6 heures plus tard.

Quel est le diagnostic le plus vraisemblable?

- a une gastro-entérite sévère
- b un coma diabétique
- c un coma hypoglycémique
- d une hémorragie ou un infarctus du cervelet
- e la maladie de Menière

26. Une femme de 65 ans présente une gonarthrose à droite évoluant depuis plus d'une année. Elle est limitée dans ses déplacements et parfois gênée la nuit par des douleurs après efforts. Son médecin rhumatologue procède à l'injection intraarticulaire d'un corticoïde à longue durée d'action au niveau de genou droit.

Que peut-on attendre de ce traitement?

- a un effet positif sur la symptomatologie et un ralentissement de l'évolution de la maladie
- b un ralentissement de l'évolution de la maladie sans effet notable sur la symptomatologie
- c une diminution temporaire des douleurs mécaniques, au risque d'accélérer l'évolution de l'atteinte dégénérative
- d une régression des signes radiologiques d'arthrose: pincement, ostéophytes, sclérose sous-chondrale
- e un effet stimulant sur la régénérescence du cartilage

27. En taillant une branche d'arbre avec son couteau de poche, un garçon de 12 ans s'entaille la face palmaire de l'index en regard de la première phalange. Il consulte un chirurgien pour qui l'examen de la sensibilité pulpaire se révèle normale. Toutefois, si la flexion active de la première phalange est possible, le patient ne peut fléchir ni la deuxième ni la troisième phalange.

Il s'agit d'une section

- a des tendons des muscles interosseux
- b des tendons des muscles lombricaux
- c du tendon fléchisseur superficiel
- d du tendon fléchisseur profond
- e des tendons fléchisseurs superficiel et profond

28. Une femme de 36 ans a présenté 3 grossesses antérieures dont l'une s'est terminée par une césarienne. L'évolution de la grossesse actuelle a été sans particularité. La patiente présente un status variqueux important au niveau des membres inférieurs. A la 39^e semaine de gestation, on procède à un enregistrement cardiotocographique en décubitus dorsal en raison d'une suspicion de début de travail. 5 minutes après le début de cet enregistrement, la patiente se plaint de malaise, palpitations cardiaques et sentiment de vertiges. Les pulsations cardiaques sont de 120/min et la pression artérielle de 90/70 mmHg. La fréquence cardiaque fœtale montre

une bradycardie d'une durée de 3 minutes.

Quel diagnostic est le plus probable?

- a la rupture utérine
- b l'embolie pulmonaire
- c le syndrome de compression de la veine cave inférieure**
- d le décollement du placenta
- e la pré-éclampsie

29. Après la délivrance, la face maternelle du placenta présente une érosion localisée avec du sang. Le placenta paraît toutefois complet car il ne manque aucun cotylédon. L'utérus est mal contracté. On observe encore un léger écoulement de sang par le vagin 15 minutes après l'accouchement. Les pertes de sang jusqu'au moment présent s'élèvent à environ 800 ml.

Quelle mesure est à prendre?

- a faire une révision de la cavité sous narcose
- b administrer une transfusion sanguine
- c administrer une perfusion rapide d'ocytocine
- d cureter sous narcose
- e attendre et ne rien faire pour le moment

30. Chez un homme de 72 ans, le médecin traitant découvre une anémie ferriprive avec du sang occulte dans les selles. Dans l'anamnèse, il n'y a aucune notion de méléna ou d'hématémèse. Le malade ne se plaint pas de douleurs abdominales, ni d'une modification de ses habitudes de défécation.

Quelle est la source d'hémorragie la plus probable?

- a un carcinome oesophagien
- b un ulcère duodénal
- c un carcinome du côlon ascendant
- d un carcinome du rectum
- e des hémorroïdes internes

31. Pendant un match de tennis, un fumeur de 47 ans a subi un traumatisme oculaire et a été hospitalisé. Le CT (cerveau, crâne) a été normal. 36 heures plus tard, peu avant de quitter l'hôpital, le patient devient anxieux et tremblant, tachycarde et nauséux. La tension artérielle monte légèrement. L'homme développe des hallucinations tactiles.

Ce tableau clinique est le plus probablement causé par

- a un syndrome de sevrage d'alcool
- b un syndrome de sevrage d'héroïne
- c un syndrome de sevrage de nicotine
- d une réaction allergique
- e un hématome sous-dural

32. Quelques semaines après avoir excisé un naevus naevo-cellulaire on voit apparaître à l'endroit de l'excision un bourrelet rouge, ferme, prurigineux qui s'agrandit continuellement et se prolonge vers les points de suture (voir figure).

Laquelle des affirmations suivantes est correcte?



- a L'altération cutanée décrite s'observe presque exclusivement chez des individus des races à peau claire.
- b L'altération cutanée décrite est plus fréquente chez les adultes que chez les enfants.**
- c Les jambes, les avant-bras et les faces dorsales des mains sont les endroits du corps les plus souvent atteints.
- d Une régression spontanée est possible.
- e Un traitement local avec des corticostéroïdes est contre-indiqué.

33. Un adolescent âgé de 16 ans présente depuis quelques semaines un larmolement de l'oeil droit. Il s'y ajoute maintenant une tuméfaction douloureuse et très rouge de l'angle interne des paupières (voir figure).



Quel est le diagnostic le plus probable?

- a un empyème du sinus maxillaire

- b une mucocèle du sinus frontal
- c une dacryocystite aiguë
- d un dermoïde palpébral
- e un lymphome orbitaire

34. Un couple a un garçon unique avec une neurofibromatose de Recklinghausen (type 1), affection transmise selon le mode autosomal dominant. Les parents sont sains, ne sont porteurs d'aucune "tache café-au-lait" et ne sont pas consanguins.

Quel est le risque qu'un autre enfant de ce couple ait aussi une neurofibromatose de Recklinghausen?

- a minime, comme pour la population en général
- b 25%
- c 50%
- d 50 %, si c'est un garçon, pas élevé, si c'est une fille
- e 100%

35. A quelle maladie cutanée correspondent les lésions du visage illustrées (voir figure) ?



- a un eczéma de contact aux résines époxydes
- b un érysipèle
- c un lupus érythémateux
- d un lymphome
- e une rosacée

36. Un agriculteur de 42 ans est amené aux urgences en raison d'une dyspnée qui est apparue après avoir rempli la remorque-citerne avec un produit phytosanitaire. Il se trouvait à ce moment dans un local fermé et le moteur de son tracteur tournait. Sa pression artérielle est de 100/60 mmHg, son pouls de 50/min. Ses pupilles sont d'un diamètre moyen. Une salivation importante est particulièrement frappante.

Quelle est la mesure la plus appropriée contre l'intoxication supposée?

- a la physostigmine
- b l'atropine
- c le naloxone
- d le flumazénil
- e l'oxygène 100 % au masque

37. 5 jours après une résection gastrique, un patient de 67 ans sans problème cardiaque se plaint de dyspnée. Sa température est de 38.5 °C. La radiographie du thorax montre un diaphragme élevé, un effacement du cul-de-sac diaphragmatique et un pneumo-bronchogramme.

Quel est le diagnostic le plus probable?

- a une pneumonie postopératoire due à une hypoventilation liée à l'état algique
- b une atélectasie de compression suite à un épanchement pleural car le diaphragme a été traumatisé par les écarteurs lors de la résection gastrique
- c un oedème pulmonaire aigu typique, qui doit être traité par restriction de l'apport liquidien et par l'administration de diurétiques à haute dose
- d une élévation diaphragmatique qui est caractéristique d'un abcès sous-phrénique consécutif au lâchage de l'anastomose
- e une rupture en deux temps de la rate après lésion peropératoire méconnue

38. Vous suivez une femme de 62 ans, qui a eu une hémicolectomie droite pour un carcinome colique stade pT3N1M0G3, 3 mois auparavant. Elle montre une augmentation du CEA (antigène carcino-embryonnaire) et une lésion focale solitaire du segment IV du foie (biopsie percutanée: adénocarcinome). La fonction hépatique de la patiente est normale et aucune autre maladie n'est connue. Le bilan d'extension comprenant un CT-scan thoraco-abdominal s'avère négatif pour d'autres lésions, hormis la lésion hépatique décrite.

Quel est le traitement ultérieur correct?

- a l'implantation d'un cathéter artériel dans l'artère hépatique commune pour la chimiothérapie
- b l'immunothérapie associée à une chimiothérapie
- c la chimiothérapie systémique uniquement
- d la radiothérapie percutanée
- e la résection partielle du foie

39. Un avocat de 63 ans vous consulte pour une faiblesse progressive des deux jambes depuis quelques jours. Il y a 3 semaines, il a souffert d'une diarrhée fébrile. A l'examen, on trouve une force et un tonus musculaire diminués, mais une sensibilité cutanée conservée. Les réflexes musculaires sont absents. Les nerfs crâniens et les membres supérieurs sont sans particularité.

Quel examen confirmera le diagnostic qu'il-faut suspecter?

- a une ponction lombaire
- b une IRM de la colonne lombaire
- c une électromyographie
- d un dosage de la glycémie
- e un dosage de la vitamine B₁₂ sérique

40. Vous désirez déterminer l'efficacité de la prescription d'un médicament anti-dépresseur au cours des premières semaines suivant une cure de désaccoutumance au tabac.
Quel plan d'étude faut-il choisir de préférence?
- a une étude de cohorte
 - b une étude cas-témoins
 - c une étude transversale
 - d une étude contrôlée randomisée
 - e une étude écologique
41. Un nourrisson de 9 mois a un périmètre crânien en dessous du 3e percentile. Le poids et la taille à la naissance aussi bien qu'à 9 mois se trouvent entre le 25^e et le 50^e percentile.
Qu'est-ce qui **n'est pas** la cause de cette microcéphalie?
- a une malnutrition
 - b le contexte social
 - c une rubéole congénitale
 - d une embryopathie alcoolique
 - e une gestose gravidique
42. Une mère emmène sa fille, âgée de 2 ans, pour le contrôle annuel. A la naissance à terme, elle présentait un poids de 2010 g (1 paquet de cigarettes/jour) et consomme régulièrement de l'alcool (5 à 6 bières et 750 ml de vin rouge chaque jour). Son papa aussi. A l'examen, le pédiatre est frappée par un nez court, un philtrum allongé, des lèvres très fines et une petite bouche. La fille est très craintive, évite le regard du médecin et ne parle pas. Elle pèse 9 kg (- 3 DS) pour une taille de 72 cm (- 3 DS) et un périmètre crânien de 43 cm (- 3 DS). Selon sa maman, elle dit 2 mots: papa, mama, ne s'intéresse pas aux livres ni aux dessins, et met systématiquement tous les objets qui lui sont présentés à la bouche.
Quelle affirmation est **fausse** concernant cette fille?
- a Elle est probablement une enfant maltraitée.
 - b Elle présente un retard staturo-pondéral
 - c Elle présente probablement des problèmes en relation avec l'alcoolisme maternel.
 - d Elle présente un retard du développement mental
 - e Elle est une enfant à risque de présenter aussi à l'avenir des problèmes développementaux liés à un environnement peu stimulant.
43. Le médecin traitant d'une femme de 72 ans ayant diagnostiqué chez elle une cataracte mature. Dans son âge avancé elle ne veut pas une opération.
Qu'est-ce qui fait partie des complications éventuelles concernant cette décision?
- +/- a une kératite
 - +/- b une dégénérescence maculaire
 - +/- c un décollement de la rétine
 - +/- d une uveite
44. Une employée âgée de 34 ans, qui remplit des ampoules pharmaceutiques, se présente à votre consultation de médecine du travail en raison de plaintes liées à son milieu de travail. Sur la base de l'anamnèse, vous décidez de visiter la place de travail.
Qu'est-ce qui fait partie des éléments qu'il faut évaluer?
- +/- a la fréquence des mouvements
 - +/- b la force à exercer
 - +/- c l'éclairage de la place de travail
 - +/- d le système d'évaluation des performances
45. Comparé à un groupe d'âge plus jeune, qu'est-ce qui est plus fréquent chez les personnes de plus de 65 ans en Suisse?
- +/- a la dépression
 - +/- b le suicide
 - +/- c la migraine
 - +/- d la fibrillation auriculaire
46. Au cours du dernier mois dans un village, les valeurs limites d'immission de l'ordonnance sur la pollution de l'air des particules de poussières volatiles fines ont été dépassées nettement au cours de onze journées.
Qu'est-ce qui fait partie des conséquences pour la santé des villageois?
- +/- a des atteintes respiratoires aiguës chez l'enfant
 - +/- b l'augmentation de la durée des épisodes d'atteintes des voies respiratoires
 - +/- c le risque accru d'avortement spontané chez les femmes enceintes
 - +/- d des problèmes cardio-vasculaires chez les personnes âgées
47. Dans une étude cas-témoins conduite chez des adultes âgés de 40 à 50 ans, les résultats montrent que les patients souffrant d'une maladie rénale ont, de façon statistiquement significative, plus fréquemment une hypertension que les témoins. On en conclut qu'une hypertension peut conduire à une maladie rénale.
Qu'est-ce qui fait partie des critères de causalité que remplit cette étude?

- +/- a l'association statistique
- +/- b la plausibilité biologique
- +/- c la séquence temporelle
- +/- d la relation dose-réponse

48. Une femme de 50 ans, en bonne santé jusqu'alors, se plaint de douleurs lombaires basses irradiant dans la face postérieure de la cuisse gauche, le bord latéral de la jambe et le gros orteil. Elle présente depuis quelques jours un pied tombant à la marche et boite en raison d'une faiblesse de la hanche. Depuis 12 heures, elle présente de surcroît une rétention urinaire et des troubles de la sensibilité péri-anale.

Jugez du bien-fondé des réflexions suivantes:

- +/- a Une compression de la queue de cheval est vraisemblable chez cette patiente.
- +/- b Un syndrome de compression de la queue de cheval représente une indication absolue à une opération d'urgence
- +/- c Cette patiente doit être adressée sans délai à un neurochirurgien.
- +/- d Sur la base des renseignements anamnestiques, il faut suspecter une lésion de la racine S1 à gauche

49. Une femme obèse de 78 ans, jusqu'alors en bonne santé, se plaint subitement de crampes abdominales et de vomissements. La patiente est afebrile. L'abdomen est modérément douloureux à la palpation, non péritonitique et ballonné. On suspecte une douleur locale à la palpation de la région inguinale droite. L'auscultation révèle des bruits intestinaux discrètement augmentés. La prise de sang montre une leucocytose à 13 G/l (norme: 4.5-11) ainsi qu'une élévation de la CRP à 20 mg/l (norme: <<10). La radiographie d'abdomen montre une image précoce d'iléus du grêle.

Ce tableau clinique évoque en premier lieu

- a une invagination
- b une colique néphrétique
- c une appendicite aiguë rétrocécale
- d **une hernie fémorale étranglée**
- e un volvulus

Le tableau clinique de cette patiente de 78 ans présente des éléments clés indiquant une obstruction intestinale, tels que les crampes abdominales, les vomissements, l'abdomen ballonné et les bruits intestinaux augmentés. L'image radiologique confirme un iléus du grêle. De plus, la douleur locale à la palpation de la région inguinale droite suggère une hernie. L'élévation de la leucocytose et de la CRP indique une réaction inflammatoire ou infectieuse. La combinaison de ces symptômes oriente vers une hernie étranglée comme cause principale. **Hernie fémorale étranglée** est le diagnostic le plus probable car :

- La douleur à la palpation de la région inguinale droite.
- L'obstruction intestinale confirmée par radiographie.
- Symptômes systémiques (leucocytose et élévation de la CRP).

Les autres options sont moins probables:

- **Invagination**: Plus fréquente chez les enfants et présente généralement avec des selles en "gelée de groseille", non mentionnées ici.
- **Colique néphrétique**: Douleur habituellement localisée au flanc irradiant vers l'aîne, souvent avec hématurie.
- **Appendicite aiguë rétrocécale**: Moins probable sans fièvre, et l'appendice est rarement palpable en inguinal.
- **Volvulus**: Symptômes plus sévères de distension abdominale et de douleur aiguë généralisée, souvent sans localisation inguinale.

50. Les résultats d'une étude de cohorte chez les médecins britanniques portant sur l'association entre le tabagisme et le cancer du poumon sont publiés. Sur 100'000 personnes-années d'observation, on dénombra 81 décès par cancer du poumon chez les fumeurs et 7 chez les non-fumeurs. Sur la base de ces observations, il est permis de conclure que 74 décès par cancer du poumon sur 100'000 personnes-années chez les médecins fumeurs sont liés à la consommation de tabac.

Il s'agit là d'un exemple de:

- a risque relatif (RR)
- b risque attribuable (RA)
- c Odds ratio (OR)
- d taux standardisé de mortalité (TSM)
- e risque attribuable populationnel (RAP)

51. Une femme de 58 ans, atteinte d'une sténose mitrale et d'une fibrillation auriculaire, se plaint subitement de douleurs violentes dans le membre inférieur gauche qui devient pâle et froid. Du côté gauche, aucune des artères (fémorale, poplitée et pédieuse) n'est palpable, alors qu'elles le sont toutes du côté droit.

Quelle mesure d'urgence devrait être effectuée?

- a la fibrinolyse
- b l'embolectomie
- c l'endartérectomie
- d l'administration d'héparine
- e l'administration d'anticoagulants par voie orale

52. Une femme de 60 ans a présenté à plusieurs reprises des épisodes de brouillard visuel avec simultanément perception d'anneaux colorés, rougeur et douleurs oculaires.

A quel diagnostic faut-il penser en premier?

- a des accès de migraine ophtalmique
- b des poussées d'iridocyclite
- c des épisodes d'ischémie rétinienne par spasme artériel
- d des poussées subaiguës de glaucome par fermeture de l'angle irido-cornéen
- e un glaucome chronique à angle ouvert

53. Une petite fille de 2 ans est emmenée aux urgences au début du mois de décembre à 6 heures du matin en raison de quintes de toux violentes. La toux a débuté subitement l'après-midi précédent alors qu'elle jouait avec son grand frère. Elle a violemment toussé toute la nuit, n'a pas dormi et a présenté de temps en temps des bruits sibilants durant l'inspiration. La fille est afebrile et refuse de se coucher. A l'auscultation pulmonaire, vous trouvez un murmure vésiculaire sur toutes les plages pulmonaires. La radiographie du thorax montre une ventilation symétrique des poumons.

Quelle est la prochaine mesure diagnostique?

- a un bilan allergique
- b une bronchoscopie
- c une formule sanguine
- d une gazométrie sanguine
- e une hémoculture

54. L'illustration ci-jointe montre des lésions cutanées observées chez un garçon de 6 mois, par ailleurs sans particularité. Elles ont été observées au cours de la 3^e semaine de vie et elles sont devenues plus grandes depuis lors, ce qui inquiète fortement les parents. L'altération cutanée est à peine dépressible, de consistance élastique avec une surface lisse.

Quelle procédure est nécessaire dans ce cas?



- a une biopsie cutanée
- b une IRM du crâne
- c une radiothérapie pour limiter la profondeur de l'invasion
- d un traitement au Laser
- e aucune en ce moment

55. Un homme de 75 ans se plaint de douleurs sourdes dans l'hémiabdomen droit, accompagnées d'une perte pondérale importante dans les 3 mois précédents. Une anémie fériprive accompagne ce tableau. Quelle est la démarche diagnostique la plus utile?
- a un examen des selles
 - b une radiographie de l'abdomen à vide debout
 - c un CT-scan abdominal
 - d un angiographie coeliaque
 - e une coloscopie
56. Une jeune femme de 18 ans arrive à l'hôpital avec comme plainte principale des nausées, des vomissements, une polyurie et une polydipsie d'apparition récente. Un diagnostic d'acidocétose d'un diabète inaugural est posé et un traitement de soluté isotonique, d'insuline et de potassium est administré. La glycémie, qui à l'admission était de 25 mmol/l, descend progressivement et est à 4 mmol/l (norme: >7) 12 heures après l'admission. Quelle mesure est indiquée à ce stade?
- a arrêter l'insuline
 - b arrêter l'insuline et commencer une perfusion de glucose
 - c diminuer l'insuline
 - d diminuer l'insuline et commencer une perfusion de glucose
 - e continuer le même traitement
57. A la suite de collisions en série sur l'autoroute, vous êtes engagé comme médecin de triage. Une première appréciation de 4 patients vous permet de constater:
- patient no 1: un homme d'environ 70 ans, profondément comateux, avec des pupilles dilatées et à peine réagissantes des deux côtés, des contusions multiples du tronc, a été couché de côté par des auxiliaires.
 - patiente no 2: une femme d'environ 30 ans, avec de multiples contusions, des douleurs thoraciques latéro-dorsales gauches respiro-dépendantes, des douleurs abdominales diffuses à la pression, pouls à 110/min, périphérie légèrement froide.
 - patient no 3: un garçon d'environ 12 ans, conscient, pleure et crie, une plaie hémorragique du cuir chevelu, éventuelle fracture non disloquée de la jambe droite, ainsi que des contusions de toute la partie droite du corps, pouls à 100/min, bien réchauffé.
 - patient no 4: un homme d'environ 50 ans, amnésique, somnolent et difficilement réveillable, pupilles égales, présence de douleurs importantes spontanées ainsi qu'aux mouvements du genou gauche, plaie légèrement hémorragique au niveau de la tête tibiale, pouls 80/min, pupilles égales.
- La première ambulance avec deux places couchées arrive. Quels patients ont la priorité de transport?
- a patient no 1 + 2
 - b patient no 1 + 4
 - c patient no 2 + 3
 - d patient no 2 + 4
 - e patient no 3 + 4
58. Un garçon de 7 mois qui s'est toujours bien porté semble avoir mal au ventre par épisodes depuis 24 heures. Durant ces crises qui durent une demi-heure, il crie et devient pâle. Il a vomi une fois et il refuse de manger. Il a une température de 37.7 °C. Quand vous l'examinez, il dort et son abdomen est souple. Quel est l'examen le plus sensible pour le diagnostic?
- a une radiographie de l'abdomen à vide
 - b une échographie abdominale
 - c un lavement avec produit de contraste
 - d un transit suivi
 - e une gastroscopie
59. Un patient de 35 ans en bonne santé habituelle doit subir une cure de hernie inguinale droite sous rachianesthésie. Parmi ces propositions, quel accès veineux est le plus adéquat pour mettre en place une perfusion?
- a un Venflon® sur le dos de la main
 - b un Venflon® dans le pli du coude

- c un Venflon® sur le dos du pied
 - d une voie veineuse centrale dans la jugulaire interne
 - e Un accès veineux n'est pas nécessaire.
60. Un fils d'un agriculteur âgé de 9 ans et 3 mois est amené aux urgences par sa mère inquiète, car il ne bouge plus la partie gauche de son visage depuis qu'il s'est levé le matin. La mère raconte spontanément que lui et son frère aîné ont eu à plusieurs reprises des piqûres de tiques. Au status, vous trouvez un garçon afébril, dont l'état général est légèrement diminué et une paralysie faciale gauche manifeste, ainsi qu'une très discrète parésie de l'abduction de l'oeil gauche. Il a de douleurs occipitales et à la nuque qui l'empêchent de tourner complètement la tête vers la droite. Lorsque vous la questionnez plus avant, la maman répond qu'il se plaint déjà depuis quelques semaines de temps en temps de céphalées et de douleurs à la nuque et qu'il a également vomi à quelques reprises. Malgré cela, il a fréquenté l'école et joue normalement, raison pour laquelle la maman n'y a pas trop accordé d'importance. Quelle est la première mesure à prendre?
- a donner rendez-vous dans 3 à 4 jours pour contrôler la parésie faciale
 - b pratiquer une imagerie cérébrale
 - c pratiquer une sérologie pour la borreliose
 - d pratiquer une ponction lombaire
 - e prescrire un analgésique
61. Depuis deux ans, un homme de 74 ans présente une arythmie complète sur fibrillation auriculaire avec une fréquence ventriculaire moyenne de 72/min. Il ne se plaint ni d'oppression thoracique ni d'essoufflement et il n'a pas d'œdèmes malléolaires. Sa tension artérielle est normale et il ne prend aucun médicament. Quelle mesure thérapeutique est indiquée?
- a un bêtabloquant
 - b un dérivé de la coumarine
 - c la digoxin
 - d l'agrégation plaquettaire avec de l'Aspirine®
 - e l'électrocardioversion
62. Une femme de 68 ans (165 cm, 50 kg) se plaint à son médecin de famille d'une faiblesse grandissante, de nervosité, de troubles du sommeil et d'inquiétude marquée depuis 2 semaines. En outre, elle a perdu 3 kg et elle a eu des épisodes répétés de palpitation et de dyspnée. Lors du complément d'anamnèse, elle dit également transpirer davantage. A l'examen clinique, le médecin trouve une tachycardie, une alopécie et un élargissement de la zone réflexe. Suite à son diagnostic de suspicion il entreprend des investigations complémentaires. En attendant les résultats de ces investigations, il faut prescrire à la patiente du
- a propylthiouracil
 - b diazépam
 - c propranolol
 - d carbimazol
 - e diltiazem
63. Un toxicomane HIV-positif de 35 ans vous consulte pour une tuméfaction latéro-cervicale non-douloureuse. Vous constatez une tuméfaction érythémateuse de 4 cm de diamètre, dont la palpation est peu douloureuse mais fluctuante. Quel est le diagnostic le plus probable?
- a un kyste thyroïdien
 - b un kyste branchiogène
 - c une lymphadénite abcédée sur Candida
 - d un lymphome malin
 - e une tuberculose ganglionnaire
64. Un homme de 20 ans, jusque-là en bonne santé, se présente aux urgences après une party. Il est confus et hallucine. Les pupilles sont dilatées et le pouls est rapide. Sa peau est sèche et chaude. Il a une pression artérielle normale. Il s'agit probablement d'une intoxication aiguë par
- a les alcaloïdes de la belladone
 - b l'alcool
 - c la cocaïne
 - d l'héroïne
 - e des organophosphorés
65. Un homme de 46 ans, qui souffre depuis 20 ans d'un diabète insulino-dépendant, se plaint de faiblesse et de vertiges matinaux au moment de se lever. Depuis quelques semaines, il a des diarrhées répétitives. Quelle est la cause la plus probable des accès de vertiges?
- a des hypoglycémies
 - b des hyperglycémies matinales
 - c une hypotension orthostatique
 - d une otosclérose
 - e des tachycardies supraventriculaires
66. Une femme de 33 ans se plaint d'une leucorrhée abondante depuis 4 jours, de douleurs abdominales basses et d'un état fébrile autour de 38 °C. Vous suspectez une infection génitale. Lequel des micro-organismes suivants faut-il rechercher en priorité?
- a le Candida albicans
 - b la Gardnerella vaginalis

- c la Chlamydia
 - d le virus d'herpès type II
 - e les bactéroïdes fragilis
67. 12 jours après son retour de vacances au maroc, un homme de 25 ans présente une température élevée, des frissons et des céphalées. Il est d'abord atteint de diarrhées, puis de constipation opiniâtre. La rate est palpable. La température est de 39.8 °C et le pouls à 72/min. Les leucocytes sont à 5.2 G/l (norme: 4.5-11), l'hémoglobine est à 13.5 g/dl (norme: 13.5-17.5). Quel est le diagnostic le plus probable?
- a la leptospirose
 - b l'amibiase
 - c une fièvre typhoïde
 - d la malaria
 - e une entérite à staphylocoques
68. La direction d'une entreprise s'adresse à un médecin du travail parce que les employés ont évidemment des problèmes de santé à cause de l'utilisation de peintures à base de solvants. Quelle proposition du médecin est la meilleure?
- a choisir une peinture à deux composants
 - b choisir une peinture à base d'eau
 - c préférer l'enduit de chaux (badigeon blanc)
 - d confier à faire les travaux à une entreprise de sous-traitance
 - e maintenir le status quo
69. Une femme de 32 ans présente autour de la bouche une éruption qui se manifeste par de petites papules et des papulo-pustules sur fond érythémateux. Après un traitement de plusieurs semaines et poussés récidivantes, le valérate de bêtaméthasone apaise la lésion. Après la cessation de la thérapie, une récurrence survient. Quel est le diagnostic le plus vraisemblable?
- a un eczéma de contact
 - b une dermatite péri-orale
 - c une folliculite gram-négative
 - d une ostiofolliculite à staphylocoques
 - e une dermatite séborrhéique
70. Une femme de 34 ans, Rhésus négative présente à la 16e semaine de grossesse un titre d'anti-D de 1:128 (positif à partir de 1:16). Dans le cadre d'un premier mariage elle avait eu 3 grossesses (2 fausses-couches spontanées et un accouchement à terme). Son premier enfant avait subi deux fois une exsanguino-transfusion pour hyperbilirubinémie peu après la naissance. Quelle mesure est indiquée?
- a l'interruption de la grossesse
 - b un doppler de l'artère cérébrale moyenne fœtale
 - c la détermination du groupe Rhésus du père de l'enfant
 - d l'administration d'anti-D
 - e aucune des mesures citées
71. Un homme de 37 ans est victime d'une collision frontale. Il est au volant et souffre de fractures de côtes en série à gauche, d'une rupture de la rate et d'une fracture ouverte du 2^e degré du fémur. Après intubation primaire et ventilation, on traite l'hémorragie de la rate avec conservation de cette dernière et la fracture du fémur par ostéosynthèse. Quelle est la complication la plus redoutable lors du séjour ultérieur aux soins intensifs?
- a la récurrence de l'hémorragie abdominale
 - b le syndrome de détresse respiratoire aigu de l'adulte (ARDS)
 - c l'ostéomyélite
 - d le pneumothorax
 - e des troubles de la crase sanguine
72. Un travailleur de 23 ans en excellente santé est envoyé en urgence à l'hôpital avec un ventre de bois. 4 heures avant son admission, il a présenté subitement des douleurs insupportables dans la région épigastrique, irradiant de suite dans tout l'abdomen. Quel est le diagnostic le plus vraisemblable?
- a une diverticulite aiguë
 - b la rupture d'un kyste échinococcique du foie
 - c un infarctus mésentérique
 - d un anévrisme disséquant de l'aorte
 - e la perforation d'ulcère duodénal
73. Chez une jeune fille de 10 ans, vous mettez en évidence un souffle entre les deux omoplates. La pression sanguine au bras droit est de 170/90 mmHg. La cause la plus probable de cette découverte concernant la pression sanguine est une
- a insuffisance de la valve aortique
 - b sténose congénitale de la valve aortique
 - c sténose de l'isthme aortique
 - d hypertension essentielle juvénile
 - e sténose de l'artère rénale

74. Un homme de 47 ans arrive aux urgences suite à une chute à vélo. Il est agité et dégage un important foetor alcoolique. Il se plaint d'une douleur basi-thoracique gauche et de l'hypocondre gauche. Le score de Glasgow est à 15. Il n'a pas de plaie visible. La fréquence respiratoire est à 38/min, le pouls à 140/min, la tension artérielle à 90/60 mmHg. Quelle est l'explication la plus probable de la situation hémodynamique?
- un réflexe vagal suite à l'accident
 - une conséquence de l'intoxication alcoolique
 - un choc cardiogène
 - une hypovolémie
 - une embolie pulmonaire
75. Une femme de 25 ans se plaint pendant le dernier tiers de sa grossesse d'un prurit. Elle n'a pas de douleurs abdominales, pas de fièvre, pas de frissons et elle n'a pas vomi. Il ressort de l'anamnèse qu'elle avait déjà des épisodes de prurit lorsqu'elle prenait des contraceptifs oraux.
Status clinique:
matrice agrandie, quelques égratignures, autrement sans particularités
resultats de laboratoire:
bilirubine totale 36 $\mu\text{mol/l}$ (norme: 5.1-17.0)
phosphatase alcaline 320 U/l (norme: 30-120)
leucocytes normaux
transaminases normales
anticorps antimitochondriaux négatifs
Quel est le diagnostic le plus probable?
- une stéatose hépatique aiguë de la grossesse
 - une cirrhose biliaire primitive
 - un ictère de la grossesse
 - une lithiase cholédocienne
 - un syndrome de Gilbert (maladie de Meulengracht)
76. Un homme de 64 ans est hospitalisé avec une fracture de la jambe gauche. Il est parfaitement orienté dans le temps et dans l'espace. A part la blessure, l'examen physique est sans particularité.
valeurs de laboratoire:
hémoglobine 13.8 g/dl (norme: 13.5-18.0)
MCV 112 fl (norme: 80-100)
leucocytes 6 G/l (norme: 4.5-11)
transaminases normales
gamma-GT 3 fois la norme
La fracture est traitée chirurgicalement. Trois jours plus tard, il est désorienté, commence à trembler et à halluciner. La numération leucocytaire est maintenant à 12 G/l et sa température corporelle monte à 38.6 °C.
Quel est le traitement le plus approprié?
- le lorazepam
 - le propranolol
 - l'halopéridol
 - le promazin
 - le phénobarbital
77. Malgré une pénicillinothérapie d'une semaine, un homme de 24 ans présente toujours une odynophagie persistante associée à une asthénie et à une polyadénopathie cervicale bilatérale.
Au vu du status pharyngé (voir figure), quel est le diagnostic le plus vraisemblable?



- une tuberculose pharyngée
- une angine de Plaut-Vincent
- une mononucléose infectieuse
- la herpangine
- une pharyngite virale

78. Une étude a été conduite en Grande-Bretagne pour déterminer s'il existe une association entre infarctus du myocarde et utilisation de la pilule contraceptive chez la femme jeune. Les antécédents de prise de pilule contraceptive entre 1990 et 1995 ont été comparés dans deux groupes de femmes.
Le premier groupe était constitué des 448 femmes britanniques de 16 à 44 ans ayant souffert d'un infarctus du myocarde en 1994-1995. Le deuxième groupe comprenait 1728 femmes tirées au sort parmi les femmes britanniques du même âge n'ayant jamais fait d'infarctus du myocarde.
Sur la base de ces informations, quel est le plan d'étude utilisé dans ce travail de recherche?
- une série de cas
 - une enquête transversale
 - une étude cas-témoin
 - une étude de cohorte
 - un essai randomisé
79. Une fillette de 3 ans est amenée aux urgences de pédiatrie à cause de l'apparition de petites taches bleu-violet sur la peau depuis la veille. Elle est en bonne santé habituelle mais a présenté une infection des voies aériennes supérieures la semaine passée. Sa température est de 37.4 °C et elle est en bon état général. Sa tension artérielle est de 110/70 mmHg. Les taches sont punctiformes, ne disparaissent pas à la vitro-pression et sont disséminées sur tout le corps. Elle n'a pas de splénomégalie. Sa formule sanguine montre:
hémoglobine 12 g/dl (norme: 11-16)
leucocytes 9.1 G/l (norme: 3-12.5)
thrombocytes 11 G/l (norme: 150-450)
Quel est le diagnostic le plus probable?
- le purpura rhumatoïde de Schönlein Henoch
 - le purpura thrombocytopénique idiopathique
 - la leucémie
 - la méningococcémie
 - la thrombasthénie de Glanzmann
80. Un homme de 52 ans est hospitalisé en urgence présentant des vomissements, des douleurs épigastriques en ceinture et une élévation des amylases sériques à 270 U/l (norme: 60-180). Le scanner abdominal met en évidence une pancréatite oedémateuse. Cet examen montre également une masse ronde de 3.5 cm de diamètre dans la surrenale droite. Les valeurs de cortisol, aldostérone, adrénaline, noradrénaline, androgènes et 10-hydroxy-cétestéroïdes sont normales.
Quelle démarche est indiquée dans ce cas?
- l'aspiration d'aiguille fine guidée par CT-scan
 - une surrenalectomie droite par laparoscopie
 - une surrenalectomie à prévoir 6 semaines plus tard après guérison de la pancréatite
 - attendre, répéter l'examen CT dans 6 mois
 - ne rien faire
81. Une femme de 67 ans vient aux urgences en raison de douleurs abdominales diffuses. L'anamnèse révèle qu'elle souffre d'une constipation et d'une diarrhée en alternance et qu'elle a de temps en temps du sang dans les selles. L'examen clinique montre un abdomen souple et, à la palpation, une légère douleur et des selles dures dans la partie gauche de l'abdomen.
Quelle est la démarche diagnostique la plus judicieuse?
- une radiographie de l'abdomen à vide debout/couché, un lavement à la gastrographine
 - un CT-scan de l'abdomen et du bassin
 - un angioscanner, assigner le lactate dans le sang
 - un ultrason de l'épigastre, des testes hépatiques et cholestatiques
 - assigner le dosage sanguin des paramètres infectieux, un contrôle gynécologique
82. La mère d'un garçon de 18 mois vous consulte en urgence. Il y a 2 jours, après une réprimande banale, le garçon a paru très contrarié, il s'est mis à pleurer, a fait une véritable crise, il en a perdu le souffle et son visage est devenu tout bleu. Cela a duré environ 1/2 minute. Ce matin dans des circonstances analogues, après s'être mis dans une grande colère, il a fait un épisode identique, mais a perdu connaissance pendant un temps que la maman n'arrive pas à préciser, probablement quelques minutes, sa figure était de nouveau toute bleue.
Quelle est l'attitude correcte du médecin?
- pratiquer un électroencéphalogramme en urgence
 - pratiquer un ECG et organiser une échographie cardiaque.
 - penser à un trouble du rythme cardiaque
 - penser à une épilepsie et envisager de la traiter
 - rassurer la famille en expliquant la nature et le caractère bénin de ces épisodes
83. Un homme à l'âge de 54 ans consulte pour une otalgie droite avec otorrhée purulente. Son anamnèse révèle une hypoacousie droite progressive depuis plusieurs années avec des épisodes d'écoulement auriculaire. A l'otoscopie, vous constatez un polype qui masque la moitié supérieure du tympan.
Quel est le diagnostic le plus probable?
- une otite moyenne chronique cholestéatomateuse
 - une otite externe maligne (nécrosante)
 - un carcinome du conduit auditif externe
 - un corps étranger du conduit auditif externe
 - un bouchon de cérumen obstructif

84. Une fille de 3 ans est fébrile à 38.5 °C. Elle présente un écoulement nasal antérieur muco-purulent et un oedème péri-orbitaire gauche.
Quel est le diagnostic le plus probable?
- une atrésie choanale
 - une rhinite allergique
 - une sinusite ethmoïdale
 - une sinusite frontale
 - une sinusite maxillaire
85. Une fillette de 8 ans souffre de fatigue, d'excrétion d'urine augmentée, de soif accrue et d'une perte de poids depuis un certain temps et depuis plus récemment aussi de douleurs abdominales. On suspecte un diabète sucré. Des examens de laboratoire donnent les résultats suivants:
glycémie à jeun 15 mmol/l (norme: <<7)
glycosurie 1 % positive
acétone dans l'urine ++
Quel examen supplémentaire est indispensable pour affirmer le diagnostic?
- un test de tolérance orale au glucose
 - une glycémie fractionnée
 - la détermination d'une glycémie et d'une insulïnémie
 - la détermination du glucose dans les urines de 24 heures (élimination totale)
 - aucun des examens mentionnés ci-dessus
86. Un homme de 63 ans est admis aux urgences à cause de douleurs dans l'hypochondre droit. Il est dans un état général diminué, sa température est de 38.3 °C. A la palpation, il présente une douleur de l'hypochondre droit sans défense, ainsi qu'un ictère.
valeurs de laboratoire:
bilirubine 83 µmol/l (norme 5.1-17.0 µmol/l)
ALAT 120 U/l (norme 0-35 U/l)
phosphatase alcaline 320 U/l (norme 30-120 U/l)
leucocytes 14 G/l (norme: 4.5-11)
neutrophiles 85 % (norme: 40-70)
L'échographie montre une lithiase vésiculaire, ainsi qu'une dilatation des voies biliaires intra- et extra-hépatiques.
Quelle est la démarche correcte dans cette situation?
- une antibiothérapie seule
 - une antibiothérapie et une cholécystectomie d'urgence
 - une antibiothérapie, une ERCP avec papillotomie, une cholécystectomie laparoscopique ultérieure
 - une antibiothérapie, un drainage endoscopique ou transhépatique sans cholécystectomie
 - une tomographie computerisée abdominale
87. Malgré d'un diurétique, un homme de 47 ans avec une cirrhose hépatique présente une ascite massive accompagnée de dyspnée marquée. En outre il a une hyponatrémie à 125 mmol/l (norme: 136-144) et une hypoalbuminémie à 20 g/l (norme: 35-55).
Le meilleur traitement immédiat est
- la perfusion d'albumine
 - le canrénoate par voie intraveineuse
 - le furosémide par voie intraveineuse
 - la correction de l'hyponatrémie par perfusion de NaCl hypertonique
 - la paracentèse de plusieurs litres
88. Un jeune homme à l'âge de 19 ans s'est blessé l'oreille il y a deux heures avec un coton-tige. L'otoscopie montre la présence de sang frais dans le canal auditif. Après aspiration, vous constatez une petite perforation fraîche de la membrane tympanique.
L'audiogramme tonal montre une hypoacousie de transmission avec des seuils s'élevant à 20 dB dans les fréquences graves.
Quelle mesure thérapeutique est indiquée?
- des gouttes nasales vasoconstrictives
 - des gouttes auriculaires
 - une mastoïdectomie
 - une tympano-ossiculoplastie
 - l'éviction d'eau dans l'oreille et l'expectative
89. Une mère vous amène son fils de 7 ans pour des lésions de grattage de la nuque, accompagnées d'adénopathies, qui ont débuté il y a deux semaines.
Quel est le premier diagnostic à envisager?
- un eczéma atopique
 - la gale
 - des poux
 - la rubéole
 - la maladie de Hodgkin
90. Un homme de 22 ans en bonne santé habituelle présente une fracture ouverte du fémur droit et une fracture du bassin suite à un accident de moto. Il est conscient, pâle, anxieux, agité et transpirant. Son pouls est à 140/min, sa tension artérielle à 80/50 mmHg et sa fréquence respiratoire à 35/min.
Quel est le tout premier geste à effectuer?
- poser une voie veineuse centrale

- b poser une voie veineuse périphérique
- c intuber le patient
- d injecter de l'adrénaline
- e mesurer l'hématocrite

91. Durant un accouchement on constate l'apparition soudaine d'une bradycardie foetale qui persiste malgré l'administration d'une tocolyse, un changement de position de la patiente et l'administration d'oxygène.

Quelle complication de l'accouchement **n'explique pas la survenue de cette bradycardie foetale?**

- a une rupture utérine
- b un décollement placentaire
- c une procidence du cordon
- d une compression de la veine cave
- e une embolie de liquide amniotique

92. Un germaniste qualifié de 48 ans, spécialiste de la littérature contemporaine, travaille dans une université et a une lourde charge d'enseignement (18 heures hebdomadaires sur un semestre). Avant, le travail lui procurait du plaisir. La pile de dossiers sur son bureau devient de plus en plus haute, les demandes s'accroissent quotidiennement. Les revues de qualité lui envoient des rappels pour des expertises d'articles demandées. Il ne trouve presque plus le temps de préparer ses cours. Des étudiants attendent devant sa porte et lui demandent conseil, aussi pour des problèmes privés. Son chef pense qu'il est occupé des journées entières par un travail improductif. Il exige davantage de performances tout en limitant ses marges de man?uvre (voyages pour les congrès) et ses libertés de décision. En plus, sa femme, qui travaille, attend de lui qu'il rentre plus ponctuellement à la maison et qu'il s'implique davantage dans les tâches ménagères. Le germaniste commence à souffrir, présente de plus en plus d'épisodes de transpiration excessive. La nuit il n'arrive pas à dormir et se creuse la tête sur les causes d'une tachycardie de plus en plus marquée.

Laquelle de ces affirmations **ne correspond pas** à ce cas?

- a Une hyperthyroïdie devrait être exclue.
- b Cette situation est un exemple typique de mobbing par le supérieur.
- c Cette constellation prédispose à des problèmes psychosomatiques.
- d Cette constellation représente un risque de développement d'un burn-out.
- e Une optimisation de l'organisation du travail peut conduire à une amélioration de la situation.

93. Une fille de 10 ans, pesant environ 40 kg, est amené aux urgences suite à un accident de ski (choc contre un sapin). Son état de conscience est correct (Glasgow Coma Scale 15). Elle se plaint de douleur à la cuisse droite et dans le bas abdomen. Au status, vous mettez en évidence une pâleur importante et une tachycardie, la cuisse droite déformée et gonflée et une douleur vive dans la région de la symphyse pubienne.

Laquelle des mesures suivantes est **inappropriée** dans l'immédiat?

- a donner 800 ml de NaCl 0.9 % pour remplissage immédiat
- b la commande de sang
- c une sonde urétrale
- d la mise en place de deux voies veineuses périphériques pour remplissage
- e un ultrason abdominal

94. Une jeune maman vient vous consulter parce que son fils de 7 semaines pleure très souvent. Cela a commencé 2 semaines auparavant et va en s'aggravant. Elle est désespérée puisqu'elle n'arrive pas à identifier la cause de ces pleurs. Son garçon est entièrement nourri au sein. Vous relevez les éléments anamnétiques et cliniques pertinents par rapport à ce problème et la mère vous précise:

Le garçon pleure en général une heure après une tétée.

Il n'arrête pas de pleurer, si on le prend dans les bras.

Les pleurs ne s'arrêtent pas, si la mère essaye de lui redonner le sein.

Il a eu une prise pondérale de 220 g au cours de la semaine précédant la consultation. Il pèse actuellement 4500 g et mesure 56 cm.

Son poids à la naissance était de 3700 g, sa taille de 52 cm.

Qu'est-ce qui fait ensuite partie de la procédure?

+/- a veiller à ce que l'enfant évacue bien l'air après son repas, soit en le portant en position verticale, soit en le couchant pendant quelques minutes à plat ventre

+/- b faire une pH-métrie pour rechercher un reflux gastro-oesophagien

+/- c augmenter la fréquence des repas indépendamment de la quantité bue

+/- d recommander à la mère de continuer à surveiller la prise pondérale

95. Un homme de 48 ans, souffrant d'une cirrhose post-virale C, est admis aux urgences pour vomissements de sang. Le patient est somnolent, montre une tachycardie et une hypotension, et il vomit toujours beaucoup du sang. Le gastroentérologue de garde n'est plus en hôpital.

Le traitement dans le service des urgences comporte:

+/- a des bêta-bloqueurs

+/- b l'octreotidum (Sandostatine®)

+/- c un shunt porto-cave

+/- d la sonde Sengstaken-Blakemore

96. Un patient âgé de 50 ans (170 cm, 87 kg) consulte son médecin à cause de douleurs très aiguës de la région du gros orteil gauche. L'acide urique sérique est de 780 µmol/l (norme: 90-360).

Qu'est-ce qui peut être employé pour le traitement aigu de ces troubles?

+/- a l'alcalinisation des urines

+/- b l'allopurinol

- +/- c la colchicine
- +/- d le diclofénac

97. Un garçon de 15 ans a eu un accident avec son vélo 3 semaines auparavant. A l'exception d'un hématome en monocle, d'une fracture du nez et d'une plaie frontale, il n'a pas eu d'autre blessure. Il présente pourtant depuis lors un rhume résistant au traitement. Pour cela il consulte, accompagné de sa mère, son médecin traitant.
Jugez du bien-fondé des réflexions suivantes:
+/- a Une investigation des nerfs crâniens est judicieuse.
+/- b Une lésion de la base du crâne doit être investiguée par tomographie computerisée.
+/- c En pensant à une lésion de la base du crâne, on cherche à mettre en évidence des bulles d'air à la tomographie computerisée.
+/- d Une rhinolithorax doit être traitée chirurgicalement.
98. Un fumeur chronique âgé de 70 ans consulte son médecin traitant en raison d'une intolérance croissante à l'effort, d'une dyspnée et d'une sensation de constriction thoracique lorsqu'il marche en montée. A plusieurs reprises, il a ressenti de brefs épisodes de vertiges à l'effort. Il y a un mois, il est tombé dans l'escalier et une plaie à l'occiput a dû être suturée. À l'examen, la tension artérielle est à 170/95 mmHg en position couchée et à 155/90 mmHg en orthostatisme. On note un pulsus parvus et tardus et des râles inspiratoires fins aux deux bases pulmonaires. L'ECG montre des ondes T négatives dans le territoire antéro-latéral.
Qu'est-ce qui est indiqué dans cette situation?
+/- a de hautes doses d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion
+/- b un test d'effort maximal
+/- c une scintigraphie pulmonaire
+/- d une échocardiographie
99. Une femme de 60 ans avec une tumeur parotide droite depuis plus de 20 ans développe en quelques semaines une paralysie progressive de toute l'hémiface droite.
Quel/s diagnostic/s faut-il envisager?
+/- a une paralysie faciale idiopathique (paralysie de Bell)
+/- b une dégénérescence maligne d'un adénome pléomorphe
+/- c une parotidite chronique
+/- d un kyste surinfecté de la parotide
100. Une femme de 62 ans, connue pour un trouble bipolaire et traitée par lithium depuis plusieurs années, vient aux urgences le soir accompagnée de son fils. Il raconte l'avoir trouvée confuse à son domicile 30 minutes avant à côté d'un emballage de lithium à 50 cp vide. Elle ne sait plus combien de comprimés elle a ingérés, mais dit les avoir pris le jour même. L'examen clinique met en évidence une ataxie et une dysarthrie. Les examens biologiques relèvent une lithémie à 6.2 mmol/l (intervalle thérapeutique 0.5-1.2), une créatinine à 220 µmol/l (norme <115) et une hypernatrémie à 150 mmol/l (norme 136-145).
Que faut-il faire?
+/- a administrer du charbon actif
+/- b administrer du furosémide intraveineuse
+/- c administrer un laxatif
+/- d effectuer une hémodialyse
101. Un motocycliste de 22 ans est admis 4 heures après un grave accident. On note une luxation du genou, ouverte, ainsi qu'une paralysie du nerf peroneus commun (nerf sciatique poplité externe). La luxation du genou a été réduite conservativement.
Qu'est-ce qui fait partie des prochaines mesures urgentes?
+/- a une arthroscopie immédiate
+/- b une palpation des pouls pédiens
+/- c une électromyographie (EMG)
+/- d la fermeture chirurgicale de l'arthrotomie traumatique
102. Un homme de 47 ans vous consulte pour des douleurs et une tuméfaction sous-mandibulaire depuis 2 jours. A l'examen, vous trouvez un trismus, une tuméfaction sous-mandibulaire douloureuse et chaude ainsi qu'une hyperémie de la région rétro-molaire et amygdalienne. La température est élevée.
Quel/s diagnostic/s faut-il envisager?
+/- a un abcès péri-amygdalien
+/- b un abcès dentogène
+/- c un abcès du plancher buccal antérieur
+/- d une sialadénite sous-maxillaire
103. Un patient de 24 ans, connu pour la maladie de Hodgkin, a reçu son quatrième cycle de chimiothérapie il y a 10 jours. Maintenant il se sent fébrile pendant 2 jours, mais par ailleurs, il est totalement asymptomatique. Aux urgences, vous mesurez 2 fois une température de 38.5 °C dans une heure. La formule sanguine montre un nombre de leucocytes de 1.2 G/l (norme: 4.5-11) et une agranulocytose complète. A l'examen clinique, vous ne pouvez pas localiser le foyer de l'infection.
Quelle est la mesure première et la plus importante?
- a instaurer un traitement antibiotique
 - b administrer de la prednisone
 - c administrer du filgrastim (G-CSF)
 - d donner des antipyrétiques
 - e transfuser des leucocytes

Pour un patient fébrile avec une neutropénie fébrile, la mesure première et la plus importante est d'instaurer un traitement antibiotique empirique (option a). La neutropénie fébrile est une urgence médicale en oncologie, et le risque de mortalité augmente si un traitement antibiotique empirique n'est pas initié rapidement, idéalement dans l'heure suivant l'apparition de la fièvre.

Gestion de la neutropénie fébrile

1. Précautions en cas de neutropénie : Dès l'évaluation clinique.
2. Stratification des risques : Utiliser des outils comme le score MASCC pour évaluer le risque de complications graves.
3. Accès veineux et cultures sanguines : Établir un accès IV et obtenir deux séries de cultures sanguines avant de commencer les antibiotiques.
4. Antibiotiques empiriques : Commencer un traitement antibiotique empirique pour éviter les complications graves.
5. Consultation : Consulter l'oncologue du patient et, si nécessaire, des spécialistes des maladies infectieuses.
6. Soins de support : Administrer des liquides IV, des antipyrétiques, des antiémétiques, etc.

Thérapie antibiotique empirique

- Patients à haut risque : Hospitalisation et antibiotiques IV à large spectre.
 - Antibiotiques recommandés : Piperacilline/tazobactam, cefepime, méropénem ou imipénem.
- Patients à faible risque : Considérer une thérapie antibiotique orale en ambulatoire si le patient tolère l'apport oral et dispose d'un accès adéquat aux soins.
 - Antibiotiques recommandés : Ciprofloxacine ou lévofloxacine plus amoxicilline/clavulanate ou clindamycine en cas d'allergie à la pénicilline.

En résumé, dans le contexte d'une neutropénie fébrile chez un patient atteint de la maladie de Hodgkin en chimiothérapie, l'instauration rapide d'un traitement antibiotique empirique est cruciale pour réduire le risque de mortalité et prévenir les complications graves.

104. Après un accident, un homme de 43 ans présente un défaut cutané de la taille d'une paume de la main de la partie inférieure du tibia. Après un traitement de la plaie par des soins de plaie, celle-ci présente une granulation satisfaisante. La plaie est propre, sans signe d'œdème ni d'inflammation.
Quelle est l'attitude thérapeutique la plus appropriée?
- des pansements quotidiens de la plaie jusqu'à l'épithélisation secondaire
 - la couverture de la plaie par une greffe cutanée
 - la couverture du défaut par un lambeau de rotation
 - une greffe par cross leg
 - la mobilisation des bords de la plaie et la fermeture directe par des points profonds en U
105. Dans une population de 11'000 hommes interrogés, 1000 avaient déjà eu un infarctus du myocarde. Au cours des 5 années suivantes, 500 nouveaux cas de premier infarctus du myocarde furent diagnostiqués dans cette même population.
Le risque de premier infarctus du myocarde sur 5 ans est de
- 5%
 - 5.50%
 - 10%
 - 10.50%
 - 20%
106. Un informaticien de 45 ans se présente aux urgences avec des douleurs en coup de poignard de la région épigastrique, persistantes depuis 4 heures. Il est fumeur et admet avoir présenté occasionnellement des douleurs du haut abdomen depuis plusieurs semaines. Une ultrasonographie abdominale effectuée récemment était sans particularité, ne montrant en particulier aucune évidence de cholélithiase. À l'examen clinique, vous constatez un abdomen aigu avec un péritonisme du haut abdomen et une absence de bruit.
Dans ce contexte, quelle technique d'imagerie semble la plus utile?
- une radiographie de l'abdomen de face
 - une radiographie du thorax de face couché
 - une radiographie du thorax de face debout
 - un transit baryté
 - une ultrasonographie de nouveau
- Pour un patient présentant des douleurs aiguës de la région épigastrique, un abdomen aigu avec péritonisme et absence de bruits intestinaux, la technique d'imagerie la plus utile serait une radiographie du thorax de face debout (option c).
- La radiographie du thorax debout permet de détecter la présence d'air sous le diaphragme, indiquant un pneumopéritoine, ce qui est un signe de perforation gastro-intestinale. Cette méthode est souvent préférée car elle peut rapidement révéler des signes de perforation, nécessitant une intervention chirurgicale urgente.
107. Chez un homme de 60 ans vous palpez dans la région sous-mandibulaire un nodule de la taille d'une cerise, dur, indolore et bien mobilisable. À l'anamnèse, le patient déclare avoir découvert ce nodule il y a 4 semaines en se rasant.
Quelle est l'affection la plus probable?
- une inflammation de la glande sous-maxillaire
 - la maladie des griffes de chat (adénite virale)
 - un carcinome du plancher de la bouche
 - un abcès chronique d'un ganglion lymphatique
 - la sarcoïdose (maladie de Boeck)
108. Un jeune homme de 14 ans, accompagné de sa mère, consulte son médecin en raison de douleurs de jambe. Il est sportif et était jusqu'ici en bonne santé. Il n'y a pas eu de traumatisme. Les douleurs ont débuté il y a quelques semaines et se situent dans la partie proximale de la jambe droite. Elles s'aggravent progressivement. Elles augmentent à l'effort. Elles sont ressenties généralement pendant la journée mais depuis peu parfois aussi pendant la nuit. Il n'a jamais eu de fièvre. L'examen clinique révèle une discrète tuméfaction légèrement douloureuse située sur le côté médial du tibia droit proche de l'articulation du genou. La peau au niveau de la tuméfaction est normale. La mobilité du genou n'est pas limitée. Le reste du status est normal.
Quelle est la première démarche?
- un CT
 - une radiographie conventionnelle
 - des hémocultures
 - une scintigraphie osseuse
 - attendre
109. Un travailleur du bâtiment de 35 ans arrive aux urgences après avoir reçu une heure auparavant une poutrelle en bois sur la moitié gauche du visage. Il présente une importante plaie profonde du sourcil et une tuméfaction massive de la paupière. L'acuité visuelle atteint 0.8 de près sans correction. À l'examen de la motilité oculaire, on découvre une limitation marquée de l'élévation en abduction et adduction. L'abaissement est aussi un peu limité.
Ce trouble de la motilité oculaire est le plus vraisemblablement lié à une
- limitation mécanique de la motilité oculaire
 - parésie du muscle droit supérieur
 - parésie du muscle oblique supérieur
 - parésie du muscle oblique inférieur
 - parésie incomplète du nerf oculomoteur
110. Un homme de 65 ans se plaint de vertiges intermittents et d'une capacité physique réduite. L'examen clinique reste sans particularité. Sa tension artérielle est à 140/80 mmHg et la fréquence cardiaque à 42/min. L'ECG montre un rythme sinusal. Sur le cyclomètre il peut réaliser 100 watts, mais après 3 minutes, il s'arrête essoufflé avec un pouls maximal de 50/min et la tension à 170/90 mmHg.
De quoi s'agit-il le plus vraisemblablement?
- une hypothyroïdie
 - une maladie du nœud sinusal

- c un bloc AV
- d une vagotonie constitutionnelle
- e un manque d'entraînement

111. Une femme de 32 ans se plaint de douleurs thoraciques lancinantes, pouvant durer jusqu'à 2 heures, sur la ligne médioclaviculaire gauche. Ces plaintes sont indépendantes de l'effort, mais apparaissent depuis 3 mois fréquemment avant l'endormissement. Le status clinique est normal. L'ECG montre quelques extrasystoles supraventriculaires, la radiographie du thorax est normale.

Quelle est ensuite la démarche indiquée?

- a une scintigraphie au thallium
- b une coronarographie
- c une échocardiographie
- d la détermination de la créatinine-phosphokinase sérique (CPK)
- e rassurer la patiente et la contrôler dans 1-2 mois

112. Un adolescent de 20 ans, conducteur et porteur d'une ceinture de sécurité, vient d'avoir un accident de voiture à grande vitesse. Il a perdu connaissance pendant quelques secondes et se plaint essentiellement de douleurs thoraciques. Aux urgences, le score de Glasgow est à 14, la tension artérielle de 150/80 mmHg, le pouls de 90/min et la fréquence respiratoire est de 20/min. La pression manuelle sur l'hémi-thorax gauche déclenche une douleur. L'abdomen est souple et indolore. Il n'y a pas de lésion des membres. La radiographie du thorax met en évidence une fracture de la 2^e et de la 3^e côte à gauche avec un décollement pleural apical gauche et un élargissement du médiastin supérieur.

Quel est le diagnostic le plus vraisemblable?

- a une rupture isthmique de l'aorte
- b une rupture bronchique
- c un hématome rétrosternal et péricostal
- d un pneumo-hémithorax
- e un volet thoracique

113. Un blessé de 20 ans de la voie publique arrive à l'hôpital avec une commotion cérébrale et des douleurs thoraciques entraînant de la dyspnée. Cliniquement et radiologiquement, il a de nombreuses fractures de côtes des deux côtés et un volet thoracique gauche important. On place un drain pour aspirer un hémopneumothorax.

Quelle est la proposition thérapeutique la plus sûre pour le volet?

- a un bandage compressif
- b une ostéosynthèse costale
- c l'intubation et un respirateur artificiel
- d la trachéotomie
- e une extension transcutanée

114. Sur la lèvre d'une femme de 32 ans se trouve une lésion superficielle, bien délimitée, souple à la palpation (voir figure).

De quoi s'agit-il le plus probablement?



- a un carcinome
- b une stomatite bactérielle
- c une leucoplasie
- d une candidose
- e un aphte

115. Une femme de 35 ans se plaint depuis environ 3 mois de céphalées récurrentes. Depuis 6 semaines, elle remarque également une lente et progressive diminution de l'acuité visuelle, à droite de manière plus marquée qu'à gauche. On trouve alors une acuité visuelle de 0.5 droite et de 0.8 gauche. Sinon la patiente se dit être en bonne santé hormis une aménorrhée depuis 3 ans, laquelle n'a pas été investiguée vu le non-désir de grossesse.

Quel est le diagnostic de présomption?

- a la migraine
- b un prolactinome
- c une artérite temporale
- d une névrite optique
- e une rétinite pigmentaire

116. Lors d'une consultation pour vaccination, la mère d'un nourrisson âgé de 3 mois signale que son enfant vomit souvent un peu après les repas. A l'âge de 6 semaines, il y a eu passage du sein au lait adapté. Le bébé continue à prendre constamment du poids.

Quel est le diagnostic le plus probable?

- a une sténose du pylore
- b un reflux gastro-oesophagien
- c une intolérance au lait de vache
- d une intolérance au fructose
- e un diverticule de Meckel

117. Une femme de 75 ans, institutionnalisée pour démence, refuse toute prise alimentaire depuis 24 heures, alors qu'elle mangeait normalement auparavant.

Au vu de la radiographie cervicale ci-jointe, quel est le diagnostic le plus probable?



- a une diverticule de Zenker
- b l'épiglottite
- c une pharyngo-oesophagite caustique
- d une rupture spontanée du pharynx
- e un corps étranger

118. Une femme de 62 ans se plaint de douleurs lombaires depuis 3 mois. Une radiographie conventionnelle de la colonne lombaire montre des modifications dégénératives de l'ensemble des vertèbres. L'anamnèse fait état de l'ablation du sein droit pour cancer (T2N0M0) il y a 3 ans.

Quelle démarche est indiquée?

- a attendre et contrôler dans un an
- b des anti-rhumatismaux non-stéroïdiens et de la physiothérapie
- c une discographie L4/L5
- d une scintigraphie osseuse ou une résonance magnétique (IRM)
- e une myélographie lombaire

119. Un chef comptable âgé de 58 ans est hospitalisé à cause d'une faiblesse générale. Dans son anamnèse, on relève une tuberculose pulmonaire il y a 15 ans. L'examen clinique est normal à l'exception d'une maladie de Dupuytren à la main gauche.

Valeurs de laboratoire à l'entrée:

- sodium 132 mmol/l (norme: 136-145)
- potassium 5.9 mmol/l (norme: 3.5-5.0)
- créatinine 82 µmol/l (norme: <<115)
- hémoglobine 11.2 g/dl (norme: 13.5-17.5)
- leucocytes 4.9 G/l (norme: 4.5-11) avec 9 % d'éosinophiles (norme 1-4)
- thrombocytes 158 G/l (norme: 150-350)

Quel examen confirmera le diagnostic de suspicion, qu'il faut poser en raison de ces résultats?

- a un test de stimulation à l'ACTH
- b la mesure du Na et K dans les urines de 24 h
- c une ponction de la moelle osseuse
- d un examen des expectorations à la recherche de mycobactéries
- e la mesure de l'albumine, du quick et du facteur V

120. 7 jours après une anesthésie générale de courte durée, une femme de 42 ans, sans passé pulmonaire, présente un état fébrile ainsi qu'une toux et des expectorations fétides et noirâtres. Le cliché thoracique révèle une image cavitaire dans le parenchyme du poumon droit.

Quel est l'organisme en cause le plus vraisemblable?

- a le candida albicans
- b le mycoplasma pneumoniae
- c des germes anaérobies
- d le staphylocoque doré
- e aucun des organismes susmentionnés

121. Une fillette de 12 mois présente un gonflement de l'abdomen. Elle a présenté des épisodes diarrhéiques. La tension artérielle est à 110/80 mmHg. Dans l'hypocondre droit, on palpe une masse abdominale ferme et indolore, dépassant la ligne médiane.

L'échographie montre un déplacement, provoqué par une grande tumeur, du rein droit vers le bas.

Quel est le diagnostic le plus probable?

- a un kyste du cholédoque
- b une tumeur de Wilms
- c un neuroblastome
- d un séminome
- e une hémorragie surrénalienne

122. Une femme de 65 ans consulte en urgence pour une tache noire depuis 48 heures devant l'oeil droit. Elle se plaint que les visages des gens disparaissent dans la tache lorsqu'elle les regarde directement. Elle est en bonne santé générale et fumeuse depuis l'âge de 20 ans. Elle a consulté pour la dernière fois 2 ans auparavant un ophtalmologue qui a diagnostiqué un début de cataracte. Au status, l'acuité visuelle corrigée est de 0.1 à droite et 0.6 à gauche. La tension intraoculaire est à 20 mmHg à l'oeil droit et à 18 mmHg à l'oeil gauche. L'examen à la lampe à fente montre une cataracte corticonucléaire débutante bilatérale, symétrique. Au fond de l'oeil, on visualise des druses et des zones d'hyperpigmentation aux deux yeux dans la région maculaire. A l'oeil droit, on voit de plus une petite hémorragie ronde et une zone d'oedème maculaire. La papille présente une excavation papillaire de 0.4 (cup disk ration) des deux cotés.

Quel est le diagnostic clinique le plus probable?

- a une dégénérescence maculaire liée à l'âge
- b une cataracte
- c un glaucome chronique à angle ouvert
- d une névrite optique
- e une neuropathie optique ischémique antérieure

123. Une femme de 72 ans, en bonne santé jusqu'à présent, signale une irrégularité des selles en augmentation. Après avoir remarqué du sang dans les selles, elle consulte son médecin traitant.

Quelle est la première mesure diagnostique nécessaire?

- a un CT-scan abdominal
- b une colonoscopie
- c un dosage du CEA (antigène carcino-embryonnaire)
- d une formule sanguine complète
- e un toucher rectal

124. Lors d'un exercice de gymnastique artistique aux anneaux, une fille de 12 ans rate sa réception au sol et se tord la cheville. Il s'agit d'un mécanisme en inversion-supination au cours duquel elle a ressenti un craquement et une violente douleur externe. Elle présente une impotence fonctionnelle partielle qui s'aggrave rapidement avec l'apparition d'un volumineux oedème antéro-externe. Quel est le diagnostic le plus probable?

- a une algodystrophie
- b une fracture de l'astragale
- c une déchirure du ligament latéral externe de la cheville
- d une déchirure de la syndesmose
- e une rupture partielle du tendon d'Achille

125. Une femme de 25 ans, en bonne santé habituelle, se présente en consultation pour l'apparition brutale de lésions pustuleuses centrées par un poil sur les membres inférieurs. Elle emploie régulièrement un lait hydratant du commerce et s'épile avec de la cire. Quel est le diagnostic le plus probable?

- a une vasculite
- b un eczéma de contact
- c une folliculite
- d un psoriasis pustuleux
- e des verrues planes

126. TRAITEMENT - Un ouvrier de chantier, espagnol de 48 ans, habite la Suisse depuis 7 ans. 11 mois après son engagement par une société de construction, il éprouve une douleur lombaire au moment du soulever une poutrelle métallique et tombe par terre. Par le cabinet de médecine générale où il arrive une heure plus tard, il est hospitalisé pour suspicion d'hernie discale L4/L5 avec une compression de la racine L5 gauche. On confirme le diagnostic et pratique la résection du prolapsus discal 3 jours plus tard.

Qui prend en charge les frais de traitement de la hernie discale, y compris les frais chirurgicaux?

- a la Suva resp. l'assureur LAA
- b l'assurance responsabilité civile de l'employeur
- c l'assurance maladie du patient
- d les frais de traitement ambulatoire par la Suva, les frais hospitaliers par l'assurance maladie
- e -

127. Vous examinez une femme de 50 ans, par ailleurs en bonne santé, du fait d'une amputation du champ visuel. A cette occasion vous découvrez un décollement rétinien unilatéral et un processus sous-rétinien brunâtre.

A quoi faut-il penser d'abord?

- a un décollement rétinien inflammatoire
- b une hémorragie sous-rétinienne
- c un angiome rétinien
- d un mélanome de la choroïde
- e une métastase choroïdienne d'un cancer du sein

128. Chez un homme de 30 ans, héroïnomane connu, un diagnostic de schizophrénie vient d'être posé. Son psychiatre lui prescrit de l'halopéridol et du diazépam. 3 jours après le début du traitement, le patient présente des troubles de la marche et des contractions de la langue et du pharynx. Il est amené aux urgences.
Comme traitement immédiat, que faut-il lui administrer par voie intraveineuse?
- un antagoniste des benzodiazépines
 - un antagoniste des opiacés
 - un anticholinergique
 - un gluconate de calcium
 - un spasmolytique
129. Un essai clinique randomisé compare la Ranitidine au placebo dans la prévention de l'hémorragie récurrente de l'ulcère duodénal chez 200 patients souffrant d'ulcère (100 patients dans chaque groupe de l'étude). Après 2 ans de suivi moyen, 15 cas de récurrence sont apparus dans le groupe traité à la Ranitidine et 45 cas dans le groupe placebo (différence significative $p < 0.01$).
Quelle conclusion est juste?
- Le taux d'incidence moyen de récurrence d'hémorragie chez les deux groupes a été de 15 cas/100 personnes année.
 - En traitant 100 patients pendant 2 ans avec la Ranitidine, on évite 45 cas de récurrence.
 - Le risque relatif de récurrence chez les patients traités par Ranitidine, par rapport aux patients sous placebo, était de 5.0.
 - La différence d'incidence d'hémorragie entre les deux groupes est minime et n'a aucune implication pour la prévention de la récurrence chez les patients affectés d'ulcère duodénal.
 - Aucun des énoncés ci-dessus n'est correct.
130. Au cours des dernières années, un homme de 52 ans a présenté à plusieurs reprises des crises douloureuses après le repas postprandiales, localisées au niveau de l'hypocondre droit et cédant spontanément après quelques heures. Il vous consulte cette fois-ci parce que les douleurs persistent et s'accompagnent d'un état fébrile. A l'examen clinique, vous constatez une vive douleur de la région sous-costale droite.
Quel est l'examen adéquat pour confirmer l'hypothèse diagnostique?
- une échographie abdominale
 - une oeso-gastro-duodénoscopie
 - une cholécystographie
 - un cliché d'abdomen à vide
 - une urographie
131. 8 mois après une ostéosynthèse pour fracture du fémur, un patient de 30 ans se présente à votre consultation avec un empatement douloureux au niveau de la cicatrice opératoire ainsi qu'une hyperthermie considérable.
Quel est le premier diagnostic à envisager?
- un hématome
 - une myosite ossifiante
 - une formation excessive de cal
 - un sarcome
 - une infection
132. Une femme de 42 ans, avec une cholécystolithiase connue, consulte son médecin traitant pour fièvre, ictère et douleurs épigastriques qui sont apparues soudainement.
Quel est le diagnostic le plus probable?
- une pancréatite
 - une cholangite
 - une cholécystite
 - un ulcère duodénal pénétrant
 - une hépatite virale aiguë
133. Un garçon de 18 mois en bon état général présente depuis quelques semaines un écoulement jaune-verdâtre, d'odeur fétide, provenant de la narine droite.
Quel est le diagnostic le plus vraisemblable?
- une sinusite maxillaire droite
 - une sinusite ethmoïdale droite
 - un corps étranger dans la narine droite
 - une hyperplasie adénoïdienne avec adénoïdite
 - une tumeur dans la narine droite
134. Une fillette âgée de 3 ans est emmenée aux urgences par sa mère pour une fièvre élevée depuis 2 jours. Elle présente une énurésie diurne bien qu'elle était propre depuis un an. En outre, elle se plaint de douleurs abdominales. Vous trouvez une fillette pâle et fébrile à 39.8 °C.
Quelle mesure diagnostique faut-il prendre en premier lieu?
- un ultrason abdominal
 - la formule sanguine, la vitesse de sédimentation, les CRP
 - une hémoculture
 - une culture urinaire
 - un status /stix urinaire
135. Un nourrisson de 6 mois a depuis quelques jours une fièvre de 40 °C. Il est très irritable et sa fontanelle est tendue. La ponction lombaire pratiquée au 3^e jour est normale. Au 4^e jour apparaît sur le tronc un exanthème formé de petites taches rouge clair. L'enfant devenant en même temps afebrile.

- Quel est le diagnostic correct?
- la rougeole
 - la rubéole
 - la roséole (exanthème subit)
 - une infection virale à Cocksackie accompagnée de méningite
 - la scarlatine
136. Un bébé âgé de 10 jours est amené chez vous. Il est né 15 jours avant terme avec un poids de 2500 g. Il a émis du méconium à 12 heures de vie et s'est alimenté normalement. Depuis ce matin, il présente des vomissements teintés de bile, est apathique, refuse de têter et il a une température de 36 °C. Il n'a pas été à selles depuis 12 heures. A l'examen, son abdomen est souple, mais le bébé gémit quand vous le palpez.
Quel est le diagnostic de présomtion?
- la maladie de Hirschsprung
 - une atrésie intestinale
 - une sténose hypertrophique du pylore
 - un volvulus intestinal
 - une invagination
137. Lors d'un effort de démarrage au cours d'un match de tennis, un sportif de 45 ans ressent une violente douleur à la face postérieure de la cheville. Il boite, ne peut se mettre sur la pointe des pieds mais, à l'examen en décubitus dorsal, est capable de fléchir la cheville, quoique avec une force diminuée.
La lésion la plus probable est une rupture
- partielle du tendon d'Achille
 - totale du tendon d'Achille
 - du plantaire grêle
 - du jambier postérieur
 - du tendon du long fléchisseur des orteils 2 à 5
138. Un homme de 73 ans vient à votre consultation accompagné de sa fille. Elle vous signale que depuis quelques mois il a tendance à oublier les prénoms de son entourage et à se perdre lorsqu'il fait à pied un trajet en ville qu'il connaissait bien auparavant. A l'examen, il ne montre pas de déficit neurologique latéralisé.
À ce stade, quelle mesure diagnostique **n'** est **pas** indiquée?
- un examen Mini-Mental-State
 - le dosage de la TSH
 - le dosage de la vitamine B₁₂ plasmatique
 - une sonographie Doppler carotidien
 - une IRM cérébrale
139. Un garçon de 4 ans respire depuis quelques mois de plus en plus mal par le nez. Les parents ont également constaté une hypoacousie depuis peu.
L'origine de ces symptômes peut être:
- +/- a une atrésie choanale
 - +/- b une hyperplasie des végétations adénoïdes
 - +/- c une rhinopathie allergique
 - +/- d un corps étranger endonasal
140. Une sage-femme vous appelle en urgence auprès d'une patiente de 27 ans qui présente un cardiotocographie (CTG) avec un tracé pathologique. Le toucher vaginal vous permet de palper le cordon ombilical dans le vagin. La tête fœtale est située 1-2 travers de doigt au-dessus de la ligne interspinale.
Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas?
- +/- a repousser sur le champ la tête fœtale vers le haut et la maintenir ainsi
 - +/- b procéder à toutes les préparations d'une césarienne en urgence
 - +/- c essayer de pratiquer sur le champ un accouchement vaginal avec l'aide d'un appui sur le fond utérin (Manœuvre de Kristeller)
 - +/- d instaurer une tocolyse d'urgence
141. Veuillez regarder les deux radiographies ci-jointes d'une fracture de cheville.
Quelle(s) lésion(s) de parties molles peut-on identifier?



- +/- a le ligament latéral interne
- +/- b le ligament latéral externe
- +/- c la syndesmose
- +/- d la capsule articulaire antérieure

142. Un homme de 28 ans est victime d'un accident de la circulation. Il subit une collision frontale alors qu'il est au volant, ceinture non attachée. Après l'accident, il est inconscient et présente une réaction de défense à la douleur. Il est transporté non intubé aux urgences d'un hôpital universitaire. Lors de son admission, il est pâle, sa tension artérielle systolique est à 80 mmHg, son pouls à 120/min. Les pupilles sont contractées et isocores. Il présente par ailleurs une fausse mobilité de la jambe droite en-dessous du genou.
- Qu'est-ce qui fait partie des mesures les plus urgentes dans les 20 premières minutes?
- +/- a la pose d'une minerve
 - +/- b un cliché thoracique
 - +/- c une échographie de l'abdomen
 - +/- d une radiographie de la jambe droite
143. Vous êtes le médecin responsable d'un établissement médico-social. L'infirmière vous informe que durant les derniers jours il y a une augmentation des cas de diarrhées aiguës et de vomissements parmi les patients et le personnel. Les symptômes durent en général 1 à 3 jours.
- Qu'est-ce qui fait partie des mesures d'urgence à prendre?
- +/- a la déclaration téléphonique à l'Office Fédéral de la Santé publique
 - +/- b le renforcement de la désinfection des mains
 - +/- c des antibiotiques prophylactiques pour les résidents
 - +/- d la fermeture de la cuisine jusqu'à l'identification de la source
144. Une ménagère de 32 ans est connue pour une pollinose printanière qu'elle traite par spray de béclométhasone pendant les mois d'avril et de mai. Le reste de l'année, elle se plaint d'une légère obstruction nasale persistante avec épisodes fréquents de pansinusites aiguës. Le status endo-nasal et le CT sinusal ne révèlent pas d'anomalie anatomique notable.
- Pour diminuer le risque de sinusites aiguës, quelle mesure est indiquée?
- a un spray nasal quotidien de béclométhasone pendant toute l'année
 - b une corticothérapie systémique pendant la période de pollinose
 - c une méatotomie moyenne bilatérale
 - d une septoplastie
 - e une turbinoplastie bilatérale
145. Un homme de 24 ans, toxicomane par voie intraveineuse connu, se plaint d'un état subfébrile, d'inappétence progressive et de dorsalgies depuis 5 jours. A l'hospitalisation, le patient est en état général diminué, mais bien orienté. Il souffre de céphalées, mais ne présente pas de méningisme. Sa température est à 38.8 °C, sa tension artérielle à 95/60 mmHg et son pouls à 98/min. L'examen neurologique est normal, sauf une hypoesthésie au bord latéral du pied gauche. La percussion de la colonne vertébrale lombaire est douloureuse.
- valeurs de laboratoire:
- leucocytes 16 G/l (norme: 4.5-11)
- hémoglobine 6.4 mmol/l (norme: 8.4-10.9)
- thrombocytes 426 G/l (norme: 150-350)
- Quelle investigation permettra de poser le diagnostic?
- a une IRM de la colonne lombaire
 - b une radiologie conventionnelle de la colonne lombaire
 - c la recherche des facteurs rhumatoïdes
 - d une ponction lombaire
 - e aucune des investigations susmentionnées
146. Une mère a remarqué que son enfant âgé de 3 mois louche. Elle ne peut indiquer avec précision quand cette loucherie a débuté.
- Dans cette situation, que faut-il faire?
- a adresser immédiatement l'enfant à un ophtalmologue pour un examen plus détaillé

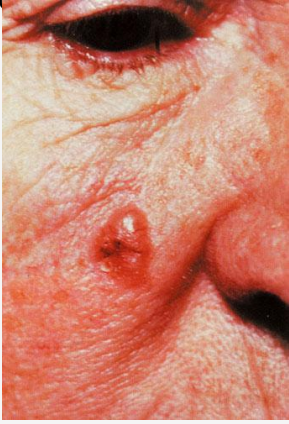
- b fermer l'oeil non-strabique à l'aide d'un pansement pendant la journée et convenir d'une nouvelle consultation 2 semaines plus tard
- c reconvoquer l'enfant pour un nouvel examen 3 mois plus tard et prendre alors la décision de l'adresser à un ophtalmologue
- d amener l'enfant à un ophtalmologue 3 mois plus tard
- e amener l'enfant à un ophtalmologue à l'âge d'un an
147. Lors de l'examen médical à la fin de l'école obligatoire, vous trouvez chez une jeune fille de 16 ans, sans plaintes subjectives, une tension artérielle de 85/50 mmHg. Pour le reste, l'examen clinique est normal.
Il faut recommander à cette jeune fille
- a consulter son médecin de famille pour une investigation
- b prendre des médicaments qui augmentent la tension artérielle
- c ne pas pratiquer de sport de compétition
- d éviter la haute altitude
- e ne pas s'en préoccuper
148. Depuis 3 ans, un adolescent de 21 ans utilise quotidiennement des gouttes vasoconstrictrices pour une obstruction nasale à prédominance nocturne. A l'examen, vous détectez une déviation septale modérée avec une turgescence des cornets inférieurs. Quelle mesure thérapeutique est indiquée en premier?
- a une septoplastie
- b une septoplastie avec cautérisation des cornets inférieurs
- c un changement du type de gouttes nasales vasoconstrictrices
- d un remplacement des gouttes vasoconstrictrices par des corticoïdes topiques
- e une corticothérapie systémique
149. Une Ile pare de 22 ans est à la 16e semaine de grossesse. Un an auparavant, elle a subi une césarienne pour la naissance de son premier enfant. Elle se plaint de fatigue, de faiblesse généralisée et n'a jamais reçu de supplémentation de fer. L'hémoglobine est à 9.5 g/dl (norme: 12-16) et l'hématocrite est de 28 % (norme: 36-46).
Parmi les affirmations suivantes, laquelle est la plus appropriée?
- a Des examens complémentaires sont indispensables pour exclure une hémolyse.
- b Il s'agit d'une anémie en raison d'une dilution sanguine dans le cadre de la grossesse.
- c L'anémie est le résultat d'un déficit en fer à mettre en relation avec les deux grossesses rapprochées.
- d Si la patiente ne reçoit pas de supplément de fer durant la grossesse actuelle, la probabilité d'une nouvelle césarienne est significativement plus élevée.
- e Un supplément de fer prescrit après la fin de la grossesse actuelle suffit à rétablir les réserves en fer.
150. Un homme de 40 ans souffre depuis 2 mois d'une raucité chronique de la voix. Lors de la prise d'anamnèse, il dit s'être toujours bien porté. Il ne signale qu'un seul traitement hospitalier. Une année auparavant, après une collision frontale comme conducteur d'une voiture, il est admis en urgence et est hospitalisé pour des fractures de côtes en série. Vous posez le diagnostic d'une parésie récurrentielle gauche et pensez à une éventuelle relation entre l'accident et la raucité.
Dans ces circonstances, laquelle des causes suivantes est la plus probable?
- a une compression du nerf récurrent par un cal hypertrophique après fracture
- b un faux anévrisme (aneurysma spurium) de l'aorte thoracique dans la région de l'isthme
- c une perturbation fonctionnelle d'origine ischémique du nerf laryngien récurrent par induration cicatricielle d'un hématome médiastinal
- d une lésion de décubitus de la trachée, sur intubation avec abcès médiastinal
- e une sténose trachéale consécutive à une respiration assistée prolongée
151. Chez un homme âgé de 50 ans, on vient de poser le diagnostic d'une cirrhose éthylique (stade Child A), avec hypertension portale et varices œsophagiennes de stade II.
Pour diminuer le risque de saignement des varices, quelle substance active est appropriée?
- a le métoprolol
- b la nitroglycérine
- c le propranolol
- d l'amlodipine
- e l'énalapril
152. Un homme de 49 ans vous consulte pour un contrôle général (check-up). En l'examinant, vous remarquez sur le dos une lésion qui mesure entre 6 et 10 mm de diamètre (voir figure).
Quelle est ensuite la démarche la plus appropriée?



- a l'excision de la totalité de la lésion pour l'examen histologique
- b une biopsie pour examen histologique
- c une radiothérapie
- d un contrôle dans 3 mois
- e aucune des mesures susmentionnées

153. Au cours des 10 dernières années, une femme de 80 ans a développé une tumeur paranasale droite (voir figure), qui saignait parfois d'une façon spontanée.

Quel est le diagnostic le plus probable?



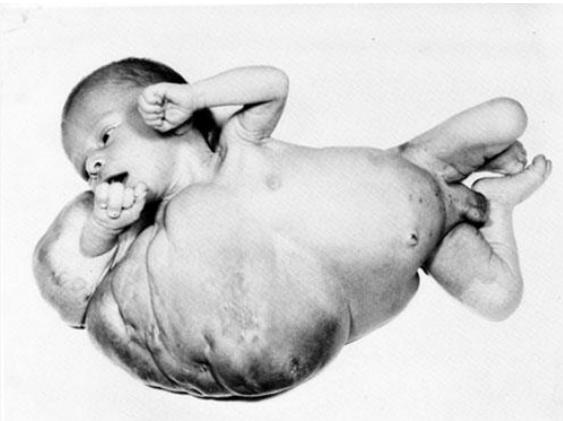
- a un carcinome basocellulaire
 - b un dermatofibrome
 - c un mélanome nodulaire, amélanotique
 - d un carcinome spinocellulaire
 - e un xanthome
154. Un enfant de 2 mois est né prématurément avec un poids de 1.2 kg. Il a évolué favorablement, est retourné sans problèmes à la maison, mais n'a pas encore atteint le poids normal d'un enfant de son âge.
- Quand faut-il vacciner cet enfant?
- a maintenant, selon l'âge puisqu'il a 2 mois
 - b attendre jusqu'à ce qu'il ait atteint le poids d'un enfant normal de 2 mois
 - c attendre jusqu'à la 2e vaccination de base à l'âge de 4 mois
 - d à l'âge de 2 ans
 - e à l'âge d'école enfantine
155. Quelle maladie évoque la lésion de la langue présentée sur l' image ci-jointe?



- a une langue géographique
 - b le lichen plan
 - c une glossite à Candida
 - d un carcinome de la langue
 - e une leucoplasie chevelue (Hairy leucoplasia)
156. Une fillette de 3 ans est amenée chez le pédiatre avec une haute fièvre apparue il y a deux jours. Elle se plaint de douleurs abdominales et présente une énurésie secondaire diurne. Elle est pâle et fébrile à 39.8 ° C. Son analyse urinaire montre:
- leucocytes ++
nitrit: +
globules rouges ++
protéine +
pH: 5 (norme: 4.5-8.0)
densité: 1.012 (norme: 1.001-1.035)
- Laquelle des malformations suivantes a-t-on le plus de chance de retrouver chez cette fillette?
- a un reflux vésico-urétéral
 - b un rein en fer à cheval
 - c un rein polykystique
 - d une sténose urétéro-vésicale
 - e une sténose pyélo-urétérale

157. On compare deux programmes de dépistage précoce de l'hypertension: dans le programme A, la valeur limite de la pression diastolique est fixée à 95 mmHg, dans le programme B, à 110 mmHg.
Qu'en est-il de leur sensibilité et de leur spécificité respectives?
- a A a une spécificité et une sensibilité plus élevées.
 - b B a une spécificité et une sensibilité plus élevées.
 - c La spécificité est pareille dans les deux programmes, la sensibilité est plus élevée dans le programme B.
 - d La sensibilité est pareille dans les deux programmes, la spécificité est plus élevée dans le programme B.
 - e La sensibilité est plus élevée dans le programme A, la spécificité est plus élevée dans le programme B.
158. Un garçon de 2 ans présente une toux depuis plusieurs jours avec début aigu sans symptômes infectieux. Lors d'un examen physique du système respiratoire, on entend un murmure vésiculaire légèrement diminué et des sibilances nettes sur l'une des côtes du thorax.
Quel est le diagnostic de présomption?
- a un faux-croup
 - b l'aspiration d'un corps étranger
 - c un asthme bronchique
 - d un pneumothorax
 - e une malformation bronchopulmonaire
159. Sans signes précurseurs, une femme de 50 ans remarque un matin au réveil qu'elle ne peut plus fermer l'oeil droit et que la salive s'écoule de sa commissure labiale droite. A l'examen vous trouvez en plus une absence de réflexe cornéen du côté droit. Le rest du status neurologique est sans particularités.
Quel diagnostic est le plus probable?
- a un infarctus cérébral
 - b une myasthénie grave
 - c une paralysie faciale périphérique
 - d des paralysies de plusieurs nerfs crâniens d'étiologie inconnue
 - e une sclérose en plaques
160. Une fille de 6 mois est adressée à l'hôpital. Elle présente de la fièvre depuis quelques jours. La mère a noté qu'elle ne bouge plus sa jambe droite depuis 24 heures et qu'elle pleure, lorsqu'elle la mobilise. A l'examen, la température est à 40 °C. A part une inflammation du tympan à droite, on observe une rotation externe et une flexion de la hanche droite, très douloureuse à la mobilisation. La cuisse droite semble un peu plus grosse que la gauche.
Valeurs de laboratoire:
hématocrite 35 % (norme: 36-46)
leucocytes 16.8 G/l (norme: 3-15) avec déviation gauche
vitesse de sédimentation 82 mm/h (norme: < 25 mm/h)
Sur la radiographie du bassin, on note une subluxation latérale de la hanche droite.
Quel est le diagnostic le plus probable?
- a une fracture épiphysaire de la tête fémorale droite
 - b une appendicite aiguë
 - c une ostéomyélite du fémur droit
 - d une arthrite septique de la hanche droite
 - e une dysplasie congénitale de la hanche droite
161. Une femme de 25 ans avec des cycles de 40 à 60 jours vous consulte parce qu'elle souhaite une grossesse. Vos investigations ne mettent en évidence aucun facteur pathologique à part une hyperprolactinémie.
Quel est le traitement en premier lieu?
- a l'agoniste de la dopamine
 - b l'agoniste GnRH
 - c la GnRH
 - d le clomifène
 - e la préparation oestro-progestative régulatrice des cycles
162. Un homme de 78 ans vous consulte accompagné d'une assistante de vie. Elle raconte qu'il souffre depuis un an d'une perte progressive de la mémoire, d'une diminution de sa capacité de concentration et d'une labilité affective. Il y a peu, on a constaté une incontinence et une ataxie à la marche avec rétropulsion.
Quel est le diagnostic le plus probable?
- a la maladie d'Alzheimer
 - b une hydrocéphalie à pression normale
 - c une déficience en vitamine B₁₂
 - d une démence sur accidents vasculaires multiples
 - e la neurosyphilis
163. Un garçon âgé de 4 ans est amené par sa mère chez le pédiatre à cause d'une boiterie qui dure depuis une semaine. Cette boiterie est actuellement indolore, mais il y a eu un épisode de douleur au pli de l'aine 3 semaines auparavant. A l'examen de la marche, il y a une boiterie de type Duchenne à droite. A l'examen clinique, la cuisse droite montre une amyotrophie avec différence de circonférence de 1.5 cm. La mobilité de la hanche droite est limitée en abduction et rotation interne. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire au bilan sanguin et les résultats de l'ultrason de hanche sont normaux.
Dans ce cas, quelle est l'attitude la plus appropriée?
- a rassurer la maman car la situation reviendra à la normale spontanément

- b prévoir un nouveau contrôle dans 48 heures
 - c effectuer une IRM du rachis
 - d effectuer une radiographie du bassin de face et une incidence de Lauenstein
 - e prescrire des anti-inflammatoires
164. Un homme de 38 ans consulte le médecin traitant et se plaint de problèmes de déglutition en buvant et de bronchopneumonies répétitives depuis 3 ans.
Quel est le diagnostic le plus probable?
- a une achalasie
 - b une sclérodermie
 - c une oesophagite de reflux sur hernie hiatale
 - d une fistule trachéo-oesophagienne
 - e un globe hystérique
165. Une femme de 28 ans, enceinte à 36 1/7 semaines d'aménorrhée, présente une tension artérielle à 160/110 mmHg et de volumineux œdèmes des membres inférieurs.
Quelle mesure **ne** faut-il prendre **en aucun cas**?
- a du repos
 - b du sulfate de magnésium
 - c un bêta-bloquant
 - d** un inhibiteur ACE *Prescrits post la grossesse: IEC, Diurétiques, antago. anti-thrombotiques?*
 - e un anticalcique
166. Au cours d'un jogging, un homme de 30 ans est mordu par un chien au mollet droit. Vous constatez deux plaies de 3 cm chacune sur la face postérieure de la jambe droite ainsi qu'une induration sous-jacente.
Le traitement correct comprend:
- +/- a le rinçage des plaies
 - +/- b la suture des deux plaies
 - +/- c une antibiothérapie
 - +/- d la mise au repos du membre blessé
167. Un homme de 73 ans vous consulte dans votre cabinet car il a des problèmes à lire.
Qu'est-ce qui fait partie des raisons possibles?
- +/- a une hémorragie vitréenne
 - +/- b une cataracte
 - +/- c un glaucome primaire à angle ouvert
 - +/- d une rétinopathie diabétique
168. Chez une fillette de 4 ans qui présente un ictère depuis une semaine, le diagnostic d'une hépatite B est posé. Sa maman se fait du souci concernant l'avenir de sa fille, de ses deux fils de 3 et 6 ans en bonne santé habituelle et de sa grossesse actuellement à 10 semaines d'aménorrhée.
Jugez du bien-fondé des affirmations suivantes:
- +/- a L'infectiosité ne dure pas plus que 2 à 3 semaines après le début de la maladie.
 - +/- b L'infection persiste chez environ 5 à 10 % des patients avec le danger d'une hépatite B chronique.
 - +/- c Une prophylaxie par vaccination active est possible.
 - +/- d Il existe un taux accru de malformations lors de l'infection en début de grossesse.
169. Un homme de 54 ans se plaint de douleurs profondes dans le bas-ventre et d'écoulement intermittent de glaires par l'anus. La colonoscopie montre un adénocarcinome du rectum s'étendant jusqu'à 8 cm de la marge anale.
L'investigation préopératoire minimale comprend:
- +/- a un CT de l'abdomen
 - +/- b une endosonographie rectale
 - +/- c un dosage de l'antigène carcinoembryonnaire sérique (CEA)
 - +/- d un lavement baryté en double contraste
170. Une femme de 40 ans, fumeuse (10 cigarettes par jour) et cadre dans le domaine de l'informatique dans l'industrie, se plaint de douleurs thoraciques lancinantes. Elle vit avec son conjoint. Ils n'ont pas d'enfants. Elle vous demande si elle est en train de faire un infarctus du myocarde.
Jugez du bien-fondé les réponses suivantes:
- +/- a Chez les femmes de 40 ans, l'infarctus du myocarde est un événement rare.
 - +/- b Les douleurs thoraciques lancinantes chez la femme sont généralement d'origine gastrique.
 - +/- c Chez les fumeuses sous traitement anticonceptionnel hormonal (pilule), le risque d'infarctus du myocarde est accru d'un facteur de 15.
 - +/- d Chez la femme, l'évolution d'une maladie coronarienne est nettement moins dangereuse que chez l'homme.
171. Un nourrisson est né avec la tuméfaction visible sur l'image ci-jointe. La diaphanoscopie effectuée est positive.
Quel est le diagnostic?



- a un tératome
- b une myéloméningocèle
- c un hémangiome
- d la maladie de Hodgkin
- e un lymphangiome

172. Vous recevez à votre cabinet de médecine générale un patient de 55 ans atteint d'un carcinome de la prostate avec métastases osseuses et pulmonaires. Les possibilités de traitement en chimiothérapie et en radiothérapie sont épuisées. Le patient souffre de douleurs aux mouvements dans la colonne vertébrale, le bassin et l'épaule gauche causées par les métastases osseuses disséminées. Jusqu'à présent, ces douleurs étaient traitées par du paracétamol et des bisphosphonates. Lors de la dernière consultation, il y a 3 semaines, cette médication suffisait encore, mais depuis 10 jours, les douleurs ont à nouveau fortement augmenté. Il faut prévoir de renforcer l'analgésie.

Quelle est la prescription la plus appropriée dans cette situation?

- a un opiacé fort, à prendre en cas de douleur ou, à titre prophylactique, avant une activité accrue
- b un opiacé fort et un laxatif à prendre en cas de besoin
- c un traitement opiacé de fond (à doses constantes) et un opiacé d'action rapide pour les douleurs incidentes
- d un traitement opiacé de fond et un opiacé d'action rapide pour les douleurs incidentes ainsi qu'un laxatif à prendre en cas de besoin
- e un traitement opiacé de fond et un laxatif à long terme, ainsi qu'un opiacé d'action rapide pour les douleurs incidentes et un antiémétique à prendre en cas de besoin

173. Des parents amènent leur fils âgé de 4 mois aux urgences de l'hôpital des enfants. Ils racontent qu'ils l'ont retrouvé dans son lit au milieu de vomissures. Cela fait 6 heures déjà qu'il est resté endormi alors qu'il aurait dû avoir faim depuis longtemps. Il a toujours été en bonne santé jusqu'à présent. La veille pourtant il aurait beaucoup pleuré et ne pouvait pas être calmé. Il n'avait pas de fièvre. Les parents n'ont pas observé de secousses cloniques. A l'examen physique, l'enfant est somnolent et vous remarquez des hématomes sur les deux bras. Les fonctions vitales sont normales.

Quelle est l'attitude la plus appropriée dans cette situation?

- a tranquilliser les parents et leur dire qu'il s'agit d'un premier épisode de convulsion et qu'une Électroencéphalographie sera à faire en cas de récurrence seulement
- b laisser rentrer les parents et leur enfant avec la directive de l'amener en contrôle chez son pédiatre dans quelques jours
- c hospitaliser l'enfant pour observation sans faire d'autres examens
- d demander un CT-scan cérébral et un examen du fond d'oeil à un ophtalmologue
- e pratiquer une formule sanguine complète et une ponction lombaire

174. Un homme de 65 ans vous consulte pour un check-up. Il est obèse (BMI 33 kg/m²), et il fume un paquet de cigarettes par jour. Son frère est décédé à la suite d'un accident cérébrovasculaire à l'âge de 42 ans. Malgré d'un traitement par une combinaison triple, sa tension artérielle est à 150/100 mmHg. Il y a une rétinopathie hypertensive stade 2. Le choc de pointe est palpé à 2 cm à gauche de la ligne médio-claviculaire.

Quel examen complémentaire faut-il demander à ce stade?

- a l'activité de la rénine plasmatique
- b l'aldostérone sérique
- c la métanéphrine dans l'urine
- d les fluctuations quotidiennes du cortisol
- e un duplex rénal

175. Un enfant issu d'une famille italienne ne prononce pas encore un seul mot à l'âge de 5 ans. Comme les deux parents travaillent, depuis 2 ans l'enfant est placé pendant le jour dans une garderie où l'on ne lui parle qu'en français.

Quelle est la cause la plus probable du retard de langage?

- a la langue des parents
- b la garderie d'enfants
- c des otites moyennes aiguës à répétition
- d un trouble de l'audition
- e le frein de la langue

176. Lors d'un cours de répétition, un soldat consulte le médecin à cause d'une hypoacousie et d'un acouphène apparus après un exercice de tir.

Que va-t-on vraisemblablement constater?

- a une fissure des tympons avec une surdité mixte
 - b une perforation des tympons et une hypoacousie de transmission
 - c des tympons intacts et une hypoacousie de perception concernant toutes les fréquences
 - d des tympons intacts et une hypoacousie de perception dans les fréquences aiguës
 - e aucune des situations décrites ci-dessus
177. En Suisse, en dehors d'éventuelles poussées épidémiques, on observe environ 100 cas par an de méningites à méningocoques indépendants les uns des autres sur le plan temporel et spatial.
Sur le plan épidémiologique, ce type de présentation est décrit le plus souvent comme étant
- a saisonnier
 - b épidémique
 - c endémique
 - d périodique
 - e cumulatif
178. Une femme de 32 ans est hospitalisée pour suspicion de grossesse extra-utérine. Une laparoscopie en urgence est indiquée. Laquelle des techniques d'anesthésie suivantes est la plus judicieuse?
- a la rachi-anesthésie
 - b l'anesthésie péridurale continue
 - c l'anesthésie générale par inhalation avec intubation
 - d l'anesthésie générale intra-veineuse avec masque
 - e la sédation avec anesthésie locale
179. Une ménagère à l'âge de 38 ans souffre depuis plusieurs semaines d'une inflammation des replis unguéaux du majeur de la main droite. La pression des bourrelets péri-unguéaux fait apparaître un peu de pus.
Quel est le diagnostic le plus probable?
- a la gale
 - b une verrue virale
 - c une paronychie herpétique
 - d la maladie de Darier
 - e la candidose
180. Lors d'un don du sang, des antigènes HBs et HBe sont détectés chez un père de famille. Il s'agit apparemment d'un porteur infectieux de l'hépatite B.
Quelle est la première mesure que doit prendre le médecin de famille?
- a une immunisation active contre l'hépatite B des autres membres de la famille
 - b une immunisation active et passive contre l'hépatite B des autres membres de la famille
 - c une immunisation passive de l'épouse contre l'hépatite B
 - d une recherche des anticorps et des antigènes de l'hépatite B par un examen de sang des autres membres du même ménage
 - e aucune mesure n'est à prendre, car cet état de porteur est probablement ancien
181. Une adolescente âgée de 18 ans constate l'apparition de spotting, malgré la prise régulière d'une contraception orale composée d'éthinylestradiol et d'un progestatif. Durant les semaines précédentes, elle a pris comme chaque année de la cétirizine et applique par voie nasale des stéroïdes topiques et de l'acide cromoglycique en raison d'une rhinite allergique. Elle prend par ailleurs depuis quelques semaines des gouttes de valériane et des dragées d'extraits de millepertuis à cause d'une insomnie.
L'étiologie la plus probable du spotting est une interaction entre les contraceptifs oraux et
- a la cétirizine
 - b les stéroïdes topiques
 - c le cromoglycate
 - d les gouttes de valériane
 - e les dragées de millepertuis
182. Une jeune fille de 14 ans est amenée chez son médecin de famille car elle se plaint de fatigue et de troubles de la concentration. Elle indique avoir moins d'appétit. Ses règles ont débuté il y a une année et sont maintenant régulières. Autrement l'anamnèse est sans particularité. L'examen physique ne révèle aucune anomalie à part une discrète pâleur. Vous effectuez une prise de sang capillaire qui montre:
hémoglobine 10 g/dl (norme: 12-16)
erythrocytes 3 G/ μ l (norme: 4-5.3)
MCV 75 fl (norme: 80-100)
réticulocytes 0.1 % (norme: 0.5-2.5)
thrombocytes 285 G/l (norme: 150-450)
leucocytes 5.2 G/l (norme: 3-12.5)
Quelle est la prochaine étape de la prise en charge?
- a l'investigation d'une anémie ferriprive
 - b un test de dépistage des drogues
 - c le dosage des paramètres infectieux
 - d une biopsie de moelle
 - e le dosage de la vitamine B₁₂ et de l'acide folique
183. A la suite d'une réaction cutanée après une piqûre d'insecte au niveau de la hanche gauche, un homme de 33 ans a observé l'apparition d'un rougeur inflammable (voir figure). Il s'étendait lentement et n'était pas accompagné d'autres symptômes.



Le traitement de cette dermatose se fait par des

- a antibiotiques
- b antimalariques
- c corticostéroïdes par voie générale
- d rétinoïdes
- e compresses humides

184. Une plaie avec perte cutanée de la surface d'une paume de la main au niveau de la jambe droite a été correctement débridée. L'évolution s'est effectuée sans complication. Vous aimeriez fermer la plaie en seconde intention 6 jours après le débridement. Quelle mesure faut-il prendre en cas de chirurgie de catastrophe?
- a une suture primaire retardée
 - b une suture secondaire après excision des berges de la plaie
 - c une plastie étendue par lambeau de rotation
 - d une plastie avec transplants de peau mince (plastie selon Thiersch)
 - e une plastie en cross-leg
185. Dans une publication sur la coqueluche, on trouve l'affirmation suivante: "50 % des membres de la famille du cas index ont également présenté une coqueluche pendant les 2 semaines suivantes". Dans ce cas, quelle mesure épidémiologique est désigné par la valeur 50 %?
- a l'incidence
 - b le taux d'infection secondaire
 - c la prévalence
 - d le rapport des cotes (odds ratio)
 - e le risque attribuable
186. En examinant des apprentis, vous trouvez chez un homme de 17 ans les résultats suivants:
taille 176 cm, poids 68 kg, extrémités longues
intelligence normale, voix masculine
pilosité pubienne forte, barbe peu abondante
discrète gynécomastie bilatérale
pénis normal, très petits testicules (2 cm^3).
A quel diagnostic faut-il penser en premier lieu?
- a une puberté tardive constitutionnelle
 - b le syndrome de Klinefelter
 - c une cryptorchidie bilatérale
 - d un prolactinome
 - e l'abus de cannabis
187. Un de vos patients de longue date vous consulte dans votre cabinet de médecine générale. Il fume et il souffre d'une bronchite asthmatiforme avec emphysème. Il n'a encore jamais envisagé sérieusement d'arrêter de fumer, mais il veut bien essayer, si vous pouvez l'y aider avec un médicament efficace. Laquelle des affirmations suivantes est correcte pour ce patient?
- a Arrêter de fumer pourrait contribuer à ralentir l'évolution du syndrome obstructif chronique.
 - b Arrêter de fumer pourrait contribuer à la régression des lésions emphysémateuses.
 - c Arrêter de fumer le plus rapidement possible est important parce qu'une réaction de type allergique à la nicotine peut accélérer l'évolution défavorable du syndrome obstructif chronique.
 - d Arrêter de fumer contribue à une amélioration de sa qualité de vie mais pas de son espérance de vie.
 - e Arrêter de fumer ne contribuera pas à améliorer sensiblement son état de santé parce qu'il n'est pas possible de modifier l'évolution d'un syndrome obstructif chronique établi.

188. Un patient de 32 ans présente depuis plusieurs semaines une rhinorrhée aqueuse bilatérale, une obstruction nasale et des salves d'éternuement.
Quelle est la première investigation?
- a un CT-scan des sinus paranasaux
 - b une épipharyngoscopie
 - c un bilan allergologique
 - d un frottis de nez
 - e un prélèvement de sécrétions nasales pour exclure une liquorrhée
189. Un homme de 70 ans vous consulte, accompagné d'une assistante de vie. Elle raconte qu'il atteint de démence depuis quelques années. Il y a deux semaines, on a constaté chez lui une incertitude à la marche, ainsi qu'une incontinence urinaire.
Quelle est la maladie la plus probable?
- a une hydrocéphalie à pression normale avec réabsorption défectueuse
 - b une insuffisance vertébro-basilaire
 - c une sclérose en plaques
 - d un syndrome de Guillain-Barré
 - e une méningite basale
190. Un travailleur de 55 ans, employé dans une entreprise chimique, consulte son médecin de famille avec les plaintes et les signes suivants: fatigue croissante depuis quelques semaines, nausées notamment en présence d'odeurs de cuisine, inappétence et douleurs abdominales hautes. Les transaminases (AST/ALT) sont fortement élevées. En raison d'un épisode de bronchite, il a été traité récemment par un antibiotique dont il ne se souvient pas du nom.
Quelle démarche diagnostic est indiqué en premier lieu?
- a prendre une anamnèse sur la consommation d'alcool, y compris le questionnaire CAGE
 - b prendre l'inventaire précis des composés chimiques auxquels il est exposé
 - c obtenir des données précises sur les médicaments consommés au cours des 6 derniers mois
 - d prendre une anamnèse sexuelle
 - e questionner le patient sur sa consommation de champignons durant les dernières semaines
191. Un adolescent de 15 1/2 ans est adressé à la consultation d'endocrinologie pour petite taille. Sa courbe de croissance montre une croissance staturale progressive entre - 1 DS et - 2 écarts types (entre le 25^e et le 3^e percentile) de 3 à 12 ans. Sa taille actuelle est de 153 cm (- 2.5 écarts types, au-dessous du 3^e percentile) et son poids de 39 kg (normal pour sa taille). Son âge osseux est de 13 ans. A l'examen clinique, il ne présente aucun signe de puberté. Son père mesure 169 cm, a présenté son pic de croissance pubertaire vers 16 ans et s'est rasé à 18 ans. Sa mère mesure 163 cm, et a présenté sa ménarche à 15 ans.
Quel est le diagnostic le plus probable?
- a une petite taille constitutionnelle et un retard pubertaire simple
 - b un hypogonadisme hypergonadotrope (syndrome de Klinefelter)
 - c un hypogonadisme hypogonadotrope
 - d une hypothyroïdie acquise
 - e une insuffisance en hormone de croissance
192. Une jeune fille de 13 ans est au 3^e percentile pour le poids et la taille. Elle présente une pilosité pubienne débutante et un développement mammaire bilatéral débutant. Les premières règles ne sont pas encore apparues. Le père est au percentile 75 pour la taille et la mère au percentile 50.
Quel est le diagnostic le plus probable?
- a un retard simple du développement
 - b l'anorexie
 - c le syndrome adrénogénital
 - d le syndrome de Turner (XO)
 - e une insuffisance hypothalamo-hypophysaire (craniopharyngéome)
193. Une femme de 40 ans a subi une fracture (voir Figure 1) lors d'un accident de la circulation. Cette lésion a été traitée primairement au moyen d'ostéosynthèse par plaque. Par la suite, des difficultés de guérison de la cicatrice opératoire sont apparues ainsi qu'une discoloration noirâtre de l'extrémité des orteils I-III (voir figure 2). Jusqu'au moment de l'accident, la patiente était en bonne santé et l'on ne relevait pas de claudication notable.



Quelle est l'étiologie la plus probable de ces troubles?

- a la gangrène (*Clostridium perfringens*)
- b une contusion traumatique de l'extrémité des orteils I-III
- c le syndrome ischémique aigu par lésion de l'artère poplitée
- d le syndrome des loges avec ischémie périphérique
- e une embolie artérielle périphérique

194. On désire étudier l'effet de la fumée pendant la grossesse sur la taille des nouveau-nés. La taille moyenne observée chez les nouveau-nés de 50 mères fumeuses choisies au hasard est de 503 mm. Celle observée chez 80 enfants de mères non fumeuses est de 509 mm.

Quelle est la conclusion correcte concernant la relation entre la fumée et la taille du nouveau-né?

- a Elle est statistiquement significative et médicalement significative.
- b Elle est statistiquement significative mais médicalement non significative.
- c Elle est statistiquement non significative.
- d Il n'est pas possible de dire si elle est statistiquement significative, car il faut connaître aussi les variances.
- e Il n'est pas possible de dire si elle est significative, car les échantillons sont trop petits.

195. Chez un garçon de 5 ans se développent en 2 à 4 semaines une parésie du sixième nerf crânien, une ataxie avec dysmétrie, un nystagmus, des vomissements matinaux et des maux de tête.

Quel est le diagnostic le plus probable?

- a une encéphalopathie d'origine mitochondriale
- b un abcès cérébral otogène
- c un médulloblastome du cervelet
- d un craniopharyngéome suprasellaire
- e une encéphalite du tronc cérébral

196. Chez un homme de 56 ans, vous investiguez une tuméfaction cervicale gauche indolore: une ponction à l'aiguille fine révèle des cellules d'un carcinome épidermoïde. La recherche d'une tumeur primitive reste négative à l'examen clinique ORL.

Quel est l'examen en suite le plus approprié?

- a une scintigraphie osseuse
- b une scintigraphie tumorale
- c une panendoscopie supérieure
- d une excision du ganglion
- e une échographie thyroïdienne

197. Un homme de 20 ans se présente avec des lésions palmaires non-prurigineuses (voir figure). Auparavant, le patient a présenté un exanthème passager également non prurigineux.

Qu'est-ce qui est indiqué en premier lieu?



- a un traitement d'épreuve de courte durée avec une crème à la cortisone
- b une culture mycologique
- c un examen histologique
- d un examen sérologique
- e des tests épicutanés

198. Une femme de 62 ans en bonne santé habituelle se pique la face palmaire de l'index en soignant ses rosiers. Le lendemain, la patiente observe une tuméfaction douloureuse de son doigt, ce qui l'amène à consulter. Le médecin observe un index inflammatoire dont la palpation de la base est douloureuse et sa mobilisation quasi impossible en raison de la douleur. Le diagnostic le plus probable est
- a une réaction allergique
 - b la présence d'un corps étranger
 - c une lésion d'un nerf collatéral
 - d un panaris pulpaire
 - e un phlegmon de la gaine des fléchisseurs
199. Un homme âgé de 35 ans tombe de cheval sans perte de connaissance et présente ensuite des céphalées modérées. 10 jours plus tard, un état confusionnel et une hémiplégie apparaissent en l'espace de 24 heures. Quel est le diagnostic le plus probable?
- a un hématome épidural
 - b un ictus apoplectique
 - c une méningo-encéphalite après une fracture du crâne non diagnostiquée
 - d un hématome sous-dural
 - e une thrombose du sinus veineux
200. Un homme de 52 ans consulte en raison d'une obstruction nasale unilatérale, d'un écoulement nasal sanguinolent et des douleurs sous-orbitaires. A quoi faut-il penser en premier lieu?
- a un papillome nasal
 - b un angiofibrome juvénile
 - c une sinusite à répétition
 - d une tumeur maligne de l'éthmoïde
 - e une polypose nasosinusienne chronique
201. Un homme de 48 ans se plaint d'une protrusion progressive de son oeil droit depuis 4 mois, alors que son état général est bon. A l'examen de l'oeil droit, on note une exophtalmie nette, une limitation de la motilité du globe oculaire dans toutes les directions, un ptosis et une hypoesthésie cornéenne. L'acuité visuelle et le champ visuel de l'oeil droit sont normaux. Quel est le diagnostic le plus probable?
- a une tumeur mixte de la glande lacrymale
 - b une tumeur siégeant au niveau de la fente sphénoïdale
 - c une thrombophlébite du sinus caverneux
 - d un neurofibrome du nerf optique
 - e une tumeur de l'hypophyse

202. Un homme de 24 ans consulte pour une déchargeaison dans l'oreille droite. Veuillez regarder l'image de l'otoscopie ci-jointe.



Quel est le diagnostic le plus probable?

- a une otite moyenne aiguë perforée
- b un zona otique
- c une otite externe mycotique
- d un cholestéatome
- e un eczéma du conduit auditif externe

203. Un homme de 44 ans se plaint de voir, depuis la veille, devant son oeil droit une sorte de petite toile d'araignée noirâtre qui flotte lors des mouvements oculaires.

Que voit-il?

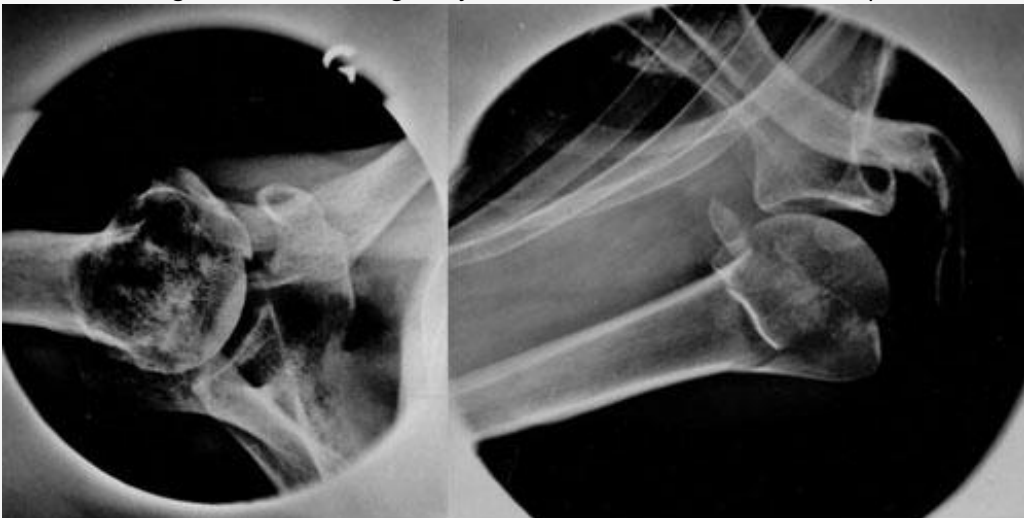
- a une hémorragie du corps vitré
- b une hémorragie dans la chambre antérieure
- c une cataracte subluxée
- d une rétine soulevée
- e ses propres vaisseaux rétinien

204. Un homme de 23 ans consulte en raison de saignement de nez répétitif. La rhinoscopie antérieure montre une perforation du septum antérieur.

A quoi faut-il penser en premier lieu?

- a la granulomatose de Wegener
- b la consommation de drogue (sniff)
- c une diathèse hémorragique aiguë
- d une hypertension artérielle
- e un lymphome à cellules T

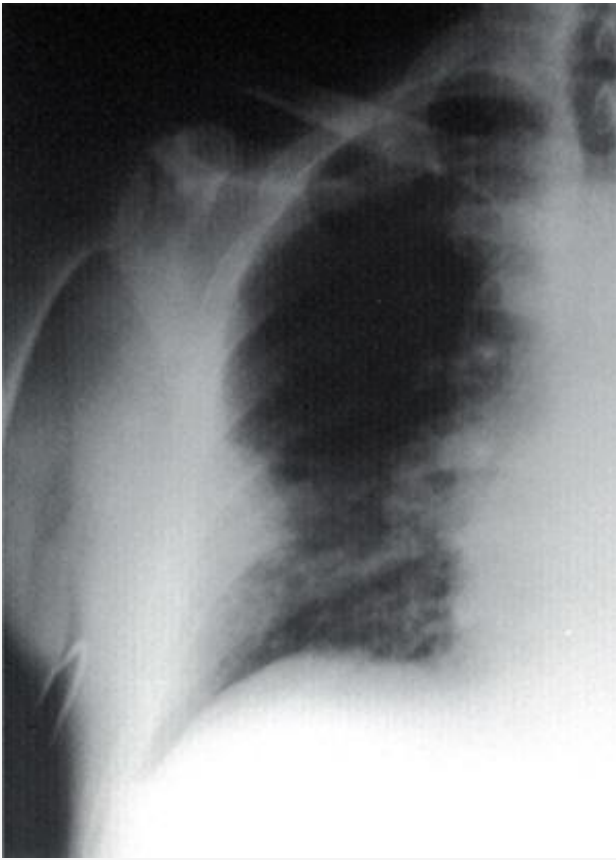
205. Veuillez regarder les deux images ci-jointes d'une fracture de l'extrémité proximale de l'humérus.



Cette fracture est le mieux décrite comme une fracture sous-capitale

- a engrenée en valgus
- b engrenée en varus
- c avec arrachement du trochiter

- d sans déplacement des fragments principaux
 - e à 4 fragments: tête, diaphyse, trochiter et trochin tubercule majeur et tubercule mineur
206. Une femme de 40 ans présente des hémorragies de privation régulières sous contraception hormonale à prédominance gestagénique. Vous palpez dans la région annexielle droite une masse mobile, indolore, aux contours réguliers et d'un diamètre de 10 cm. Un examen ultrasonographique montre la présence d'un kyste multi-loculaire. Quelle démarche est indiquée?
- a une laparoscopie
 - b un frottis cytologique du col avec curetage explorateur
 - c un contrôle ultrasonographique annuel pour objectiver la constatation
 - d un traitement cytostatique
 - e ni investigation complémentaire ni traitement, mais seulement un contrôle annuel
207. On se propose d'étudier le rôle du tabagisme en rapport avec le cancer bronchique. C'est pour ça qu'on fait deux groupes de personnes: un groupe constitué par tous les malades atteints de cancer bronchique figurant dans un registre et un groupe de même grandeur de sujets non atteints par cette affection. Le groupe de sujets indemnes est constitué de façon à ce que pour chaque malade, on choisisse un individu sain ayant les mêmes caractéristiques d'âge, de sexe, socio-professionnelles, etc. Cette méthode constitue en épidémiologie
- a un sondage
 - b un échantillon représentatif
 - c un appariement
 - d une standardisation
 - e une étude en double aveugle
208. Après quelques jours d'une rhinite séreuse, un nourrisson de 3 mois, n'ayant reçu aucune vaccination préalable, développe un syndrome de détresse respiratoire progressif avec polypnée et gêne expiratoire. Le compte leucocytaire de même que la répartition sont dans les limites normales. Quel est le diagnostic le plus probable?
- a un faux croup
 - b une pneumonie à Chlamydia
 - c une bronchiolite
 - d une coqueluche
 - e une pneumopathie de Mikity-Wilson
209. Une jeune femme de 16 ans vient à votre consultation et se plaint d'une toux principalement nocturne, sans sécrétion de mucus et d'une dyspnée depuis 3 semaines. Elle nie la présence de fièvre ou de douleurs. Néanmoins, elle a éprouvé des symptômes semblables de moindre intensité il y a un an, également au printemps. Pour confirmer la suspicion diagnostique qui s'impose, quel examen est le plus approprié?
- a une bronchoscopie
 - b une spirométrie
 - c une radiographie du thorax
 - d un test d'effort
 - e la formule sanguine
210. Une femme obèse de 60 ans, qui s'est toujours sentie en bonne santé, se réveille un matin tôt avec une dyspnée rapidement progressive. Le jour suivant, elle ressent des douleurs thoraciques droites. Elle est afebrile. A l'examen clinique, vous constatez une tachypnée et vous auscultez un frottement localisé à la région douloureuse. Veuillez regarder l'image ci-jointe de la radiographie thoracique.



Quel est le diagnostic de présomption?

- a un pneumothorax
- b une embolie pulmonaire aiguë avec infarctus pulmonaire
- c un carcinome bronchique avec atélectasie par obstruction
- d une pneumonie virale
- e une métastase pulmonaire d'une tumeur primaire d'origine inconnue avec épanchement pleural

211. Un homme de 40 ans, connu pour une insuffisance rénale chronique avec une diurèse conservée, est opéré d'une fracture ouverte du tibia.

Parmi les analgésiques ou anesthésiques suivants, lequel est particulièrement **contre-indiqué**?

- a le fentanyl
- b la buprénorphine
- c le diclofénac
- d le paracétamol
- e la bupivacaïne

212. Un homme de 25 ans est admis aux urgences pour une douleur de la fosse iliaque droite. Le status clinique et les examens biologiques font poser le diagnostic d'une crise d'appendicite aiguë non perforée. Le patient va être opéré sous anesthésie générale. Parmi les éléments de monitoring décrits ci-dessous, lequel s'avère **superflu**?

- a la pression artérielle non invasive
- b la pression artérielle invasive
- c la saturation en oxygène
- d la fraction expirée de CO₂
- e la fraction inspirée d'oxygène

213. Un imprimeur de 25 ans est chasseur dans ses moments de loisir. A la suite d'une mauvaise manipulation de fusil par un ami, il reçoit de la grenaille de plomb dans les fesses. L'homme se rétablit rapidement. Environ deux mois plus tard, il se sent fatigué, présente quelques crampes abdominales et a mal à la hanche gauche. Au travail, il a dû faire des heures supplémentaires, souvent de nuit, pour imprimer des catalogues de mode par procédé offset.

Un examen raisonnable comprend:

- +/- a la ponction et l'analyse du liquide synovial de la hanche gauche
- +/- b une plombémie
- +/- c le taux de mercure urinaire
- +/- d une visite du poste de travail par la suva

214. Dans une entreprise de l'industrie chimique, une étude sur 100 postes de travail devant un écran (ordinateur), auxquels les collaborateurs travaillaient 3 heures par jour ou plus, a montré qu'un pourcentage élevé de ceux-ci se plaignaient de troubles.

40 % se plaignaient de brûlures oculaires et de fatigue en fin de journée.

46 % se plaignaient de douleurs dans la nuque.

17 % avaient des céphalées plus fréquentes, mises sur le compte du travail à l'écran.

17 % attribuaient leurs douleurs dorso-lombaires à la place de travail.

20 % se plaignaient de douleurs des épaules provenant du travail à l'écran.

9 % se plaignaient de douleurs du poignet à droite, 3 % respectivement à gauche.

En tant que médecin du travail qualifié de cette entreprise, que devez-vous proposer pour réduire la fréquence des plaintes?

- +/- a mettre des filtres anti-champs électromagnétiques à disposition des collaborateurs présentant des douleurs oculaires et des céphalées
- +/- b effectuer un examen de l'acuité visuelle des collaborateurs présentant des problèmes oculaires et des céphalées
- +/- c enseigner aux collaborateurs les attitudes ergonomiques à la place de travail
- +/- d donner une formation approfondie aux collaborateurs responsables de l'achat du mobilier ainsi qu'à ceux qui sont chargés de l'aménagement des places de travail

215. Un employé de banque de 37 ans a prévu de faire un voyage de 3 semaines dans la forêt tropicale d'Amérique du Sud. Il est en bonne santé. Il ne souffre pas d'allergies ni de maladies neuro-psychiatriques.

Que faut-il lui recommander?

- +/- a la protection contre les moustiques, vu le risque de paludisme et de dengue
- +/- b la vaccination contre le choléra
- +/- c la vaccination contre la fièvre jaune
- +/- d d'éviter tout contact avec des chiens errants

216. Un diabétique de 53 ans, connu depuis plus de 10 ans, vous consulte pour une tuméfaction du pied indolore. A l'examen, vous constatez une tuméfaction rouge de la base du gros orteil, qui présente une hyperkératose épaisse sous l'articulation métatarso-phalangienne. La rougeur et la tuméfaction remontent sur le dos du pied jusqu'au delà de la cheville.

Qu'est-ce qu'il-faut envisager pour le diagnostic différentiel?

- +/- a une crise de goutte
- +/- b une crise de chondrocalcinose
- +/- c une arthrite septique MP1
- +/- d la lymphangite

217. Une enquête cas-témoins a donné les résultats suivants:

(voir image)

$\chi^2 = 7.62$ ($p < 0.01$)

	infarctus du myocarde +	infarctus du myocarde -
éthylisme chronique +	71	52
éthylisme chronique -	29	48

Que signifie " $p < 0.01$ " dans ce contexte?

- +/- a La fréquence de l'éthylisme est significativement plus élevée dans le groupe de malades atteints d'un infarctus du myocarde.
- +/- b Il existe une corrélation significative entre l'infarctus du myocarde et l'éthylisme chronique.
- +/- c Il existe un biais significatif de mesure.
- +/- d Il existe un biais significatif de sélection.

218. Chez un malade de 20 ans de petite taille, ayant des diarrhées depuis des semaines, on trouve dans le sang des valeurs abaissées pour les protéines, le calcium et le cholestérol. En plus, la phosphatase alcaline est augmentée et le temps de prothrombine est prolongé. Il existe une stéatorrhée.

La prochaine investigation qui s'impose sera

- a un lavement baryté
- b une biopsie du grêle
- c une coeliacographie
- d un test à la sécrétine-pancréozymine
- e un examen bactériologique des selles

219. Un homme de 23 ans a fait une chute importante sur son flanc droit en faisant du surf des neiges. Sa 11^e côte est cassée et il présente un épanchement pleural peu important. Son sédiment urinaire montre une hématurie à ++++. Au CT, on observe une lésion sur le bord extérieur du pôle supérieur de son rein droit avec un important hématome limité par la capsule de Gerota. Sa tension artérielle est stable.

Quelle est la marche à suivre?

- a une opération avec l'objectif d'une néphrectomie pour éviter une hypertension artérielle posttraumatique
- b une opération avec l'objectif d'une néphrectomie partielle pour éviter l'infection posttraumatique
- c pratiquer une angiographie avec embolisation
- d observer l'évolution qui est le plus souvent bénigne
- e observer l'évolution en préparant une chirurgie secondaire qui est le plus souvent indispensable

220. Une femme de 28 ans vous consulte à cause de douleurs récidivantes des grandes et petites articulations qui sont légèrement enflées, ainsi que d'une fatigue générale. Cette symptomatologie dure depuis environ 1 année 1/2. Radiologiquement, les articulations sont normales.

Valeurs de laboratoire:

vitesse de sédimentation 60 mm/h (norme: < 25)

hémoglobine 6.8 mmol/l (norme: 7.4-9.9)

valeurs érythrocytaires normales

Le diagnostic le plus vraisemblable est

- a un lupus érythémateux disséminé
 - b la maladie de Reiter
 - c la chondrocalcinose
 - d une polymyalgie rhumatique
 - e la goutte
221. Une fille, née à terme avec un poids de naissance de 3000 g et une anamnèse périnatale sans particularité, pèse à 6 mois 4700 g. La mère la nourrit au sein complètement et sans supplément.
Quelle mesure doit être prise en premier?
- a une biopsie intestinale pour exclure une malabsorption
 - b une électro-encéphalographie pour détecter une anomalie du développement cérébral
 - c un ultrason cérébral pour exclure une hydrocéphalie
 - d un test à la sueur pour exclure une mucoviscidose
 - e une évaluation de la quantité de lait prise au sein
222. Chez un garçon de 14 ans on trouve une fièvre et une amygdalite caractérisée par la présence de membranes gris-blanchâtres, qu'on peut facilement détacher. Il a des lymphadénopathies généralisées, un exanthème maculo-papulaire, une augmentation des lymphocytes et monocytes dans la formule sanguine.
Quel est le diagnostic le plus probable?
- a une leucémie aiguë
 - b une infection à VIH
 - c la diphtérie
 - d la scarlatine
 - e une mononucléose infectieuse
223. Une éthilique de 60 ans avait subi, il y a 4 ans, une cholécystectomie pour cholécystolithiase. Il y a 8 jours, elle a présenté une douleur épigastrique aiguë suivie d'un frisson et d'une fièvre à 40 °C. 24 heures après le frisson, un ictère s'est manifesté mais a disparu après 3 jours. Par la suite la patiente est restée afebrile.
La cause la plus vraisemblable de cette maladie est
- a un abcès hépatique
 - b une migration lithiasique du cholédoque
 - c une hépatite éthylique aiguë
 - d une pancréatite aiguë
 - e un kyste pancréatique surinfecté
224. Un homme de 60 ans consulte les urgences pour l'apparition subite il y a 2 jours de douleurs lancinantes touchant la région orbitaire gauche et le front à gauche. Ces douleurs s'accompagnent d'un état de fatigue, de malaise et, depuis veille, d'une peau rougie au niveau des régions temporale et frontale gauches. L'anamnèse familiale est sans particularité, exception faite d'une visite, il y a 2 semaines, chez une nièce de 7 ans atteinte d'une maladie infantile. L'examen clinique montre un placard érythémateux avec des vésicules à liquide clair groupées en bouquets et quelques croûtes sur le front et la paupière à gauche s'arrêtant à la ligne médiane. Le malade doit cligner de l'oeil de façon répétée, et son oeil gauche est rouge et larmoyant. Sa température s'élève à 38 °C.
Quelle démarche diagnostique est indiquée pour déterminer le traitement adéquat?
- a une formule sanguine complète, des paramètres inflammatoires et des sérologies virales
 - b un status ophtalmologique avec examen à la lampe à fente
 - c une biopsie cutanée
 - d une ponction lombaire
 - e un CT cérébral
225. Un petit garçon de 4 ans est amené chez son pédiatre car il refuse de marcher depuis qu'il s'est levé ce matin. La semaine passée, il a présenté une infection des voies aériennes supérieures. Il a joué au football la veille. Sa température est de 37.2 °C. Son status est dans la norme à part une limitation douloureuse de l'abduction et de la rotation externe de la hanche droite. Sa formule sanguine montre: leucocytes 11.2 G/l (norme: 4.5-11) avec 6 % de neutrophiles non segmentés. La CRP est à 90 mg/l (norme: <<10). L'ultrasonographie de la hanche montre un épanchement intra-articulaire de faible importance.
Quel est le diagnostic le plus probable?
- a une arthrite septique
 - b la maladie de Perthes
 - c une synovite transitoire de la hanche
 - d une arthrite chronique juvénile
 - e le sarcome d'Ewing
226. Un homme de 55 ans consulte en raison d'une dyspnée croissante et d'une somnolence diurne. A l'examen clinique, vous notez une obésité (poids 130 kg, taille 173 cm), une cyanose centrale et une auscultation cardio-pulmonaire sans particularité. La radiographie thoracique est normale. résultats de la spirométrie:
volume expiré maximal à la 1^{re} seconde (VEMS₁) 78 % de la valeur prédite
capacité vitale forcée (CVF) 80 % de la valeur prédite
résultats de la gazométrie artérielle:
pO₂ 54 mmHg (norme: 80-100)
pCO₂ 60 mmHg (norme: 35-45)
pH 7.37 (norme: 7.38-7.44)
bicarbonate 29 mmol/l (norme: 21-28)
Quel traitement est à envisager en premier lieu?

- a l'inhalation des bronchodilatateurs de long durée
 - b une thérapie systémique avec de l'acétazolamide
 - c une thérapie systémique avec des corticostéroïdes
 - d une ventilation à pression positive non invasive et nocturne
 - e une oxygénothérapie permanente pendant 16 de 24 heures
227. Une femme de 40 ans présente depuis une année les symptômes suivants: aménorrhée, augmentation du poids de 6 kg, faiblesse des jambes, discrète hypertension artérielle et léger diabète sucré. Lequel des examens suivants a le plus de chance de contribuer au diagnostic?
- a l'anamnèse alimentaire
 - b la détermination de la TSH et le fT4 plasmatique
 - c la détermination de la LH et de la FSH plasmatiques après administration de GNRH (LHRH)
 - d les 17-cétostéroïdes dans les urines de 24 h
 - e le cortisol libre dans les urines de 24 h
228. Une fille nouveau-née présente dès les premières heures de vie une hypersialorrhée avec de la mousse blanche devant la bouche. De plus, elle tousse occasionnellement, devient bleu et récupère chaque fois rapidement. La fréquence respiratoire est de 40/min. A l'auscultation des poumons et de la trachée, on entend des râles bulleux. Quel est le diagnostic le plus probable?
- a une atrésie de l'oesophage
 - b la mucoviscidose
 - c un oedème pulmonaire
 - d une cardiopathie congénitale
 - e l'aspiration massive de liquide amniotique
229. Un patient de 40 ans, chauffeur de profession, en bonne santé habituelle, consulte son médecin en raison de l'apparition progressive d'une sensation de picotements désagréables dans le 4^e et 5^e doigt de la main droite. Quel est le diagnostic le plus probable?
- a une thrombose de l'artère humérale
 - b l'hypersensibilité au froid
 - c un trouble statique de la colonne cervicale
 - d le syndrome du tunnel carpien
 - e le syndrome compressif du nerf cubital au coude
230. Un homme de 35 ans consulte l'ophtalmologue et se plaint de voir devant lui "un voile sombre s'agrandissant vers le haut" depuis 12 heures. 2 semaines auparavant, il avait remarqué des éclairs. Quel est le diagnostic le plus vraisemblable?
- a un décollement postérieur du corps vitré
 - b une occlusion de l'artère centrale de la rétine
 - c une inflammation du nerf optique
 - d une hémorragie vitréenne
 - e aucune des pathologies susmentionnées
231. Une étudiante de 22 ans travaille comme vendeuse dans un magasin de mode. Son temps de travail représente 12 heures hebdomadaires. Un dimanche de congé, en skiant, elle subit une fracture du tibia. Les frais de traitement seront pris en charge par
- a l'assurance responsabilité des remontés mécaniques
 - b l'assurance-accidents obligatoire de l'université
 - c l'assurance-accidents obligatoire du magasin de mode
 - d l'assurance-accidents complémentaire de l'assurance maladie
 - e l'assurance-maladie subsidiaire
232. A la fin de leur article, les auteurs d'une étude ont indiqué que "77 % des femmes de moins de 45 ans ayant souffert d'un infarctus du myocarde ne prenaient pas de contraceptif oral au moment du diagnostic de l'infarctus". Quel interprétation peut-on donner de ce message?
- a La prévalence de prise de contraceptifs oraux était de 23 % au moment du diagnostic d'infarctus du myocarde chez les femmes ayant moins de 45 ans.
 - b 23% des infarctus du myocarde survenus chez des femmes de moins de 45 ans sont attribuables à la prise de contraceptifs oraux.
 - c L'incidence d'infarctus du myocarde a été de 23 % chez les participantes à l'étude n'ayant pas pris de contraceptifs oraux.
 - d La proportion de femmes prenant un contraceptif oral était de 23 % plus élevée chez les femmes de moins de 45 ans ayant souffert d'un infarctus du myocarde que chez celles qui n'ont pas souffert d'infarctus.
 - e Aucune des interprétations précédentes n'est correcte.
233. Chez les personnes de plus de 85 ans, les maladies cardio-vasculaires restent la principale cause de décès dans les sociétés industrielles modernes. En Suisse, qu'est-ce qui est correct concernant les maladies cardio-vasculaire?
- +/- a La Suisse a la mortalité par cardiopathies ischémiques la plus élevée au niveau international.
 - +/- b En Suisse, durant les 40 dernières années, la mortalité par maladies cardiovasculaires a augmenté pour les deux sexes.
 - +/- c La mortalité par maladies cardiovasculaires a évolué parallèlement dans les pays de l'Europe de l'Est et de l'Ouest.
 - +/- d En général, c'est le tabagisme qui est associé au risque attribuable le plus élevé pour les maladies cardio-vasculaires.

234. 60 secondes après la naissance, un garçon nouveau-né à terme présente les symptômes suivants: un cri faible, une fréquence cardiaque entre 120-140/min, une respiration lente et irrégulière, une légère flexion des extrémités, il réagit faiblement lorsqu'une sonde est placée pour aspirer le nez et la bouche des extrémités cyanosées. Son score Apgar est de:
- 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
235. Un homme de 45 ans se plaint d'une perte progressive de la vision à l'œil droit. L'opticien ne peut améliorer l'acuité visuelle à l'aide de lunettes de manière significative. Le patient ne présente aucune autre plainte et est par ailleurs en bonne santé. Au status, l'ophtalmologue mesure une acuité visuelle sans correction à droite de 0.15 et à gauche de 1.0. L'examen du champ visuel met en évidence un scotome central relatif à droite et un champ visuel normal à gauche. La pression intra-oculaire est normale des deux côtés. La sensibilité cornéenne est diminuée à l'œil droit et normale à l'œil gauche. La mesure à l'aide de l'exophtalmomètre de Hertel met en évidence une légère exophtalmie à droite. Quel est le diagnostic le plus probable?
- un glaucome chronique simple droit
 - une névrite optique droite sur une encéphalomyélite disséminée
 - un méningiome de la grande aile du sphénoïde droit
 - une thrombophlébite du sinus caverneux
 - un syndrome de Gradenigo droit
236. Une fillette de 5 ans dystrophique et avec un hippocratisme digital, souffre depuis 2 ans d'une toux récidivante. Elle expectore des sécrétions muqueuses, parfois purulentes, surtout le matin et elle a parfois des poussées fébriles. Quel est le diagnostic le plus vraisemblable?
- la tétralogie de Fallot
 - une tuberculose pulmonaire caverneuse
 - un kyste pulmonaire congénital
 - une sarcoïdose pulmonaire
 - la mucoviscidose
237. Une femme de 50 ans déclare que depuis 3 mois elle souffre d'une petite lésion persistante de la commissure labiale gauche, qui est de temps en temps couverte d'une croûte. À l'examen, vous trouvez un ulcère fissuré de la grosseur d'un petit pois sur le rebord labial. Dans la région sous-mentonnière, vous palpez un ganglion lymphatique de la grosseur d'un haricot, mobile, dur, mais indolore. Quel est le diagnostic le plus vraisemblable?
- un carcinome basocellulaire
 - un carcinome spinocellulaire
 - le syndrome de Plummer-Vinson
 - une cheilite avec rhagades
 - un ulcère syphilitique
238. Vous suivez une patiente de 62 ans pour une hypertension bien équilibrée sous diltiazem et un léger diabète de type 2 équilibré sous glimépiril. Elle reçoit également de son psychiatre du lithium pour un trouble bipolaire en rémission depuis 3 ans. Lors d'un contrôle, elle se plaint d'un tremblement de repos en augmentant, qui occasionne des maladroites et des lâchages d'objets. Quelle est l'attitude correcte?
- faire un traitement d'essai par lévodopa pour exclure une maladie de Parkinson débutante
 - remplacer la prescription de diltiazem par un inhibiteur de l'enzyme de conversion (p.ex. l'énalapril)
 - adjoindre un bêta-bloquant (p.ex. le propranolol) pour agir sur le tremblement de type central
 - adjoindre un diurétique tel que la chlorthalidone pour améliorer l'excrétion de lithium
 - demandeur une mesure de lithémie et réajuster la posologie du lithium selon le résultat
239. Une fille de 10 mois est amenée à votre cabinet médical car elle vomit et a de la diarrhée depuis 2 jours. Elle vomit chaque fois que sa mère essaie de la nourrir et a eu 8 selles liquides durant les dernières 24 heures. Sa température est de 38.2° C. Elle pèse 8.5 kg. Sa mère dit qu'elle pesait 9.4 kg il y a une semaine. Sa fréquence respiratoire est de 45/min, sa fréquence cardiaque est de 120/min, et sa tension artérielle est de 75/45 mmHg. Elle n'a pas de larmes quand elle pleure, elle est apathique et sa langue est sèche. Dans la prise en charge de cette fille, quel est le traitement le plus approprié?
- la réhydratation orale avec une solution de réhydratation
 - la perfusion de glucose 10 %
 - le traitement antibiotique
 - un inhibiteur du péristaltisme (antidiarrhéique)
 - la perfusion de NaCl 0.9 % ou de Ringer lactate
240. Suite à un accident, un cycliste d'une soixantaine d'années est emmené aux urgences. Votre examen clinique conclut à un traumatisme isolé mais sévère du thorax droit. Il est choqué et cyanosé, dyspnéique et hypotendu. À l'auscultation, la plage droite est muette. Laquelle des mesures suivantes est la mieux adaptée?
- une gazométrie artérielle
 - l'intubation trachéale
 - une radiographie du thorax
 - un drainage pleural d'emblée
 - un CT-scanner thoracique
241. Un homme de 64 ans se présente à votre consultation avec un nodule près du nez, qu'il a remarqué depuis une année (voir figure [manquante]). Quelle est la mesure la plus importante à prendre?

- a une anamnèse plus approfondie
 - b la palpation du nodule
 - c une dermatoscopie
 - d une biopsie
 - e une excision avec une marge de sécurité de 2 cm
242. Un garçon de 6 ans présente depuis un mois un torticolis. Il n'y a pas de plaintes subjectives et il est afébrile. Pas de notion de traumatisme dans l'anamnèse. Quel est le diagnostic le plus probable?
- a une polyarthrite rhumatoïde
 - b un torticolis oculaire
 - c une tumeur cérébrale
 - d une malformation de la colonne cervicale
 - e une problématique psychologique
243. Une campagne visant la promotion de l'activité physique est envisagée dans une grande ville en Suisse. Vu les ressources limitées à disposition, il est décidé d'organiser cette campagne de promotion sous forme d'une grande fête « marcher c'est sain » concentré sur un week-end unique. Quelle affirmation est correcte?
- a C'est une décision raisonnable, car une grande action unique et isolée suscite d'avantage des modifications de comportement qu'une série d'actions plus modestes s'intégrant dans une campagne de longue durée.
 - b Une campagne d'information sur les dangers de la sédentarité serait plus indiquée, puisque les modifications de comportement s'obtiennent surtout par des informations qui dérangent ou qui font peur.
 - c Une fête axée sur le seul thème « marcher c'est sain » n'a pas de sens, car une action de promotion de la santé ne peut se concevoir que globalement et d'autres facteurs de risque que la sédentarité devraient être inclus dans une telle campagne.
 - d On peut espérer au mieux qu'une telle action isolée sensibilise à la problématique en question.
 - e En terme de promotion de la santé, une telle fête n'a pas de sens, car le thème « marcher c'est sain » n'attire que des fanatiques de l'activité physique.
244. Un médecin-assistant se demande s'il peut interrompre la ventilation d'un patient incurable et inconscient. Il craint l'avocat de la famille. Qu'est-ce qui s'applique à cette situation?
- +/- a Les directives sur l'assistance au décès édictées par l'Académie suisse des sciences médicales protègent de toute poursuite judiciaire
 - +/- b La volonté du patient doit toujours être respectée obligatoire.
 - +/- c En Suisse, les proches ne peuvent s'immiscer dans ces situations.
 - +/- d Avant de s'adresser à la famille, le médecin-assistant doit s'assurer que les organes peuvent être transplantés.
245. Parmi les facteurs prédisposant pour la fracture du col du fémur chez la personne âgée on trouve:
- +/- a la ménopause chez la femme
 - +/- b la malnutrition chez la personne âgée
 - +/- c une masse osseuse peu développée dans l'âge adulte jeune
 - +/- d des troubles sensoriels des extrémités
246. Une étude a pour but de mesurer la fréquence de la cirrhose hépatique dans la population d'une ville suisse. Pour cette raison, on effectue pendant une année une échographie chez tous les patients consultant la polyclinique médicale le lundi matin ou le jeudi après-midi. Lors de suspicion d'une cirrhose du foie, un ultrason est effectué. Sur les 3000 examens de patients, 57 font suspecter une cirrhose du foie. Aucun de ces patients n'est âgé de plus de 70 ans. Les auteurs en déduisent que dans la population l'incidence de la cirrhose du foie est de 19 sur 1000 et que la cirrhose du foie induit une mort prématurée. Jugez du bien-fondé des affirmations suivantes:
- +/- a Une étude transversale unique ne permet pas d'estimer l'incidence.
 - +/- b Les patients d'une polyclinique ne sont pas forcément représentatifs de la population citadine.
 - +/- c Les deux jours choisis pour l'examen ne conviennent pas.
 - +/- d Cette étude ne permet pas d'estimer la mortalité.
247. Une fillette âgée de 6 ans est emmenée à l'hôpital avec des convulsions généralisées. A l'examen clinique on note un œdème papillaire et une tension artérielle de 200/140 mmHg. Immédiatement après les convulsions, l'enfant émet quelques gouttes d'urine qui contiennent des globules rouges vieux et frais, des cylindres granuleux et des protéines à 5 g/l (norme: <150 mg/24h). Quel est le diagnostic le plus probable?
- a une méningite purulente
 - b une tumeur intracérébrale
 - c une crise d'hypoglycémie
 - d une glomérulonéphrite
 - e une intoxication à l'atropine
248. Une femme de 18 ans a souffert d'une anorexie mentale pendant 6 ans. Elle a eu un IMC entre 15 à 17 kg/m². Elle a actuellement normalisé son poids. A long terme, le médecin traitant doit rester attentif à:
- +/- a des fractures pathologiques
 - +/- b une hypothermie
 - +/- c un risque suicidaire élevé
 - +/- d une mauvaise insertion sociale
249. Veuillez regarder la figure ci-jointe [manquante]. Quelle est la thérapie de choix pour cette lésion traumatique du pavillon de l'oreille?

- a une ponction stérile
 - b une antibiothérapie per os
 - c une ponction stérile et une antibiothérapie per os
 - d une incision et une compression
 - e aucune thérapie n'est nécessaire
250. L'un de vos collègues a été chargé d'enquêter sur l'origine d'une épidémie d'intoxications alimentaires survenues parmi les 48 personnes ayant participé à un pique-nique. Il vous présente le tableau suivant des données qu'il a récolté: [figure manquante]
Quelle est la source la plus probable de l'épidémie?
- a les crevettes
 - b le poulet froid
 - c la salade russe
 - d la salade grecque
 - e la crème vanille
251. Chez un homme de 60 ans, en traitement depuis plusieurs semaines pour des douleurs articulaires, apparaissent subitement un état fébrile, des douleurs pharyngées et des adénopathies cervicales. L'examen de laboratoire montre des leucocytes à 12 G/l (norme: 4.5-11) dont 89 % de lymphocytes et 8 % de monocytes. Quel est le diagnostic ?
- a une leucémie lymphatique chronique
 - b la maladie de Hodgkin
 - c l'agranulocytose
 - d la borréliose
 - e aucune des maladies mentionnées
252. Depuis 9 mois, un homme de 30 ans est traité pour une dépression. Son traitement comporte, outre une psychothérapie, de la paroxétine. L'amélioration clinique amène le patient à interrompre le traitement médicamenteux. 4 jours après l'interruption du traitement médicamenteux, il vous consulte parce qu'il présente des vertiges, des douleurs musculaires et se retrouve excité, irritable et fébrile (40° C). La cause la plus vraisemblable de cette symptomatologie est :
- a un syndrome sérotoninergique
 - b un syndrome malin des neuroleptiques
 - c une hyperthermie maligne
 - d un syndrome de sevrage
 - e un état grippal
253. REINSERTION - Un ouvrier de chantier, espagnol de 48 ans, habite la Suisse depuis 7 ans. 11 mois après son engagement dans une société de construction, il a un accident lorsqu'il soulève une poutrelle métallique. On diagnostique une hernie discale L4/L5 avec une compression de la racine L5 gauche et pratique la résection du prolapsus discal. 3 mois après l'opération, il se plaint toujours de fortes douleurs dans la région lombaire et présente une parésie résiduelle des extenseurs du pouce du pied gauche. Ceci entraîne, comme ouvrier du bâtiment, une prolongation d'incapacité de travail à 100% et il est licencié. 9 mois plus tard, la situation est inchangée, et on peut prévoir qu'il ne pourra plus travailler sur un chantier. On lui propose une réinsertion professionnelle. Dans ce cas, une réinsertion professionnelle est à la charge de:
- a la Suva
 - b l'AI
 - c l'assurance chômage
 - d son dernier employeur
 - e lui-même

Formulations approximatives :

254. Femme de 32 ans présente depuis peu des épisodes de vertiges et céphalées. A eu à plusieurs reprises une HTA à 150/100. BSH, pas de médicaments hormis contraceptifs inhibiteur de l'ovulation conventionnel. Examen clinique sp, Examen urine, sang (hémo + chimie) sp. Démarche indiquée :
- a Change pilule contre pilule progestative + contrôles répétés de la TA.
 - b Baisse du NaCl alimentaire
 - c Prescrire un TTT de + hydrochlorothiazide (3x 1cp/j)
 - d Urographie intraveineuse
 - e Bilan endocrinologique
255. Un homme de 74 ans se présente aux urgences pour des céphalées modérées et une baisse de l'état général. Au status: état fébrile, hypoTA, tachycardie, tachypnée. Quel examen aura le plus d'impact en terme de diagnostic?
- a Rx thorax
 - b hémocultures
 - c PL
 - d analyses urinaires (stix, cultures)
 - e ...
256. Un homme de 77 ans se rend aux urgences en raison de douleurs abdominales. Il souffre d'une anurie depuis la veille. L'US confirme le diagnostic de suspicion d'une vessie hypotone par regorgement. Quel médicament est le plus probablement responsable de cette rétention urinaire ?
- a Amoxicilline

- b Bromazepam
 - c Phénytoïne
 - d Amitriptyline
 - e Hydrochlorothiazide
257. Jeune de 16 ans en BSH se présente avec douleurs épigastriques qui peu à peu migrent en FID. Nausées - vomissements. Température légèrement élevée. Cause la plus probable :
- a Reflux GO
 - b Gastroentérite virale
 - c Inf. pas Salmonella
 - d Appendicite
 - e Cholécystite
258. Un enfant de 6 ans est amené par ses parents en raison d'une boiterie depuis 3 mois exacerbée à la fatigue douleur au genou. Genou sp au status. Diagnostic le + vraisemblable :
- a Perthes-Calve
 - b Déchirure du ménisque réduite a la consultation
 - c Osteocondrite disséquante
 - d ...
259. Une Ile pare légèrement obèse se présente à l'hôpital pour des contractions utérines régulières. Son premier enfant pesait 4 kg à la naissance et les examens cliniques et échographiques au cours de la grossesse actuelle parlent en faveur d'un gros bébé. A l'admission, le col utérin est dilaté à 4 cm et la présentation céphalique se trouve à 1 cm au-dessus des épines sciatiques. Quelle mesure vous semble indiquée?
- a l'expectative et l'observation de la progression de l'accouchement
 - b la césarienne afin de réduire le risque de dystocie des épaules
 - c la pelvimétrie radiologique et césarienne en cas de suspicion de bassin rétréci
 - d la stimulation des contractions par syntocinon
 - e l'anesthésie péridurale dans le but d'obtenir un relâchement des muscles du plancher pelvien
260. Anesthésie péridurale chez une femme enceinte de 40 semaines d'aménorrhée, apparition d'une bradycardie fœtale. Quelle est la cause de la bradycardie fœtale la plus probable?
- a décollement placentaire
 - b procidence du cordon
 - c anémie fœtale
 - d Hypotension maternelle
261. Un enfant de 6 ans présente depuis un mois un torticolis. Il n'a pas d'autres plaintes subjectives. Il est afébrile. Pas de notion de trauma. Quel est le diagnostic le plus probable:
- a polyarthrite rhumatoïde
 - b torticolis oculaire
 - c tumeur cérébrale
 - d malformation de la colonne cervicale
 - e problème psychologique
262. Une fille de 2 ans est amenée aux urgences par ses parents. A domicile, elle a présenté un épisode de cyanose avec respiration difficile et hyperthermie aux 4 membres dont elle s'est remise après quelques minutes. Ses parents l'ont trouvée peu réactive pendant les 10 minutes suivantes avant d'être complètement rétablie. Ils signalent qu'hier elle a présenté un rhume avec une fièvre mesurée par sa grand-mère à 39.5°C. Quel est le diagnostic?
- a une crise d'épilepsie
 - b une convulsion fébrile
 - c une hydrocéphalie
 - d une hémorragie intra-crânienne
 - e une méningite
263. Une femme de 29 ans se réveille le matin avec des maux de tête et une chute de la paupière supérieure de l'oeil gauche. Quand elle soulève la paupière elle voit double. Cause la plus probable?
- a tumeur cérébrale
 - b diabète
 - c infection par un virus
 - d myasthénie
 - e anévrisme de l'artère communicante postérieure

Réponses – ordre des questions (n°):

Réponse	FAUX	N°	Question (début de l'intitulé)	page
A		1	Une femme de 28 ans, nullipare, au 15e jour du cycle menstruel, vous consulte pour des	1
A		2	Un garçon de 13 ans obèse souffre de douleurs à la hanche depuis 2 mois. A l'examen, on	1
A		3	Un garçon de 16 ans, en bonne santé habituelle, présente des douleurs périombilicales	1
D		4	Chez un patient de 40 ans, l'hémoglobine a chuté de 14 à 10 g/dl (norme: 13.5-17.5) en	1
D		5	Un homme de 72 ans se plaint d'une douleur intense lors de la déglutition qui dure depuis	1
A		6	Lors d'un examen d'entourage d'une famille, effectué à la suite de la découverte d'un cas	1
C		7	Une fille de 10 ans avec un syndrome de Marfan se plaint subitement de douleur lancinante	1
A		8	Chez un homme de 70 ans, avec une hypertension artérielle asymptomatique de	1
A		9	Une toxicomane de 18 ans (héroïne intraveineuse) vous consulte en raison d'une fièvre à	2
D		10	Une femme âgée de 50 ans vous consulte et montre une lésion réticulaire, blanche et	2
B		11	Un homme de 30 ans est traité depuis 9 mois pour une dépression. L'amélioration de son	2
C		12	Un homme de 45 ans est traité depuis des années pour une polyarthrite chronique. Il est	2
D		13	Un cycliste de 35 ans est mordu à l'avant-bras droit par un renard en zone d'endémie de la	2
D ??		14	Une veuve de 67 ans est hospitalisée pour investigations d'une baisse de l'état général. Le	2
A		15	Depuis 6 mois, une adolescente de 18 ans présente des papules ortiées sur le tégument.	3
C		16	Un garçon de 3 ans est emmené chez le pédiatre car il est fébrile à 39 °C depuis 3 jours et	3
A		17	Un patient de 19 ans se plaint d'une toux non productive depuis deux jours. Chaque accès	3
E		18	Un homme de 76 ans est conduit en ambulance aux urgences en raison de vertiges ne lui	3
D		19	6 mois après avoir été opérée d'une prothèse de la hanche droite, alors que tout allait bien,	3
C		20	Un adolescent de 18 ans souffre depuis 4 ans de douleurs dorsales intermittentes. A	3
E ?		21	Une femme de 29 ans ressentait pendant 3 jours des picotements et de légères douleurs	3
D		22	Une fille de 12 ans développe un état fébrile et un exanthème maculeux partiellement	4
D		23	Un homme de 46 ans, opéré d'une appendicite aiguë, présente au 6e jour post-opératoire	4
C		24	Un homme de 20 ans remarque, après une exposition solaire en été, des macules blanc-	4
D ?		25	Une femme de 57 ans, présentant une surcharge pondérale et souffrant depuis des années	4
C		26	Une femme de 65 ans présente une gonarthrose à droite évoluant depuis plus d'une année.	4
E		27	En taillant une branche d'arbre avec son couteau de poche, un garçon de 12 ans s'entaille la	4
C		28	Une femme de 36 ans a présenté 3 grossesses antérieures dont l'une s'est terminée par	4
C ??	A	29	Après la délivrance, la face maternelle du placenta présente une érosion localisée avec du	5
C		30	Chez un homme de 72 ans, le médecin traitant découvre une anémie ferriprive avec du	5
A		31	Pendant un match de tennis, un fumeur de 47 ans a subi un traumatisme oculaire et a été	5
D		32	Quelques semaines après avoir excisé un naevus naevo-cellulaire on voit apparaître à	5
C		33	Un adolescent âgé de 16 ans présente depuis quelques semaines un larmolement de l'oeil	5
A		34	Un couple a un garçon unique avec une neurofibromatose de Recklinghausen (type 1),	6
E		35	A quelle maladie cutanée correspondent les lésions du	6
B		36	Un agriculteur de 42 ans est amené aux urgences en raison d'une dyspnée qui est apparue	6
A ??		37	5 jours après une résection gastrique, un patient de 67 ans sans problème cardiaque se	6
E		38	Vous suivez une femme de 62 ans, qui a eu une hémicolectomie droite pour un carcinome	6
A ??		39	Un avocat de 63 ans vous consulte pour une faiblesse progressive des deux jambes depuis	6
D		40	Vous désirez déterminer l'efficacité de la prescription d'un médicament anti-dépresseur au	7
A		41	Un nourrisson de 9 mois a un périmètre crânien en dessous du 3e percentile. Le poids et la	7
A		42	Une mère emmène sa fille, âgée de 2 ans, pour le contrôle annuel. A la naissance à terme,	7
---- ??		43	Le médecin traitant d'une femme de 72 ans ayant diagnostiqué chez elle une cataracte	7
+++-		44	Une employée âgée de 34 ans, qui remplit des ampoules pharmaceutiques, se présente à	7
+++		45	Comparé à un groupe d'âge plus jeune, qu'est-ce qui est plus fréquent chez les personnes	7
+ --- ??		46	Au cours du dernier mois dans un village, les valeurs limites d'immission de l'ordonnance	7
++-		47	Dans une étude cas-témoins conduite chez des adultes âgés de 40 à 50 ans, les résultats	7
+++		48	Une femme de 50 ans, en bonne santé jusqu'alors, se plaint de douleurs lombaires basses	8
D		49	Une femme obèse de 78 ans, jusqu'alors en bonne santé, se plaint subitement de crampes	8
B		50	Les résultats d'une étude de cohorte chez les médecins britanniques portant sur	8
B ?	A	51	Une femme de 58 ans, atteinte d'une sténose mitrale et d'une fibrillation auriculaire, se	8
D ?	AB	52	Une femme de 60 ans a présenté à plusieurs reprises des épisodes de brouillard visuel avec	8
B		53	Une petite fille de 2 ans est emmenée aux urgences au début du mois de décembre à 6	8
E		54	L'illustration ci-jointe montre des lésions cutanées observées chez un garçon de 6 mois, par	8
D		55	Un homme de 75 ans se plaint de douleurs sourdes dans l'hémiabdomen droit,	9
D		56	Une jeune femme de 18 ans arrive à l'hôpital avec comme plainte principale des nausées,	9
D		57	A la suite de collisions en série sur l'autoroute, vous êtes engagé comme médecin de triage.	9
B		58	Un garçon de 7 mois qui s'est toujours bien porté semble avoir mal au ventre par épisodes	9
A		59	Un patient de 35 ans en bonne santé habituelle doit subir une cure de hernie inguinale	9
B ?		60	Un fils d'un agriculteur âgé de 9 ans et 3 mois est amené aux urgences par sa mère	10
B		61	Depuis deux ans, un homme de 74 ans présente une arythmie complète sur fibrillation	10
C		62	Une femme de 68 ans (165 cm, 50 kg) se plaint à son médecin de famille d'une faiblesse	10
E		63	Un toxicomane HIV-positif de 35 ans vous consulte pour une tuméfaction latéro-cervicale	10
A		64	Un homme de 20 ans, jusque-là en bonne santé, se présente aux urgences après une party.	10
C		65	Un homme de 46 ans, qui souffre depuis 20 ans d'un diabète insulino-dépendant, se plaint	10
C		66	Une femme de 33 ans se plaint d'une leucorrhée abondante depuis 4 jours, de douleurs	10

C		67	12 jours après son retour de vacances au maroc, un homme de 25 ans présente une	11
B		68	La direction d'une entreprise s'adresse à un médecin du travail parce que les employés ont	11
C		69	Une femme de 32 ans présente autour de la bouche une éruption qui se manifeste par de	11
C		70	Une femme de 34 ans, Rhésus négative présente à la 16e semaine de grossesse un titre	11
B		71	Un homme de 37 ans est victime d'une collision frontale. Il est au volant et souffre de	11
E		72	Un travailleur de 23 ans en excellente santé est envoyé en urgence à l'hôpital avec un	11
C		73	Chez une jeune fille de 10 ans, vous mettez en évidence un souffle entre les	11
D		74	Un homme de 47 ans arrive aux urgences suite à une chute à vélo. Il est agité et dégage un	12
C		75	Une femme de 25 ans se plaint pendant le dernier tiers de sa grossesse d'un prurit. Elle n'a	12
A		76	Un homme de 64 ans est hospitalisé avec une fracture de la jambe gauche. Il est	12
C		77	Malgré une pénicillinothérapie d'une semaine, un homme de 24 ans présente toujours une	12
C		78	Une étude a été conduite en Grande-Bretagne pour déterminer s'il existe une association	13
B		79	Une fillette de 3 ans est amenée aux urgences de pédiatrie à cause de l'apparition de	13
D		80	Un homme de 52 ans est hospitalisé en urgence présentant des vomissements, des	13
B		81	Une femme de 67 ans vient aux urgences en raison de douleurs abdominales diffuses.	13
E		82	La mère d'un garçon de 18 mois vous consulte en urgence. Il y a 2 jours, après une	13
A		83	Un homme a l'âge de 54 ans consulte pour une otalgie droite avec otorrhée purulente. Son	13
C		84	Une fille de 3 ans est fébrile à 38.5 °C. Elle présente un écoulement nasal antérieur muco-	14
E		85	Une fillette de 8 ans souffre de fatigue, d'excrétion d'urine augmentée, de soif accrue et	14
C		86	Un homme de 63 ans est admis aux urgences à cause de douleurs dans l'hypochondre droit.	14
E		87	Malgré d'un diurétique, un homme de 47 ans avec une cirrhose hépatique présente une	14
E		88	Un jeune homme à l'âge de 19 ans s'est blessé l'oreille il y a deux heures avec un coton-	14
C ?	DE	89	Une mère vous amène son fils de 7 ans pour des lésions de grattage de la nuque,	14
B		90	Un homme de 22 ans en bonne santé habituelle présente une fracture ouverte du fémur	14
D		91	Durant un accouchement on constate l'apparition soudaine d'une bradycardie foetale qui	15
B		92	Un germaniste qualifié de 48 ans, spécialiste de la littérature contemporaine, travaille dans	15
C		93	Une fille de 10 ans, pesant environ 40 kg, est amené aux urgences suite à un accident de ski	15
+++		94	Une jeune maman vient vous consulter parce que son fils de 7 semaines pleure très	15
-++		95	Un homme de 48 ans, souffrant d'une cirrhose post-virale C, est admis aux urgences pour	15
--++		96	Un patient âgé de 50 ans (170 cm, 87 kg) consulte son médecin à cause de douleurs très	15
++++		97	Un garçon de 15 ans a eu un accident avec son vélo 3 semaines auparavant. A l'exception	16
---+		98	Un fumeur chronique âgé de 70 ans consulte son médecin traitant en raison d'une	16
-+-		99	Une femme de 60 ans avec une tumeur parotide droite depuis plus de 20 ans développe en	16
---+		100	Une femme de 62 ans, connue pour un trouble bipolaire et traitée par lithium depuis	16
-+-+??	+-	101	Un motocycliste de 22 ans est admis 4 heures après un grave accident. On note une	16
+++		102	Un homme de 47 ans vous consulte pour des douleurs et une tuméfaction sous-	16
C		103	Un patient de 24 ans, connu pour la maladie de Hodgkin, a reçu son quatrième cycle de	16
B ?	A	104	Après un accident, un homme de 43 ans présente un défaut cutané de la taille d'une paume	17
A		105	Dans une population de 11'000 hommes interrogés, 1000 avaient déjà eu un infarctus du	17
C		106	Un informaticien de 45 ans se présente aux urgences avec des douleurs en coup de	17
C		107	Chez un homme de 60 ans vous palpez dans la région sous-mandibulaire un nodule de la	17
B		108	Un jeune homme de 14 ans, accompagné de sa mère, consulte son médecin en raison de	17
A		109	Un travailleur du bâtiment de 35 ans arrive aux urgences après avoir reçu une heure	17
B		110	Un homme de 65 ans se plaint de vertiges intermittents et d'une capacité physique réduite.	17
E		111	Une femme de 32 ans se plaint de douleurs thoraciques lancinantes, pouvant durer jusqu'à	18
A		112	Un adolescent de 20 ans, conducteur et porteur d'une ceinture de sécurité, vient d'avoir un	18
C		113	Un blessé de 20 ans de la voie publique arrive à l'hôpital avec une commotion cérébrale et	18
E		114	Sur la lèvre d'une femme de 32 ans se trouve une lésion superficielle, bien délimitée,	18
B		115	Une femme de 35 ans se plaint depuis environ 3 mois de céphalées récidivantes. Depuis	18
B		116	Lors d'une consultation pour vaccination, la mère d'un nourrisson âgé de 3 mois signale que	18
E		117	Une femme de 75 ans, institutionnalisée pour démence, refuse toute prise alimentaire	19
D		118	Une femme de 62 ans se plaint de douleurs lombaires depuis 3 mois. Une radiographie	19
A		119	Un chef comptable âgé de 58 ans est hospitalisé à cause d'une faiblesse générale. Dans son	19
C		120	7 jours après une anesthésie générale de courte durée, une femme de 42 ans, sans passé	19
C		121	Une fillette de 12 mois présente un gonflement de l'abdomen. Elle a présenté des épisodes	19
A		122	Une femme de 65 ans consulte en urgence pour une tache noire depuis 48 heures devant	20
E		123	Une femme de 72 ans, en bonne santé jusqu'à présent, signale une irrégularité des selles	20
C		124	Lors d'un exercice de gymnastique artistique aux anneaux, une fille de 12 ans rate sa	20
C		125	Une femme de 25 ans, en bonne santé habituelle, se présente en consultation pour	20
C		126	TRAITEMENT - Un ouvrier de chantier, espagnol de 48 ans, habite la Suisse depuis 7 ans. 11	20
D		127	Vous examinez une femme de 50 ans, par ailleurs en bonne santé, du fait d'une amputation	20
C ??	F	128	Chez un homme de 30 ans, héroïnomane connu, un diagnostic de schizophrénie vient	21
A		129	Un essai clinique randomisé compare la Ranitidine au placebo dans la prévention de	21
A		130	Au cours des dernières années, un homme de 52 ans a présenté à plusieurs reprises des	21
E		131	8 mois après une ostéosynthèse pour fracture du fémur, un patient de 30 ans se présente à	21
B		132	Une femme de 42 ans, avec une cholécystolithiase connue, consulte son médecin traitant	21
C		133	Un garçon de 18 mois en bon état général présente depuis quelque semaines un	21
E		134	Une fillette âgée de 3 ans est emmenée aux urgences par sa mère pour une fièvre élevée	21
C		135	Un nourrisson de 6 mois a depuis quelques jours une fièvre de 40 °C. Il est très irritable et	21

D	136	Un bébé âgé de 10 jours est amené chez vous. Il est né 15 jours avant terme avec un poids	22
B	137	Lors d'un effort de démarrage au cours d'un match de tennis, un sportif de 45 ans ressent	22
D	138	Un homme de 73 ans vient à votre consultation accompagné de sa fille. Elle vous signale	22
++-	139	Un garçon de 4 ans respire depuis quelques mois de plus en plus mal par le nez. Les parents	22
+++	140	Une sage-femme vous appelle en urgence auprès d'une patiente de 27 ans qui présente un	22
- - + +	141	Veuillez regarder les deux radiographies ci-jointes d'une fracture de cheville.	22
+++	142	Un homme de 28 ans est victime d'un accident de la circulation. Il subit une collision	23
+-	143	Vous êtes le médecin responsable d'un établissement médico-social. L'infirmière vous	23
A	144	Une ménagère de 32 ans est connue pour une pollinose printanière qu'elle traite par spray	23
A	145	Un homme de 24 ans, toxicomane par voie intraveineuse connu, se plaint d'un état	23
A	146	Une mère a remarqué que son enfant âgé de 3 mois louche. Elle ne peut indiquer	23
E	147	Lors de l'examen médical à la fin de l'école obligatoire, vous trouvez chez une jeune fille	24
D	148	Depuis 3 ans, un adolescent de 21 ans utilise quotidiennement des gouttes	24
C	149	Une lle pare de 22 ans est à la 16e semaine de grossesse. Un an auparavant,	24
B	150	Un homme de 40 ans souffre depuis 2 mois d'une raucité chronique de la voix	24
E	151	Chez un homme âgé de 50 ans, on vient de poser le diagnostic d'une cirrhose éthylique	24
A	152	Un homme de 49 ans vous consulte pour un contrôle général (check-up	24
A	153	Au cours des 10 dernières années, une femme de 80 ans a développé	25
A	154	Un enfant de 2 mois est né prématurément avec un poids de 1.2 kg. Il	25
E	155	Quelle maladie évoque la lésion de la langue	25
A	156	Une fillette de 3 ans est amenée chez le pédiatre avec une haute fièvre apparue	25
E	157	On compare deux programmes de dépistage précoce de l'hypertension: dans	26
B	158	Un garçon de 2 ans présente une toux depuis plusieurs jours avec début	26
C	159	Sans signes précurseurs, une femme de 50 ans remarque un matin au réveil	26
D	160	Une fille de 6 mois est adressée à l'hôpital. Elle présente de la fièvre depuis quelques	26
A	161	Une femme de 25 ans avec des cycles de 40 à 60 jours vous consulte parce qu'elle souhaite	26
B	162	Un homme de 78 ans vous consulte accompagné d'une assistante de vie. Elle raconte	26
D ?	163	Un garçon âgé de 4 ans est amené par sa mère chez le pédiatre à cause d'une boiterie	26
A ?	164	Un homme de 38 ans consulte le médecin traitant et se plaint de problèmes de	27
D	165	Une femme de 28 ans, enceinte à 36 1/7 semaines d'aménorrhée, présente	27
+ - + +	166	Au cours d'un jogging, un homme de 30 ans est mordu par un chien au mollet	27
- + + + ?	167	Un homme de 73 ans vous consulte dans votre cabinet car il a des problèmes	27
++-	168	Chez une fillette de 4 ans qui présente un ictère depuis une semaine, le	27
+++	169	Un homme de 54 ans se plaint de douleurs profondes dans le bas-ventre et	27
+ - - - ?	170	Une femme de 40 ans, fumeuse (10 cigarettes par jour) et cadre dans le domaine	27
E	171	Un nourrisson est né avec la tuméfaction visible sur l'image ci-jointe	27
E	172	Vous recevez à votre cabinet de médecine générale un patient de 55 ans atteint	28
D	173	Des parents amènent leur fils âgé de 4 mois aux urgences de l'hôpital des enfants. Ils	28
E	174	Un homme de 65 ans vous consulte pour un check-up. Il est obèse (BMI 33 kg/	28
D	175	Un enfant issu d'une famille italienne ne prononce pas encore un seul mot à l'âge de 5 ans	28
D	176	Lors d'un cours de répétition, un soldat consulte le médecin à cause d'une	28
C	177	En Suisse, en dehors d'éventuelles poussées épidémiques, on observe environ 100 cas par	29
C	178	Une femme de 32 ans est hospitalisée pour suspicion de grossesse extra-utérine. Une	29
E	179	Une ménagère à l'âge de 38 ans souffre depuis plusieurs semaines d'une inflammation des	29
D	180	Lors d'un don du sang, des antigènes HBs et HBe sont détectés chez un père de famille. Il	29
E	181	Une adolescente âgée de 18 ans constate l'apparition de spotting, malgré la prise régulière	29
A	182	Une jeune fille de 14 ans est amenée chez son médecin de famille car elle se plaint de	29
A	183	A la suite d'une réaction cutanée après une piqûre d'insecte au niveau de la hanche gauche,	29
D	184	Une plaie avec perte cutanée de la surface d'une paume de la main au niveau de la jambe	30
B	185	Dans une publication sur la coqueluche, on trouve l'affirmation suivante: "50 % des	30
B	186	En examinant des apprentis, vous trouvez chez un homme de 17 ans les résultats suivants:	30
A	187	Un de vos patients de longue date vous consulte dans votre cabinet de médecine générale.	30
C	188	Un patient de 32 ans présente depuis plusieurs semaines une rhinorrhée aqueuse	31
A	189	Un homme de 70 ans vous consulte, accompagné d'une assistante de vie. Elle raconte qu'il	31
A ??	190	Un travailleur de 55 ans, employé dans une entreprise chimique, consulte son médecin de	31
A	191	Un adolescent de 15 1/2 ans est adressé à la consultation d'endocrinologie pour petite	31
A	192	Une jeune fille de 13 ans est au 3e percentile pour le poids et la taille. Elle présente une	31
C	193	Une femme de 40 ans a subi une fracture (voir Figure 1) lors d'un accident de la circulation.	31
D	194	On désire étudier l'effet de la fumée pendant la grossesse sur la taille des nouveau-nés. La	32
C	195	Chez un garçon de 5 ans se développent en 2 à 4 semaines une parésie du sixième nerf	32
C	196	Chez un homme de 56 ans, vous investiguez une tuméfaction cervicale gauche indolore:	32
D	197	Un homme de 20 ans se présente avec des lésions palmaires non-prurigineuses (voir	32
E	198	Une femme de 62 ans en bonne santé habituelle se pique la face palmaire de l'index en	33
D	199	Un homme âgé de 35 ans tombe de cheval sans perte de connaissance et présente ensuite	33
D	200	Un homme de 52 ans consulte en raison d'une obstruction nasale unilatérale, d'un	33
B	201	Un homme de 48 ans se plaint d'une protrusion progressive de son oeil droit depuis 4 mois,	33
C	202	Un homme de 34 ans consulte pour une démangeaison dans l'oreille droite. Veuillez	34
A ??	203	Un homme de 44 ans se plaint de voir, depuis la veille, devant son oeil droit une sorte de	34
B	204	Un homme de 23 ans consulte en raison de saignement de nez répitif. La rhinoscopie	34

E	205	Veillez regarder les deux images ci-jointes d'une fracture de l'extrémité proximale de	34
A	206	Une femme de 40 ans présente des hémorragies de privation régulières sous contraception	35
C	207	On se propose d'étudier le rôle du tabagisme en rapport avec le cancer bronchique. C'est	35
C	208	Après quelques jours d'une rhinite séreuse, un nourrisson de 3 mois, n'ayant reçu aucune	35
B	209	Une jeune femme de 16 ans vient à votre consultation et se plaint d'une toux	35
B	210	Une femme obèse de 60 ans, qui s'est toujours sentie en bonne santé, se réveille un matin	35
C	211	Un homme de 40 ans, connu pour une insuffisance rénale chronique avec une diurèse	36
B	212	Un homme de 25 ans est admis aux urgences pour une douleur de la fosse iliaque droite. Le	36
++--	213	Un imprimeur de 25 ans est chasseur dans ses moments de loisir. A la suite d'une mauvaise	36
-+++	214	Dans une entreprise de l'industrie chimique, une étude sur 100 postes de travail devant un	36
+++	215	Un employé de banque de 37 ans a prévu de faire un voyage de 3 semaines dans la forêt	37
--++	216	Un diabétique de 53 ans, connu depuis plus de 10 ans, vous consulte pour une tuméfaction	37
++--	217	Une enquête cas-témoins a donné les résultats suivants:	37
B	218	Chez un malade de 20 ans de petite taille, ayant des diarrhées depuis des semaines,	37
D	219	Un homme de 23 ans a fait une chute importante sur son flanc droit en faisant du surf des	37
A	220	Une femme de 28 ans vous consulte à cause de douleurs récidivantes des grandes et	37
E	221	Une fille, née à terme avec un poids de naissance de 3000 g et une anamnèse périnatale	38
E	222	Chez un garçon de 14 ans on trouve une fièvre et une amygdalite caractérisée par la	38
B ??	223	Une éthilique de 60 ans avait subi, il y a 4 ans, une cholécystectomie pour	38
B	224	Un homme de 60 ans consulte les urgences pour l'apparition subite il y a 2 jours de douleurs	38
C	225	Un petit garçon de 4 ans est amené chez son pédiatre car il refuse de marcher depuis qu'il	38
D	226	Un homme de 55 ans consulte en raison d'une dyspnée croissante et d'une somnolence	38
E	227	Une femme de 40 ans présente depuis une année les symptômes suivants: aménorrhée,	39
A	228	Une fille nouveau-née présente dès les premières heures de vie une hypersialorrhée avec	39
E	229	Un patient de 40 ans, chauffeur de profession, en bonne santé habituelle, consulte son	39
E	230	Un homme de 35 ans consulte l'ophtalmologue et se plaint de voir devant lui "un voile	39
C	231	Une étudiante de 22 ans travaille comme vendeuse dans un magasin de mode. Son temps	39
A	232	A la fin de leur article, les auteurs d'une étude ont indiqué que "77 % des femmes de moins	39
--- +	233	Chez les personnes de plus de 85 ans, les maladies cardio-vasculaires restent la principale	39
D	234	60 secondes après la naissance, un garçon nouveau-né à terme présente les symptômes	40
C	235	Un homme de 45 ans se plaint d'une perte progressive de la vision à l'œil droit.	40
E	236	Une fillette de 5 ans dystrophique et avec un hippocratisme digital, souffre depuis 2 ans	40
B	237	Une femme de 50 ans déclare que depuis 3 mois elle souffre d'une petite lésion persistante	40
E	238	Vous suivez une patiente de 62 ans pour une hypertension bien équilibrée sous diltiazem et	40
E	239	Une fille de 10 mois est amenée à votre cabinet médical car elle vomit et a de la diarrhée	40
D	240	Suite à un accident, un cycliste d'une soixantaine d'années est emmené aux urgences.	40
D	241	Un homme de 64 ans se présente à votre consultation avec un nodule près du nez, qu'il a	40
C	242	Un garçon de 6 ans présente depuis un mois un torticolis. Il n'y a pas de plaintes subjectives	41
D	243	Une campagne visant la promotion de l'activité physique est envisagée dans une grande	41
----	244	Un médecin-assistant se demande s'il peut interrompre la ventilation d'un patient	41
++++	245	Parmi les facteurs prédisposant pour la fracture du col du fémur chez la personne âgée	41
++ - +	246	Une étude a pour but de mesurer la fréquence de la cirrhose hépatique dans la population	41
D	247	Une fillette âgée de 6 ans est emmenée à l'hôpital avec des convulsions généralisées. A	41
+ - + +	248	Une femme de 18 ans a souffert d'une anorexie mentale pendant 6 ans. Elle a eu un IMC	41
D	249	Veillez regarder la figure ci-jointe [manquante]. Quelle est la thérapie de choix pour cette	41
B	250	L'un de vos collègues a été chargé d'enquêter sur l'origine d'une épidémie d'intoxications	42
C	251	Chez un homme de 60 ans, en traitement depuis plusieurs semaines pour des douleurs	42
D	252	Depuis 9 mois, un homme de 30 ans est traité pour une dépression. Son traitement	42
B	253	REINSERTION - Un ouvrier de chantier, espagnol de 48 ans, habite la Suisse depuis 7 ans. 11	42
chgt pillule	254	Femme de 32 ans présente depuis peu des épisodes de vertiges et céphalées	42
e...	255	Un homme de 74 ans se présente aux urgences pour des céphalées modérées et une	42
amitriptyline	256	Un homme de 77 ans se rend aux urgences en raison de douleurs abdominales. Il	42
appendicite	257	Jeune de 16 ans en BSH se présente avec douleurs épigastriques qui peu à peu migrent	43
Perthès-	258	Un enfant de 6 ans est amené par ses parents en raison d'une boiterie depuis 3 mois	43
expectative	259	Une Ile pare légèrement obèse se présente à l'hôpital pour des contractions utérines	43
hypoTA	260	Anesthésie péridurale chez une femme enceinte de 40 semaines d'aménorrhée,	43
tumeur	261	Un enfant de 6 ans présente depuis un mois un torticolis.	43
convulsion	262	Une fille de 2 ans est amenée aux urgences par ses parents. A domicile, elle a présenté un	43
anévrisme	263	Une femme de 29 ans se réveille le matin avec des maux de tête et une chute de	43

CE

Réponses – ordre alphabétique des énoncés :

Réponse	FAUX	N°	Question (début de l'intitulé)	pag
C		67	12 jours après son retour de vacances au maroc, un homme de 25 ans présente une	11
A ??		37	5 jours après une résection gastrique, un patient de 67 ans sans problème cardiaque se plaint	6
D		19	6 mois après avoir été opéré d'une prothèse de la hanche droite, alors que tout allait bien,	3
D		23	60 secondes après la naissance, un garçon nouveau-né à terme présente les symptômes	40
C		12	7 jours après une anesthésie générale de courte durée, une femme de 42 ans, sans passé	19
E		13	8 mois après une ostéosynthèse pour fracture du fémur, un patient de 30 ans se présente à	21
A		23	A la fin de leur article, les auteurs d'une étude ont indiqué que "77 % des femmes de moins de	39
D		57	A la suite de collisions en série sur l'autoroute, vous êtes engagé comme médecin de triage.	9
A		18	A la suite d'une réaction cutanée après une piqûre d'insecte au niveau de la hanche gauche,	29
E		35	A quelle maladie cutanée correspondent les lésions du	6
hypoTA		26	Anesthésie péridurale chez une femme enceinte de 40 semaines d'aménorrhée,	43
C ??	A	29	Après la délivrance, la face maternelle du placenta présente une érosion localisée avec du	5
C		20	Après quelques jours d'une rhinite séreuse, un nourrisson de 3 mois, n'ayant reçu aucune	35
B ?	A	10	Après un accident, un homme de 43 ans présente un défaut cutané de la taille d'une paume	17
A		15	Au cours des 10 dernières années, une femme de 80 ans a développé	25
A		13	Au cours des dernières années, un homme de 52 ans a présenté à plusieurs reprises des crises	21
+ - - - ??		46	Au cours du dernier mois dans un village, les valeurs limites d'immission de l'ordonnance sur	7
+ - + +		16	Au cours d'un jogging, un homme de 30 ans est mordu par un chien au mollet	27
- - - +		23	Chez les personnes de plus de 85 ans, les maladies cardio-vasculaires restent la principale	39
E		22	Chez un garçon de 14 ans on trouve une fièvre et une amygdalite caractérisée par la présence	38
C		19	Chez un garçon de 5 ans se développent en 2 à 4 semaines une paralysie du sixième nerf	32
E		15	Chez un homme âgé de 50 ans, on vient de poser le diagnostic d'une cirrhose éthylique	24
C ??	F	12	Chez un homme de 30 ans, heroinomane connu, un diagnostic de schizophrénie vient d'être	21
C		19	Chez un homme de 56 ans, vous investiguez une tuméfaction cervicale gauche indolore: une	32
C		10	Chez un homme de 60 ans vous palpez dans la région sous-mandibulaire un nodule de la taille	17
C		25	Chez un homme de 60 ans, en traitement depuis plusieurs semaines pour des douleurs	42
A		8	Chez un homme de 70 ans, avec une hypertension artérielle asymptomatique de	1
C		30	Chez un homme de 72 ans, le médecin traitant découvre une anémie ferriprive avec du sang	5
B		21	Chez un malade de 20 ans de petite taille, ayant des diarrhées depuis des semaines,	37
D		4	Chez un patient de 40 ans, l'hémoglobine a chuté de 14 à 10 g/dl (norme: 13.5-17.5) en	1
++-		16	Chez une fillette de 4 ans qui présente un ictère depuis une semaine, le	27
C		73	Chez une jeune fille de 10 ans, vous mettez en évidence un souffle entre les deux omoplates.	11
+++		45	Comparé à un groupe d'âge plus jeune, qu'est-ce qui est plus fréquent chez les personnes de	7
+++		21	Dans une entreprise de l'industrie chimique, une étude sur 100 postes de travail devant un	36
+++		47	Dans une étude cas-témoins conduite chez des adultes âgés de 40 à 50 ans, les résultats	7
A		10	Dans une population de 11'000 hommes interrogés, 1000 avaient déjà eu un infarctus du	17
B		18	Dans une publication sur la coqueluche, on trouve l'affirmation suivante: "50 % des membres	30
D		14	Depuis 3 ans, un adolescent de 21 ans utilise quotidiennement des gouttes vasoconstrictrices	24
A		15	Depuis 6 mois, une adolescente de 18 ans présente des papules ortiées sur le tégument. Elles	3
D		25	Depuis 9 mois, un homme de 30 ans est traité pour une dépression. Son traitement comporte	42
B		61	Depuis deux ans, un homme de 74 ans présente une arythmie complète sur fibrillation	10
D		17	Des parents amènent leur fils âgé de 4 mois aux urgences de l'hôpital des enfants. Ils	28
D		91	Durant un accouchement on constate l'apparition soudaine d'une bradycardie foetale qui	15
B		18	En examinant des apprentis, vous trouvez chez un homme de 17 ans les résultats suivants:	30
C		17	En Suisse, en dehors d'éventuelles poussées épidémiques, on observe environ 100 cas par an	29
E		27	En taillant une branche d'arbre avec son couteau de poche, un garçon de 12 ans s'entaille la	4
chgt pillule		25	Femme de 32 ans présente depuis peu des épisodes de vertiges et céphalées	42
appendicite		25	Jeune de 16 ans en BSH se présente avec douleurs épigastriques qui peu à peu migrent	43
B		25	L'un de vos collègues a été chargé d'enquêter sur l'origine d'une épidémie d'intoxications	42
B		68	La direction d'une entreprise s'adresse à un médecin du travail parce que les employés ont	11
E		82	La mère d'un garçon de 18 mois vous consulte en urgence. Il y a 2 jours, après une	13
- - - - ??		43	Le médecin traitant d'une femme de 72 ans ayant diagnostiqué chez elle une cataracte	7
B		50	Les résultats d'une étude de cohorte chez les médecins britanniques portant sur l'association	8
E		54	L'illustration ci-jointe montre des lésions cutanées observées chez un garçon de 6 mois, par	8
E		14	Lors de l'examen médical à la fin de l'école obligatoire, vous trouvez chez une jeune fille	24
D		17	Lors d'un cours de répétition, un soldat consulte le médecin à cause d'une	28
D		18	Lors d'un don du sang, des antigènes HBs et HBe sont détectés chez un père de famille. Il	29
B		13	Lors d'un effort de démarrage au cours d'un match de tennis, un sportif de 45 ans ressent une	22
A		6	Lors d'un examen d'entourage d'une famille, effectué à la suite de la découverte d'un cas de	1
C		12	Lors d'un exercice de gymnastique artistique aux anneaux, une fille de 12 ans rate sa	20
B		11	Lors d'une consultation pour vaccination, la mère d'un nourrisson âgé de 3 mois signale que	18
E		87	Malgré d'un diurétique, un homme de 47 ans avec une cirrhose hépatique présente une	14
C		77	Malgré une pénicillinothérapie d'une semaine, un homme de 24 ans présente toujours une	12
E		15	On compare deux programmes de dépistage précoce de l'hypertension: dans	26
D		19	On désire étudier l'effet de la fumée pendant la grossesse sur la taille des nouveau-nés. La	32
C		20	On se propose d'étudier le rôle du tabagisme en rapport avec le cancer bronchique. C'est pour	35

++++	24	Parmi les facteurs prédisposant pour la fracture du col du fémur chez la personne âgée	41
A	31	Pendant un match de tennis, un fumeur de 47 ans a subi un traumatisme oculaire et a été	5
E	15	Quelle maladie évoque la lésion de la langue	25
D	32	Quelques semaines après avoir excisé un naevus naevo-cellulaire on voit apparaître à	5
B	25	REINSERTION - Un ouvrier de chantier, espagnol de 48 ans, habite la Suisse depuis 7 ans. 11	42
C	15	Sans signes précurseurs, une femme de 50 ans remarque un matin au réveil	26
D	24	Suite à un accident, un cycliste d'une soixantaine d'années est emmené aux urgences.	40
E	11	Sur la luette d'une femme de 32 ans se trouve une lésion superficielle, bien délimitée, souple à	18
C	12	TRAITEMENT - Un ouvrier de chantier, espagnol de 48 ans, habite la Suisse depuis 7 ans. 11	20
C	33	Un adolescent âgé de 16 ans présente depuis quelques semaines un larmoiement de l'oeil	5
A	19	Un adolescent de 15 1/2 ans est adressé à la consultation d'endocrinologie pour petite taille.	31
C	20	Un adolescent de 18 ans souffre depuis 4 ans de douleurs dorsales intermittentes. A l'examen,	3
A	11	Un adolescent de 20 ans, conducteur et porteur d'une ceinture de sécurité, vient d'avoir un	18
B	36	Un agriculteur de 42 ans est amené aux urgences en raison d'une dyspnée qui est apparue	6
A ??	39	Un avocat de 63 ans vous consulte pour une faiblesse progressive des deux jambes depuis	6
D	13	Un bébé âgé de 10 jours est amené chez vous. Il est né 15 jours avant terme avec un poids de	22
C	11	Un blessé de 20 ans de la voie publique arrive à l'hôpital avec une commotion cérébrale et	18
A	11	Un chef comptable âgé de 58 ans est hospitalisé à cause d'une faiblesse générale. Dans son	19
A	34	Un couple a un garçon unique avec une neurofibromatose de Recklinghausen (type 1),	6
D	13	Un cycliste de 35 ans est mordu à l'avant-bras droit par un renard en zone d'endémie de la	2
A	18	Un de vos patients de longue date vous consulte dans votre cabinet de médecine générale. Il	30
---+	21	Un diabétique de 53 ans, connu depuis plus de 10 ans, vous consulte pour une tuméfaction du	37
+++	21	Un employé de banque de 37 ans a prévu de faire un voyage de 3 semaines dans la forêt	37
A	15	Un enfant de 2 mois est né prématurément avec un poids de 1.2 kg. Il	25
Perthès-	25	Un enfant de 6 ans est amené par ses parents en raison d'une boiterie depuis 3 mois	43
tumeur	26	Un enfant de 6 ans présente depuis un mois un torticolis.	43
D	17	Un enfant issu d'une famille italienne ne prononce pas encore un seul mot à l'âge de 5 ans	28
A	12	Un essai clinique randomisé compare la Ranitidine au placebo dans la prévention de	21
B ?	60	Un fils d'un agriculteur âgé de 9 ans et 3 mois est amené aux urgences par sa mère inquiète,	10
---+	98	Un fumeur chronique âgé de 70 ans consulte son médecin traitant en raison d'une intolérance	16
D ?	16	Un garçon âgé de 4 ans est amené par sa mère chez le pédiatre à cause d'une boiterie	26
A	2	Un garçon de 13 ans obèse souffre de douleurs à la hanche depuis 2 mois. A l'examen, on met	1
++++	97	Un garçon de 15 ans a eu un accident avec son vélo 3 semaines auparavant. A l'exception	16
A	3	Un garçon de 16 ans, en bonne santé habituelle, présente des douleurs périombilicales	1
C	13	Un garçon de 18 mois en bon état général présente depuis quelque semaines un écoulement	21
B	15	Un garçon de 2 ans présente une toux depuis plusieurs jours avec début	26
C	16	Un garçon de 3 ans est emmené chez le pédiatre car il est fébrile à 39 °C depuis 3 jours et	3
---+	13	Un garçon de 4 ans respire depuis quelques mois de plus en plus mal par le nez. Les parents	22
C	24	Un garçon de 6 ans présente depuis un mois un torticolis. Il n'y a pas de plaintes subjectives	41
B	58	Un garçon de 7 mois qui s'est toujours bien porté semble avoir mal au ventre par épisodes	9
B	92	Un germaniste qualifié de 48 ans, spécialiste de la littérature contemporaine, travaille dans	15
A	83	Un homme a l'âge de 54 ans consulte pour une otalgie droite avec otorrhée purulente. Son	13
D	19	Un homme âgé de 35 ans tombe de cheval sans perte de connaissance et présente ensuite	33
C	24	Un homme de 20 ans remarque, après une exposition solaire en été, des macules blanc-	4
D	19	Un homme de 20 ans se présente avec des lésions palmaires non-prurigineuses (voir figure).	32
A	64	Un homme de 20 ans, jusque-là en bonne santé, se présente aux urgences après une party. Il	10
B	90	Un homme de 22 ans en bonne santé habituelle présente une fracture ouverte du fémur droit	14
D	21	Un homme de 23 ans a fait une chute importante sur son flanc droit en faisant du surf des	37
B	20	Un homme de 23 ans consulte en raison de saignement de nez répétitif. La rhinoscopie	34
A	14	Un homme de 24 ans, toxicomane par voie intraveineuse connu, se plaint d'un état subfébrile,	23
B	21	Un homme de 25 ans est admis aux urgences pour une douleur de la fosse iliaque droite. Le	36
+++	14	Un homme de 28 ans est victime d'un accident de la circulation. Il subit une collision frontale	23
B	11	Un homme de 30 ans est traité depuis 9 mois pour une dépression. L'amélioration de son état	2
C	20	Un homme de 34 ans consulte pour une démangeaison dans l'oreille droite. Veuillez regarder	34
E	23	Un homme de 35 ans consulte l'ophtalmologue et se plaint de voir devant lui "un voile	39
B	71	Un homme de 37 ans est victime d'une collision frontale. Il est au volant et souffre de	11
A ?	16	Un homme de 38 ans consulte le médecin traitant et se plaint de problèmes de	27
B	15	Un homme de 40 ans souffre depuis 2 mois d'une raucité chronique de la voix	24
C	21	Un homme de 40 ans, connu pour une insuffisance rénale chronique avec une diurèse	36
A ??	20	Un homme de 44 ans se plaint de voir, depuis la veille, devant son oeil droit une sorte de	34
C	23	Un homme de 45 ans se plaint d'une perte progressive de la vision à l'œil droit.	40
C	12	Un homme de 45 ans est traité depuis des années pour une polyarthrite chronique. Il est	2
D	23	Un homme de 46 ans, opéré d'une appendicite aiguë, présente au 6e jour post-opératoire un	4
C	65	Un homme de 46 ans, qui souffre depuis 20 ans d'un diabète insulino-dépendant, se plaint de	10
D	74	Un homme de 47 ans arrive aux urgences suite à une chute à vélo. Il est agité et dégage un	12
++--	10	Un homme de 47 ans vous consulte pour des douleurs et une tuméfaction sous-mandibulaire	16
B	20	Un homme de 48 ans se plaint d'une protrusion progressive de son oeil droit depuis 4 mois,	33
-++	95	Un homme de 48 ans, souffrant d'une cirrhose post-virale C, est admis aux urgences pour	15
A	15	Un homme de 49 ans vous consulte pour un contrôle général (check-up	24

D		20	Un homme de 52 ans consulte en raison d'une obstruction nasale unilatérale, d'un	33
D		80	Un homme de 52 ans est hospitalisé en urgence présentant des vomissements, des douleurs	13
+++		16	Un homme de 54 ans se plaint de douleurs profondes dans le bas-ventre et	27
D		22	Un homme de 55 ans consulte en raison d'une dyspnée croissante et d'une somnolence	38
B		22	Un homme de 60 ans consulte les urgences pour l'apparition subite il y a 2 jours de douleurs	38
C		86	Un homme de 63 ans est admis aux urgences à cause de douleurs dans l'hypochondre droit. Il	14
A		76	Un homme de 64 ans est hospitalisé avec une fracture de la jambe gauche. Il est parfaitement	12
D		24	Un homme de 64 ans se présente à votre consultation avec un nodule près du nez, qu'il a	40
B		11	Un homme de 65 ans se plaint de vertiges intermittents et d'une capacité physique réduite.	17
E		17	Un homme de 65 ans vous consulte pour un check-up. Il est obèse (BMI 33 kg/	28
A		18	Un homme de 70 ans vous consulte, accompagné d'une assistante de vie. Elle raconte qu'il	31
D		5	Un homme de 72 ans se plaint d'une douleur intense lors de la déglutition qui dure depuis	1
D		13	Un homme de 73 ans vient à votre consultation accompagné de sa fille. Elle vous signale que	22
- + + + ?	++++=3/4ok	16	Un homme de 73 ans vous consulte dans votre cabinet car il a des problèmes	27
e...		25	Un homme de 74 ans se présente aux urgences pour des céphalées modérées et une	42
D		55	Un homme de 75 ans se plaint de douleurs sourdes dans l'hémiabdomen droit, accompagnées	9
E		18	Un homme de 76 ans est conduit en ambulance aux urgences en raison de vertiges ne lui	3
amitriptylin		25	Un homme de 77 ans se rend aux urgences en raison de douleurs abdominales. Il	42
B		16	Un homme de 78 ans vous consulte accompagné d'une assistante de vie. Elle raconte	26
++--		21	Un imprimeur de 25 ans est chasseur dans ses moments de loisir. A la suite d'une mauvaise	36
C		10	Un informaticien de 45 ans se présente aux urgences avec des douleurs en coup de poignard	17
E		88	Un jeune homme à l'âge de 19 ans s'est blessé l'oreille il y a deux heures avec un coton-tige.	14
B		10	Un jeune homme de 14 ans, accompagné de sa mère, consulte son médecin en raison de	17
----		24	Un médecin-assistant se demande s'il peut interrompre la ventilation d'un patient incurable	41
- + - + ? ?	--- =3/4ok	10	Un motocycliste de 22 ans est admis 4 heures après un grave accident. On note une luxation	16
C		13	Un nourrisson de 6 mois a depuis quelques jours une fièvre de 40 °C. Il est très irritable et sa	21
A		41	Un nourrisson de 9 mois a un périmètre crânien en dessous du 3e percentile. Le poids et la	7
E		17	Un nourrisson est né avec la tuméfaction visible sur l'image ci-jointe	27
-- + +		96	Un patient âgé de 50 ans (170 cm, 87 kg) consulte son médecin à cause de douleurs très	15
A		17	Un patient de 19 ans se plaint d'une toux non productive depuis deux jours. Chaque accès de	3
C		10	Un patient de 24 ans, connu pour la maladie de Hodgkin, a reçu son quatrième cycle de	16
C		18	Un patient de 32 ans présente depuis plusieurs semaines une rhinorrhée aqueuse bilatérale,	31
A		59	Un patient de 35 ans en bonne santé habituelle doit subir une cure de hernie inguinale droite	9
E		22	Un patient de 40 ans, chauffeur de profession, en bonne santé habituelle, consulte son	39
C		22	Un petit garçon de 4 ans est amené chez son pédiatre car il refuse de marcher depuis qu'il	38
E		63	Un toxicomane HIV-positif de 35 ans vous consulte pour une tuméfaction latéro-cervicale	10
E		72	Un travailleur de 23 ans en excellente santé est envoyé en urgence à l'hôpital avec un ventre	11
A ??	C	19	Un travailleur de 55 ans, employé dans une entreprise chimique, consulte son médecin de	31
A		10	Un travailleur du bâtiment de 35 ans arrive aux urgences après avoir reçu une heure	17
E		18	Une adolescente âgée de 18 ans constate l'apparition de spotting, malgré la prise régulière	29
D		24	Une campagne visant la promotion de l'activité physique est envisagée dans une grande ville	41
+++		44	Une employée âgée de 34 ans, qui remplit des ampoules pharmaceutiques, se présente à	7
++--		21	Une enquête cas-témoins a donné les résultats suivants:	37
B ??	CE	22	Une éthilique de 60 ans avait subi, il y a 4 ans, une cholécystectomie pour cholécystolithiase.	38
C		78	Une étude a été conduite en Grande-Bretagne pour déterminer s'il existe une association	13
+ + - +		24	Une étude a pour but de mesurer la fréquence de la cirrhose hépatique dans la population	41
C		23	Une étudiante de 22 ans travaille comme vendeuse dans un magasin de mode. Son temps de	39
D		10	Une femme âgée de 50 ans vous consulte et montre une lésion réticulaire, blanche et	2
+ - + +		24	Une femme de 18 ans a souffert d'une anorexie mentale pendant 6 ans. Elle a eu un IMC	41
A		16	Une femme de 25 ans avec des cycles de 40 à 60 jours vous consulte parce qu'elle souhaite	26
C		12	Une femme de 25 ans, en bonne santé habituelle, se présente en consultation pour	20
C		75	Une femme de 25 ans se plaint pendant le dernier tiers de sa grossesse d'un prurit. Elle n'a	12
A		22	Une femme de 28 ans vous consulte à cause de douleurs récidivantes des grandes et petites	37
D		16	Une femme de 28 ans, enceinte à 36 1/7 semaines d'aménorrhée, présente	27
A		1	Une femme de 28 ans, nullipare, au 15e jour du cycle menstruel, vous consulte pour des	1
E ?		21	Une femme de 29 ans ressentait pendant 3 jours des picotements et de légères douleurs dans	3
anévrisme		26	Une femme de 29 ans se réveille le matin avec des maux de tête et une chute de	43
C		17	Une femme de 32 ans est hospitalisée pour suspicion de grossesse extra-utérine. Une	29
C		69	Une femme de 32 ans présente autour de la bouche une éruption qui se manifeste par de	11
E		11	Une femme de 32 ans se plaint de douleurs thoraciques lancinantes, pouvant durer jusqu'à	18
C		66	Une femme de 33 ans se plaint d'une leucorrhée abondante depuis 4 jours, de douleurs	10
C		70	Une femme de 34 ans, Rhésus négative présente à la 16e semaine de grossesse un titre	11
B		11	Une femme de 35 ans se plaint depuis environ 3 mois de céphalées récidivantes. Depuis	18
C		28	Une femme de 36 ans a présenté 3 grossesses antérieures dont l'une s'est terminée par une	4
C		19	Une femme de 40 ans a subi une fracture (voir Figure 1) lors d'un accident de la circulation.	31
A		20	Une femme de 40 ans présente des hémorragies de privation régulières sous contraception	35
E		22	Une femme de 40 ans présente depuis une année les symptômes suivants: aménorrhée,	39
+ - + - ?	--+ =	17	Une femme de 40 ans, fumeuse (10 cigarettes par jour) et cadre dans le domaine	27
B		13	Une femme de 42 ans, avec une cholécystolithiase connue, consulte son médecin traitant	21

B		23	Une femme de 50 ans déclare que depuis 3 mois elle souffre d'une petite lésion persistante	40
+++-		48	Une femme de 50 ans, en bonne santé jusqu'alors, se plaint de douleurs lombaires basses	8
D ?		25	Une femme de 57 ans, présentant une surcharge pondérale et souffrant depuis des années	4
B ?	A	51	Une femme de 58 ans, atteinte d'une sténose mitrale et d'une fibrillation auriculaire, se plaint	8
D ?	AB	52	Une femme de 60 ans a présenté à plusieurs reprises des épisodes de brouillard visuel avec	8
- + - -		99	Une femme de 60 ans avec une tumeur parotide droite depuis plus de 20 ans développe en	16
E		19	Une femme de 62 ans en bonne santé habituelle se pique la face palmaire de l'index en	33
D		11	Une femme de 62 ans se plaint de douleurs lombaires depuis 3 mois. Une radiographie	19
---+		10	Une femme de 62 ans, connue pour un trouble bipolaire et traitée par lithium depuis plusieurs	16
A		12	Une femme de 65 ans consulte en urgence pour une tache noire depuis 48 heures devant	20
C		26	Une femme de 65 ans présente une gonarthrose à droite évoluant depuis plus d'une année.	4
B		81	Une femme de 67 ans vient aux urgences en raison de douleurs abdominales diffuses.	13
C		62	Une femme de 68 ans (165 cm, 50 kg) se plaint à son médecin de famille d'une faiblesse	10
E		12	Une femme de 72 ans, en bonne santé jusqu'à présent, signale une irrégularité des selles en	20
E		11	Une femme de 75 ans, institutionnalisée pour démence, refuse toute prise alimentaire depuis	19
B		21	Une femme obèse de 60 ans, qui s'est toujours sentie en bonne santé, se réveille un matin tôt	35
D		49	Une femme obèse de 78 ans, jusqu'alors en bonne santé, se plaint subitement de crampes	8
C		7	Une fille de 10 ans avec un syndrome de Marfan se plaint subitement de douleur lancinante à	1
C		93	Une fille de 10 ans, pesant environ 40 kg, est amené aux urgences suite à un accident de ski	15
E		23	Une fille de 10 mois est amenée à votre cabinet médical car elle vomit et a de la diarrhée	40
D		22	Une fille de 12 ans développe un état fébrile et un exanthème maculeux partiellement	4
convulsion		26	Une fille de 2 ans est amenée aux urgences par ses parents. A domicile, elle a présenté un	43
C		84	Une fille de 3 ans est fébrile à 38.5 °C. Elle présente un écoulement nasal antérieur muco-	14
D		16	Une fille de 6 mois est adressée à l'hôpital. Elle présente de la fièvre depuis quelques	26
A		22	Une fille nouveau-née présente dès les premières heures de vie une hypersialorrhée avec de la	39
E		22	Une fille, née à terme avec un poids de naissance de 3000 g et une anamnèse périnatale sans	38
E		13	Une fillette âgée de 3 ans est emmenée aux urgences par sa mère pour une fièvre élevée	21
D		24	Une fillette âgée de 6 ans est emmenée à l'hôpital avec des convulsions généralisées. A	41
C		12	Une fillette de 12 mois présente un gonflement de l'abdomen. Elle a présenté des épisodes	19
B		79	Une fillette de 3 ans est amenée aux urgences de pédiatrie à cause de l'apparition de petites	13
A		15	Une fillette de 3 ans est amenée chez le pédiatre avec une haute fièvre apparue	25
E		23	Une fillette de 5 ans dystrophique et avec un hippocratisme digital, souffre depuis 2 ans d'une	40
E		85	Une fillette de 8 ans souffre de fatigue, d'excrétion d'urine augmentée, de soif accrue et d'une	14
C		14	Une lle pare de 22 ans est à la 16e semaine de grossesse. Un an auparavant,	24
expectative		25	Une lle pare légèrement obèse se présente à l'hôpital pour des contractions utérines	43
B		20	Une jeune femme de 16 ans vient à votre consultation et se plaint d'une toux principalement	35
D		56	Une jeune femme de 18 ans arrive à l'hôpital avec comme plainte principale des nausées, des	9
A		19	Une jeune fille de 13 ans est au 3e percentile pour le poids et la taille. Elle présente une	31
A		18	Une jeune fille de 14 ans est amenée chez son médecin de famille car elle se plaint de fatigue	29
+++		94	Une jeune maman vient vous consulter parce que son fils de 7 semaines pleure très souvent.	15
E		17	Une ménagère à l'âge de 38 ans souffre depuis plusieurs semaines d'une inflammation des	29
A		14	Une ménagère de 32 ans est connue pour une pollinose printanière qu'elle traite par spray de	23
A		14	Une mère a remarqué que son enfant âgé de 3 mois louche. Elle ne peut indiquer	23
A		42	Une mère emmène sa fille, âgée de 2 ans, pour le contrôle annuel. A la naissance à terme, elle	7
C ?	DE	89	Une mère vous amène son fils de 7 ans pour des lésions de grattage de la nuque,	14
B		53	Une petite fille de 2 ans est emmenée aux urgences au début du mois de décembre à 6 heures	8
D		18	Une plaie avec perte cutanée de la surface d'une paume de la main au niveau de la jambe	30
+++		14	Une sage-femme vous appelle en urgence auprès d'une patiente de 27 ans qui présente un	22
A		9	Une toxicomane de 18 ans (héroïne intraveineuse) vous consulte en raison d'une fièvre à	2
D ??		14	Une veuve de 67 ans est hospitalisée pour investigations d'une baisse de l'état général. Le	2
D		24	Veillez regarder la figure ci-jointe [manquante]. Quelle est la thérapie de choix pour cette	41
- - + +		14	Veillez regarder les deux radiographies ci-jointes d'une fracture de cheville.	22
E		20	Veillez regarder les deux images ci-jointes d'une fracture de l'extrémité proximale de	34
D		40	Vous désirez déterminer l'efficacité de la prescription d'un médicament anti-dépresseur au	7
+-		14	Vous êtes le médecin responsable d'un établissement médico-social. L'infirmière vous informe	23
D		12	Vous examinez une femme de 50 ans, par ailleurs en bonne santé, du fait d'une amputation	20
E		17	Vous recevez à votre cabinet de médecine générale un patient de 55 ans atteint	28
E		38	Vous suivez une femme de 62 ans, qui a eu une hémicolectomie droite pour un carcinome	6
E		23	Vous suivez une patiente de 62 ans pour une hypertension bien équilibrée sous diltiazem et un	40